

CERTIFICA,

Que en el marco del Proceso Selectivo aprobado por Resolución de 23 de diciembre de 2022, por la que se convocan los procesos selectivos extraordinarios de estabilización del empleo temporal y los procesos selectivos ordinarios de acceso a la condición de personal ESTATUTARIO fijo en plazas básicas vacantes de diversas categorías sanitarias y de gestión y servicios, en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud , BOC nº 255, de 29 de diciembre de 2022

Se ha reunido el Tribunal Coordinador en diferentes sesiones y de conformidad con lo dispuesto en la Base novena punto 3, de las Bases de referencia, ha aprobado el repertorio provisional de preguntas de la Médica/o de Urgencia Hospitalaria y otorgado 3 días hábiles para impugnaciones.

Finalizada la fase anterior, prevista para las impugnaciones, se han adoptado los acuerdos que constan en acta, por lo que procede elevar, mediante este certificado, la redacción de las preguntas definitivas a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud para su aprobación y si procede su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (Base novena 3, de la convocatoria).

A este Certificado se adjunta como Anexo la Redacción definitiva de las preguntas y respuestas definitivas, que conforme dispone la Base novena 3, se ha de publicar en la página web del Servicio Canario de la Salud.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

1. ¿Qué artículo de la Constitución reconoce expresamente el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud?:

- A) El artículo 41.
- B) El artículo 42.
- C) El artículo 43.
- D) El artículo 44.

Respuesta Correcta: C

2. ¿Quiénes deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público, o vinculados a él, de sus derechos y deberes?:

- A) Las Leyes.
- B) Los Poderes Públicos.
- C) La Ley General de Sanidad.
- D) El Sistema Nacional de Salud.

Respuesta Correcta: B

3. De las siguientes afirmaciones, señalar cuál de ellas es falsa:

- A) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos.
- B) El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.
- C) El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación en Sanidad.
- D) El respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social.

Respuesta Correcta: C

4. El catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud tiene por objeto:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención.
- B) Garantizar la calidad de las prestaciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención.
- C) Garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención basada en los principios de igualdad, equidad, notoriedad y relevancia en el nivel adecuado de atención.
- D) Todas las respuestas son correctas.

Respuesta Correcta: A

5. ¿Cuándo fue aprobada la Ley General de Sanidad?:

- A) Por la Ley 14/1986, de 25 de abril.
- B) Por la Ley 14/1989, de 12 de mayo.
- C) Por la Ley 14/1986, de 12 de mayo.
- D) Por la Ley 14/1989, de 25 de abril.

Respuesta Correcta: A

6. ¿Quiénes según la Ley General de Sanidad, los que serán titulares del derecho a la protección de la salud?:

- A) Todos los españoles.
- B) Todas las personas que tengan establecida su residencia en la península
- C) Todas las personas que tengan establecida su residencia en España.
- D) Todas las personas que tengan establecida su residencia en territorio nacional.

Respuesta Correcta: D

7. ¿Cuál es, según la Ley General de Sanidad, la pieza básica de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas?

- A) Las Áreas de Salud.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Las Zonas Básicas de Salud.
- C) Las Zonas y Áreas Básicas de Salud.
- D) Las Gerencias de los Servicios de Salud.

Respuesta Correcta: A

8. En toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente se necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado. Este consentimiento se prestará por escrito en el siguiente caso:

- A) Intervención quirúrgica.
- B) Procedimientos terapéuticos invasores.
- C) Procedimientos diagnósticos invasores.
- D) En los tres casos anteriores es preciso la autorización escrita.

Respuesta Correcta: D

9. ¿Quién regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona?:

- A) Cada Servicio de Salud.
- B) El Sistema Nacional de Salud.
- C) La Ley General de Sanidad.
- D) El Ministerio de Sanidad y Consumo.

Respuesta Correcta: A

10. ¿Cuál es el objeto de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias?:

- A) La creación y organización del Servicio Canario de la Salud
- B) Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) La regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución
- D) Esta ley regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general de la formación de los profesionales, al desarrollo profesional de éstos y a su participación en la planificación y ordenación de las profesiones sanitarias.

Respuesta Correcta: D

11. La Ley de Ordenación de las profesiones Sanitaria es la:

- A) Ley 11/1994, de 26 de junio.
- B) Ley 8/2003, de 26 de julio.
- C) Ley 44/2003, de 21 de noviembre.
- D) Ninguna es correcta.

Respuesta Correcta: C

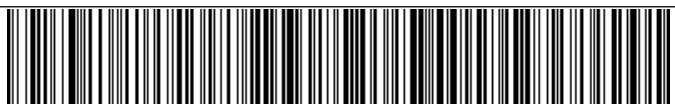
12. Las disposiciones de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias son aplicables:

- A) Solamente a las profesiones que tengan que ver con el ámbito público de cualquiera de las profesiones sanitarias.
- B) Tanto si la profesión se ejerce en los servicios sanitarios públicos como en el ámbito de la sanidad privada
- C) En todo el territorio Nacional
- D) Solo si la profesión se ejerce en el ámbito de la sanidad privada.

Respuesta Correcta: B

13. De conformidad con la Ley de Ordenación de las profesiones Sanitaria, la formación especializada en ciencias de la Salud:

- A) Es una formación reglada y de carácter no oficial.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Es una formación reglada y de carácter oficial.
- C) En una formación reglamentada y de carácter no oficial.
- D) Es una formación reglamentada y de carácter oficial.

Respuesta Correcta: B

14. De conformidad con la Ley de Ordenación de las profesiones Sanitaria ¿Cada cuánto tiempo los centros sanitarios revisaran que los profesionales sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos necesarios para ejercer la profesión?

- A) Cada año como mínimo
- B) Cada cuatro años como mínimo
- C) Cada diez años como mínimo
- D) Cada tres años como mínimo

Respuesta Correcta: D

15. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho colectivo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:

- A) La movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, en la forma en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables
- B) La negociación colectiva, representación y participación en la determinación de las condiciones de trabajo
- C) Disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad laboral
- D) Reunión.

Respuesta Correcta: A

16. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) El procedimiento disciplinario responderá a los principios de tipicidad, eficacia y proporcionalidad.
- B) El régimen disciplinario responderá a los principios de tipicidad, eficacia y proporcionalidad en todo el Sistema Nacional de Salud, y su procedimiento, a los de inmediatez, economía procesal y pleno respeto de los derechos y garantías correspondientes.
- C) El régimen disciplinario responderá a los principios de eficacia y proporcionalidad en todo el Sistema Nacional de Salud, y su procedimiento, a los de inmediatez, economía procesal y pleno respeto de los derechos y garantías correspondientes.
- D) El régimen disciplinario responderá a los principios de tipicidad, eficacia y proporcionalidad en todo el Sistema Nacional de Salud, y su procedimiento, a los de economía procesal y pleno respeto de los derechos y garantías correspondientes.

Respuesta Correcta: B

17. Señale la respuesta incorrecta:

- A) El apercibimiento será siempre por escrito, y sólo se impondrá por faltas leves.
- B) La suspensión de funciones, cuando se imponga por faltas muy graves, no podrá superar los seis años ni será inferior a los dos años.
- C) Cuando la suspensión provisional se produzca como consecuencia de expediente disciplinario, no podrá exceder de seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado.
- D) Para la imposición de sanciones por faltas leves será preceptiva la previa instrucción del procedimiento.

Respuesta Correcta: D

18. Señale la Respuesta Correcta:

- A) Resultará de aplicación al personal estatutario el régimen de incompatibilidades establecido con carácter general para los funcionarios públicos, con las normas específicas que se determinan en esta ley.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) La percepción de pensión de jubilación parcial será incompatible con las retribuciones derivadas de una actividad a tiempo parcial.
- C) No resultará de aplicación al personal estatutario el régimen de incompatibilidades establecido con carácter general para los funcionarios públicos.
- D) Las retribuciones del personal emérito, sumadas a su pensión de jubilación, podrán superar las retribuciones que el interesado percibía antes de su jubilación, consideradas, todas ellas, en cómputo anual.

Respuesta Correcta: A

19. De los siguientes principios rectores cual NO se contempla en la ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:

- A) Consagrar derechos de las personas víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.
- B) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social.
- C) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.
- D) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género.

Respuesta Correcta: A

20. ¿A quién debe estar dirigido el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género con carácter permanente, conforme a la ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?

- A) Debe estar dirigido a mujeres.
- B) Debe estar dirigido tanto a las mujeres como a sus hijas e hijos.
- C) Debe estar dirigido tanto a hombres como a mujeres.
- D) Debe estar dirigido a las personas.

Respuesta Correcta: C

21. ¿Por qué órgano debe estar controlado el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género con carácter permanente, conforme a la ley





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?

- A) Por una Comisión de amplia participación.
- B) Por un Comité de expertas.
- C) Por una Comisión de diez personas.
- D) Por una Comisión de mujeres.

Respuesta Correcta: A

22. ¿Qué servicios se deben reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?

- A) Se deben reforzar los centros sanitarios, de atención ciudadana, de emergencia policial, de apoyo y de recuperación integral de la mujer.
- B) Se deben reforzar los servicios comunitarios, de atención telefónica, de emergencia sanitaria, de apoyo emocional y de recuperación integral.
- C) Se deben reforzar los servicios sociales autonómicos, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral.
- D) Se deben reforzar los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral.

Respuesta Correcta: D

23. En relación con la formación de profesionales que intervienen en situaciones de violencia de género, ¿cuál es uno de los elementos clave que debe contener el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género según la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?

- A) La inclusión de un programa de formación continua y reciclaje.
- B) La participación activa de las víctimas en el diseño de los programas de formación.
- C) La creación de una Comisión para supervisar la ejecución del programa de formación.
- D) La promoción de la capacitación en primeros auxilios para situaciones de violencia de género.

Respuesta Correcta: A

24. ¿Cómo deben ser realizadas las campañas de información y sensibilización contra la violencia de género, según la Ley 1/2004 de Medidas de Protección





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Integral contra la Violencia de Género, para garantizar el acceso a las mismas de las personas con discapacidad?

- A) Las campañas deben ser adaptadas a los distintos tipos de discapacidad.
- B) Las campañas deben estar disponibles en formatos digitales accesibles.
- C) Las campañas deben contar con intérpretes de lenguaje de signos.
- D) Las campañas deben ser traducidas a múltiples idiomas.

Respuesta Correcta: B

25. Según la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿qué aspecto es fundamental para el programa de formación complementaria y reciclaje de los profesionales que intervienen en situaciones de violencia de género?

- A) La actualización constante de los protocolos de actuación.
- B) La participación exclusiva de profesionales con experiencia previa en casos de violencia de género.
- C) La inclusión de perspectiva de género en todos los ámbitos de formación.
- D) La realización de evaluaciones de desempeño semestrales.

Respuesta Correcta: C

26. ¿Quiénes están sujetos a las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en los términos de su ámbito de aplicación?

- A) Únicamente las personas físicas que sean ciudadanas españolas.
- B) Toda persona, ya sea física o jurídica, que actúe en el territorio español, independientemente de su nacionalidad, domicilio o residencia.
- C) Solo las instituciones gubernamentales en territorio español.
- D) Las personas físicas o jurídicas con nacionalidad española y domicilio en territorio español.

Respuesta Correcta: B

27. Según el artículo 19 bis de la Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿qué tipo de atención sanitaria se garantiza a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas?

- A) Atención sanitaria básica.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Atención sanitaria con especial atención psicológica y psiquiátrica, así como seguimiento de su estado de salud hasta su total recuperación.
- C) Atención sanitaria solo para las secuelas físicas de la violencia.
- D) Atención sanitaria especializada en enfermedades crónicas.

Respuesta Correcta: B

28. ¿Cuál es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

- A) Ley 31/1995, de 6 de noviembre.
- B) Ley 13/1995, de 8 de noviembre.
- C) Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
- D) Ley 31/1996, de 6 noviembre.

Respuesta Correcta: C

29. ¿Qué artículo de la Constitución Española configura el soporte básico en que se asienta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

- A) Artículo 40.2
- B) Artículo 43.1
- C) Artículo 42.1
- D) Artículo 41.2

Respuesta Correcta: A

30. En relación al artículo 40.2 de la Constitución Española, señala la afirmación correcta:

- A) Encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
- B) Este mandato conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores.
- C) Encuentra en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales su pilar fundamental.
- D) Todas las respuestas son correctas.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

31. Señala cuál es una de las principales novedades de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:

- A) Solamente posee carácter de legislación laboral.
- B) Se aplicará también en el ámbito de las Administraciones públicas.
- C) No constituye norma básica del régimen estatutario de los funcionarios públicos.
- D) Solamente se aplicará en el ámbito de las Administraciones privadas.

Respuesta Correcta: B

32. Señala qué capítulo de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales regula el conjunto de derechos y obligaciones:

- A) Capítulo I.
- B) Capítulo V.
- C) Capítulo III.
- D) Capítulo II.

Respuesta Correcta: C

33. Señala qué capítulo de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales regula los derechos de consulta y participación de los trabajadores:

- A) Capítulo V.
- B) Capítulo I.
- C) Capítulo II.
- D) Capítulo IV.

Respuesta Correcta: A

34. En relación a los derechos de consulta y participación de los trabajadores, según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, señala la respuesta INCORRECTA:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) La Ley atribuye a los Delegados de Prevención el ejercicio de las funciones especializadas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
- B) Dichos derechos tienen que ver con las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo.
- C) Junto a ello, el Comité de Seguridad y Salud, se configura como el órgano de encuentro entre representantes y empresario.
- D) Todas son incorrectas.

Respuesta Correcta: D

35. Señale qué artículos comprenden el Capítulo III de Derechos y Obligaciones de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:

- A) Del artículo 14 al artículo 29.
- B) Del artículo 13 al artículo 29.
- C) Del artículo 14 al artículo 28.
- D) Del artículo 31 al artículo 40.

Respuesta Correcta: A

36. Señale qué artículos comprenden el Capítulo V de derechos de consulta y participación de los trabajadores de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:

- A) Del artículo 14 al artículo 29.
- B) Del artículo 13 al artículo 29.
- C) Del artículo 31 al artículo 40.
- D) Del artículo 33 al artículo 40.

Respuesta Correcta: D

37. El reglamento (UE) 2016/679 comprende un total de:

- A) 173 artículos.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) 113 artículos.
- C) 99 artículos.
- D) 99 considerandos.

Respuesta Correcta: C

38. El Reglamento (UE)2016/679 NO se aplicará:

- A) A las actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.
- B) A la actividad de las autoridades con fines de protección de delitos.
- C) Al tratamiento de datos por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
- D) Entre otros, en ninguno de los supuestos que se indica.

Respuesta Correcta: D

39. ¿Cuál es la duración del deber de mantener el “Secreto Profesional”?

- A) 1 año.
- B) Permanente.
- C) No se establece límite en la legislación.
- D) 5 años.

Respuesta Correcta: B

40. ¿A partir de qué edad una persona podrá consentir por si mismo el tratamiento de sus datos personales?

- A) 14 años.
- B) 18 años.
- C) 21 años.
- D) 16 años.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

41. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorada por un Consejo Consultivo compuesto, entre otros, por:

- A) Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados.
- B) Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial.
- C) Un representante de las organizaciones que agrupan a los Consejos Generales, Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal de las diferentes profesiones colegiadas, propuesto por el Ministro de Justicia.
- D) Todos los anteriores representantes están incluidos en el Consejo Consultivo.

Respuesta Correcta: D

42. El profesional sanitario puede romper el secreto profesional:

- A) Nunca y bajo ninguna circunstancia.
- B) Cuando la situación clínica de un paciente pueda afectar a su compañero de habitación.
- C) En cuanto se presente la ocasión.
- D) Ante requerimiento judicial.

Respuesta Correcta: D

43. En cuanto al consentimiento, se subraya la necesidad de que, en los supuestos que sean necesarios, este consentimiento se entienda como una manifestación de voluntad prestada de forma:

- A) Libre, específica, informada y en una declaración sin lugar a dudas.
- B) Libre, específica, informada, inequívoca y en una declaración o una clara acción afirmativa.
- C) Libre, concreta, informada, inequívoca y en una declaración o una clara acción negativa.
- D) Libre, específica, concreta, inequívoca y en una declaración o una clara afirmación afirmativa.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: B

44. Se entenderá por “toda información sobre una persona física identificada o identificable”:

- A) Tratamiento.
- B) Elaboración de perfiles.
- C) Datos personales.
- D) Limitación del tratamiento.

Respuesta Correcta: C

45. Los datos personales deben ser:

- A) Tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado.
- B) Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.
- C) Tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.
- D) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

Respuesta Correcta: D

46. ¿Cuál es la principal recomendación para el manejo de la trombosis coronaria durante la reanimación cardiopulmonar (RCP)?

- A) Realizar fibrinólisis inmediata
- B) Realizar angioplastia coronaria percutánea
- C) No realizar ninguna intervención durante la RCP
- D) Administrar anticoagulantes parenterales

Respuesta Correcta: C

47. ¿Cuál es la maniobra inicial recomendada para tratar la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en un adulto consciente?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Compresiones abdominales
- B) Maniobra de Heimlich
- C) Ventilación con bolsa-mascarilla
- D) Realizar intubación endotraqueal

Respuesta Correcta: B

48. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la reanimación cardiopulmonar (RCP) en una mujer embarazada que sufre un paro cardíaco?

- A) Realizar RCP con las mismas técnicas que en una persona no embarazada
- B) Realizar únicamente compresiones torácicas sin ventilación
- C) Realizar únicamente ventilación sin compresiones torácicas
- D) Realizar cesárea de emergencia inmediata

Respuesta Correcta: A

49. ¿Cuál es el enfoque recomendado para el manejo de la vía aérea después del retorno de la circulación espontánea durante la reanimación cardiopulmonar (RCP)?

- A) Realizar intubación endotraqueal en todos los casos
- B) Usar una mascarilla con reservorio de oxígeno
- C) Realizar ventilación con bolsa-mascarilla eficaz
- D) No realizar ninguna intervención en la vía aérea

Respuesta Correcta: C

50. ¿Cuál de las siguientes opciones es un criterio clave para la donación de órganos después de una parada cardíaca?

- A) Edad del donante menor de 50 años
- B) Ausencia de enfermedades crónicas en el donante
- C) Tiempo de parada cardíaca inferior a 20 minutos
- D) Evaluación adecuada y descarte de contraindicaciones para la donación

Respuesta Correcta: D





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

51. ¿Cuál es la recomendación principal para el manejo de la vía aérea en un paciente embarazado después del retorno de la circulación espontánea durante la reanimación cardiopulmonar (RCP)?

- A) Realizar intubación endotraqueal de forma inmediata
- B) Usar una mascarilla con reservorio de oxígeno
- C) Realizar ventilación con bolsa-mascarilla con maniobras de hiperinsuflación
- D) No realizar ninguna intervención en la vía aérea y observar al paciente

Respuesta Correcta: B

52. ¿Cuál es la principal recomendación para el manejo de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en un adulto inconsciente durante la reanimación cardiopulmonar (RCP)?

- A) Realizar compresiones abdominales de forma inmediata
- B) Realizar intubación endotraqueal sin demora
- C) Realizar ventilación con bolsa-mascarilla con maniobras de hiperinsuflación
- D) Realizar compresiones torácicas y, si es visible, extraer el cuerpo extraño con pinzas

Respuesta Correcta: D

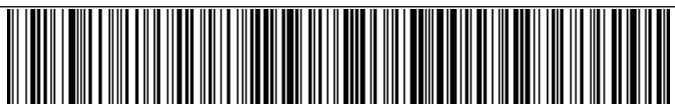
53. ¿Cuál es la recomendación principal para la secuencia de pasos en la reanimación neonatal según las Directrices del Consejo Europeo de Reanimación 2021 Resumen ejecutivo?

- A) Ventilación, masaje cardíaco, administración de adrenalina
- B) Masaje cardíaco, administración de adrenalina, ventilación
- C) Ventilación, administración de adrenalina, masaje cardíaco eficaz
- D) Masaje cardíaco, ventilación, administración de adrenalina

Respuesta Correcta: C

54. ¿Cuál es la recomendación del Consejo Europeo de Reanimación 2021 en cuanto a la donación de órganos en el contexto de la reanimación?

- A) Priorizar la donación de órganos sobre la reanimación del paciente





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Realizar pruebas de compatibilidad inmediatas en todos los pacientes en paro cardiorrespiratorio.
- C) Considerar la posibilidad de donación de órganos en casos seleccionados y en coordinación con los equipos especializados.
- D) Suspender la reanimación en pacientes potenciales para donación de órganos.

Respuesta Correcta: C

55. ¿Cuál es la recomendación principal para el tratamiento europeo de las heridas torácicas abiertas según las Directrices del Consejo de Reanimación 2021 Resumen ejecutivo?

- A) Realizar una sutura inmediata de la herida
- B) Aplicar una venda compresiva sobre la herida
- C) Usar un apósito estéril y sellar la herida herméticamente
- D) No realizar ninguna intervención directa en la herida, solo cubrirla con un apósito

Respuesta Correcta: C

56. ¿Cuál es la recomendación principal sobre el uso de torniquetes para hemorragias externas mortales según las Directrices del Consejo Europeo de Reanimación 2021 Resumen ejecutivo?

- A) Utilizar un torniquete solo como último recurso
- B) Aplicar un torniquete de forma inmediata en todas las hemorragias
- C) No utilizar torniquetes, sino aplicar presión directa en la herida
- D) Utilizar un torniquete solo en casos de hemorragias arteriales severas

Respuesta Correcta: D

57. ¿Cuál es la recomendación principal para el enderezamiento de una fractura angulada según las Directrices del Consejo Europeo de Reanimación 2021 Resumen ejecutivo?

- A) Realizar una reducción cerrada de la fractura utilizando técnicas manuales
- B) Aplicar tracción continua sobre la extremidad afectada para alinear la fractura
- C) Inmovilizar la extremidad en la posición en la que se encuentra sin intentar enderezar la fractura





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Realizar una reducción abierta de la fractura utilizando dispositivos ortopédicos

Respuesta Correcta: C

58. ¿Cuál es la recomendación principal para el transporte de un diente avulsionado según las Directrices del Consejo Europeo de Reanimación 2021

Resumen ejecutivo?

- A) Colocar el diente en un vaso de agua hasta llegar al dentista
- B) Envolver el diente en un pañuelo de papel húmedo y llevar al dentista
- C) Colocar el diente nuevamente en su lugar y mantenerlo en posición durante el transporte
- D) No realizar ninguna acción en el diente y llevar al dentista de inmediato

Respuesta Correcta: C

59. ¿Cuál es la recomendación principal para el manejo inicial de una fractura de pelvis?

- A) Inmovilizar la pelvis con una férula rígida de inmediato
- B) Realizar tracción continua para alinear la fractura de pelvis
- C) Evaluar y controlar las hemorragias externas de forma prioritaria
- D) Administrar analgésicos intravenosos para aliviar el dolor

Respuesta Correcta: C

60. ¿Cuál es la recomendación principal del paciente para el transporte de un con fractura de pelvis?

- A) Transportar al paciente en posición supina con las piernas extendidas
- B) Usar una tabla espinal para inmovilizar la columna y la pelvis
- C) Colocar almohadas debajo de las caderas para elevar la pelvis durante el transporte
- D) Realizar la movilización lo más pronto posible sin tener en cuenta la estabilidad de la fractura

Respuesta Correcta: B

61. ¿Cuál es una complicación potencial de una fractura de pelvis?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Lesión de órganos abdominales
- B) Fractura de huesos de las extremidades superiores
- C) Hernia inguinal
- D) Luxación de cadera

Respuesta Correcta: A

62. ¿Cuál es la primera acción en el manejo de una víctima traumática con una posible lesión de la columna cervical?

- A) Administrar oxígeno suplementario
- B) Inmovilizar la columna cervical
- C) Evaluar la permeabilidad de la vía aérea
- D) Realizar una evaluación neurológica

Respuesta Correcta: C

63. En el Servicio de Urgencias hay que tener presente que "todo paciente con posibilidad de desarrollar una muerte encefálica es un potencial donante de órganos". ¿En un paciente con coma estructural irreversible y evidenciado por neuroimagen, de entre los siguientes procesos concomitantes cuál NO es excluyente para la donación de órganos?

- A) Hipertensión de larga evolución para la donación de riñón.
- B) Antecedentes de melanoma.
- C) Síndrome de disfunción multiorgánica para la donación de órganos sólidos.
- D) Tuberculosis no tratada correctamente

Respuesta Correcta: A

64. Algunos problemas de seguridad del paciente en el Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) derivan de factores asociados a una evaluación inicial pobre o inaceptable, a la falta de reconocimiento de deterioro en la condición clínica del paciente y la inadecuada comunicación en el traspaso de la información clínica. Este tipo de riesgo se concentra en la fase de triaje y en los cambios de turno del personal. ¿Cuál de las siguientes NO es una medida recomendada de valoración del sistema de triaje en el SUH?

- A) Nivel de triaje y tiempo de atención médica recomendada





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Nivel de triaje y número de recursos clínicos recomendados
- C) El sistema de triaje, validado, debe estar integrado en el sistema informático del hospital.
- D) Tiempo medio entre la llegada al SUH (momento de registro en Admisión) y realización del triaje (registro en el sistema informático).

Respuesta Correcta: B

65. ¿Cuál de los siguientes sistemas estructurados de triaje NO tiene establecido un objetivo de tiempo máximo para el primer contacto o la primera valoración por el médico de urgencias?

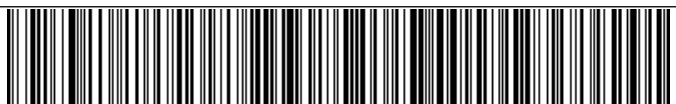
- A) Manchester triage Scale (MTS)
- B) Canadian triage and acuity scale (CTAS)
- C) Sistema español de triaje (SET)
- D) Emergency Severity Index 5 level triage (ESI)

Respuesta Correcta: D

66. Sobre los sistemas de triaje en los hospitales del SNS ¿qué afirmación NO es correcta?

- A) El personal de Enfermería no utiliza ningún sistema estructurado de triaje cuando está implantado el sistema de triaje avanzado (en los que se usan protocolos específicos para solicitar pruebas básicas y administrar algunos tratamientos básicos antes de la entrada en la consulta médica).
- B) Los sistemas estructurados de triaje más usados en los hospitales del SNS son el Manchester triage Scale (MTS) y el sistema español de triaje (SET).
- C) En el triaje multidisciplinar está formado por personal de enfermería entrenado, se incluye siempre a un médico de urgencias y, además, puede incluirse a auxiliares de Enfermería, celador informador o administrativo.
- D) Actualmente es el personal de enfermería el que con más frecuencia realiza el triaje, con o sin ayuda del facultativo. En este sentido algunos estudios concluyen que el triaje de enfermería con apoyo médico es más eficiente que el triaje de enfermería aislado, sobre todo, para los casos de alta urgencia y complejidad.

Respuesta Correcta: A





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

67. ¿Qué actividad puede demorarse no tiene que realizarse en el momento del triaje?

- A) Glucemia en triaje caso de síndrome confusional agudo
- B) Determinación de FR y saturación de O₂ en triaje en caso de disnea
- C) Todas las actividades mencionadas son necesarias que se realicen en el momento del triaje
- D) ECG en triaje caso de síncope

Respuesta Correcta: C

68. El Consejo Español de Triaje Prehospitalario y Hospitalario (CETPH) ha diseñado una cadena asistencial en incidentes con múltiples víctimas (IMV) ¿Cuál de los objetivos de los cuatro eslabones de la cadena NO es correcto?

- A) Durante el triaje avanzado: realizar la derivación rápida y eficiente
- B) En el área de rescate: proteger y alertar.
- C) Durante el triaje básico: realizar las maniobras salvadoras.
- D) Durante el triaje avanzado: realizar la estabilización

Respuesta Correcta: A

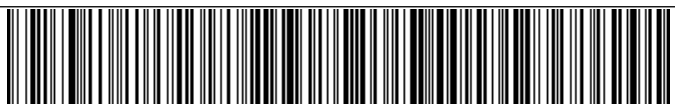
69. ¿De entre las siguientes víctimas cuál NO tiene riesgo de muerte inmediata (10 minutos) o precoz (2 horas)?

- A) Hemoneumotórax
- B) Laceración hepática
- C) Contusión esplénica
- D) Fractura de pelvis

Respuesta Correcta: C

70. ¿Cuál es el objetivo principal del triaje en un incidente con múltiples víctimas según el Advanced Trauma Life Support (ATLS) del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos?

- A) Estabilizar las lesiones críticas de inmediato
- B) Determinar la gravedad de las lesiones en cada víctima
- C) Priorizar la atención médica basada en la gravedad de las lesiones





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Coordinar la evacuación de las víctimas al centro de atención adecuado

Respuesta Correcta: C

71. ¿Cuál es el objetivo principal de la organización del incidente en un manejo efectivo de múltiples víctimas según el Advanced Trauma Life Support (ATLS) del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos?

- A) Proporcionar tratamiento definitivo a todas las víctimas en el lugar del incidente
- B) Minimizar el tiempo de respuesta y evacuación de las víctimas
- C) Establecer un área de triaje segura para la atención médica inicial
- D) Coordinar la colaboración de los diferentes servicios de emergencia

Respuesta Correcta: B

72. ¿Cuál es el principio básico en la distribución de recursos médicos limitados durante un incidente con múltiples víctimas según el Advanced Trauma Life Support (ATLS) del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos?

- A) Priorizar a los pacientes con lesiones más graves
- B) Asignar recursos a los pacientes más jóvenes primero
- C) Distribuir los recursos de manera equitativa entre todas las víctimas
- D) Evaluar la capacidad de recuperación de cada paciente individualmente

Respuesta Correcta: A

73. ¿Qué nivel PRIORIDAD se le asigna a un paciente varón de 80 años con un ICTUS TRANSITORIO en el servicio de urgencias hospitalario?

- A) Nivel de PRIORIDAD 1
- B) Nivel de PRIORIDAD 2
- C) Nivel de PRIORIDAD 3
- D) No es necesario su traslado al servicio de urgencias hospitalario

Respuesta Correcta: B

74. ¿Qué nivel PRIORIDAD se le asigna a un paciente varón de 80 años con ICTUS CON DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONSCIENCIA en el servicio de urgencias hospitalario?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Nivel de PRIORIDAD 1
- B) Nivel de PRIORIDAD 2
- C) Nivel de PRIORIDAD 3
- D) No es necesario su traslado al servicio de urgencias hospitalario

Respuesta Correcta: A

75. ¿Qué nivel PRIORIDAD se le asigna a un paciente varón de 80 años con ICTUS DE MÁS DE 24 HORAS DE EVOLUCIÓN CON SITUACIÓN VITAL PREVIA INDEPENDIENTE en el servicio de urgencias hospitalario?

- A) Nivel de PRIORIDAD 1
- B) Nivel de PRIORIDAD 2
- C) Nivel de PRIORIDAD 3
- D) No es necesario su traslado al servicio de urgencias hospitalario

Respuesta Correcta: C

76. Ante una mujer de raza negra de 50 años con cefalea intensa de inicio súbito que presenta 15 puntos en la Escala de Coma de Glasgow, rigidez de nuca, sin déficit motor y que en el TC craneal no se evidencia una hemorragia subaracnoidea, ¿cuál es la primera prueba complementaria que realizaría de entre las siguientes?

- A) Punción lumbar
- B) Angio-TC
- C) Arteriografía
- D) RM cerebral y medular

Respuesta Correcta: A

77. Ante una mujer de 78 años trasladada desde su domicilio en ambulancia de soporte vital básico, refiere su hija “que su madre es independiente, que la ve que se toma sus pastillas, tanto por la mañana como por la noche para su hipertensión arterial, diabetes, tiroides, colesterol y para el insomnio, que su madre lleva unos 2 días apática, muy deprimida y muy lenta, que no se ha caído, no ha ingerido tóxicos y que cuando llegó del trabajo la encuentra en su cama y que le cuesta mucho que le conteste”. A la llegada al servicio de Urgencias hospitalario (SUH) está con aspecto mixematoso, saturando basalmente al 93%, TA 100/60, FC 60, con





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

12 puntos en la escala de Coma de Glasgow (O3, V3, M6), sin rigidez de nuca, sin focalidad motora, glucemia 70 mg/dL, antes de administrar precozmente levotiroxina y actocortina ¿qué realizaría primero de entre las siguientes actividades a la llegada al SUH?

- A) Medir la temperatura corporal
- B) Administrar precozmente ceftriaxona y aciclovir
- C) Realizar electrocardiograma
- D) Preparar para realizar punción lumbar

Respuesta Correcta: A

78. En caso de hipertensión intracraneal (HIC) ¿qué NO está indicado en el servicio de Urgencias hospitalario?

- A) Realizar punción lumbar con fines terapéuticos.
- B) Administrar dexametasona en bolo inicial de 20-40 mg y dosis posterior de 4-8 mg/12 h.
- C) Descartar HIC si no hay bradicardia asociada a hipertensión arterial.
- D) Utilizar sueros hipotónicos.

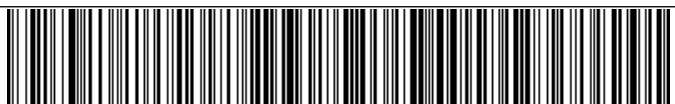
Respuesta Correcta: D

79. La crisis tónico-clónica generalizada es indicativa de GRAVEDAD en las siguientes circunstancias EXCEPTO en:

- A) En el síndrome de embolia grasa asociado a traumatismos y en no asociado a traumatismos
- B) Cuando aparece midriasis bilateral, síndrome confusional poscrítico y fiebre en lactantes.
- C) Cuando la crisis dura más de 30 minutos.
- D) Cuando entre las crisis repetidas no se recupera por más de 30 minutos el estado neurológico previo.

Respuesta Correcta: B

80. La intubación endotraqueal, como medida inmediata, puede evitarse EXCEPTO en uno de los siguientes casos de coma, ¿cuál es?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Paciente sin enfermedad terminal o avanzada y con GCS de 7 puntos.
- B) Paciente en coma que no consigue una SatO₂ > 90 % con oxígeno suplementario.
- C) Paciente en coma que no se consigue una SatO₂ > 90 % con oxígeno suplementario, con vómito reciente y reflejo tusígeno y faríngeo pobres.
- D) Paciente en coma con gran infarto hemisférico.

Respuesta Correcta: D

81. Sobre el código ictus en Canarias ¿cuál afirmación es FALSA?

- A) El código Ictus extrahospitalario está implantado en Canarias a través del teléfono de emergencias 112.
- B) El código ictus extrahospitalario puede ser activado tras comunicarse con el 112, y tanto por personal sanitario como no sanitario.
- C) El código Ictus intrahospitalario también se activa cuando el paciente está ingresado en planta de hospitalización.
- D) El código Ictus intrahospitalario se produce como consecuencia de la aplicación del código extrahospitalario o a la llegada de un ictus a la puerta de urgencia del hospital.

Respuesta Correcta: C

82. Todas estas afirmaciones sobre el ictus son falsas EXCEPTO una, señálese:

- A) Se define como accidente isquémico transitorio (AIT) el déficit neurológico focal que no deja evidencia en la neuroimagen, habitualmente sin que tenga importancia la duración del déficit en la evidencia en la neuroimagen.
- B) El ictus hemorrágico tiene como etiología más frecuente es la hipertensión arterial y, por ello, es más frecuente que el ictus isquémico.
- C) La anticoagulación terapéutica cuando está indicada, se inicia antes de las 48 horas.
- D) En el ictus isquémico sin criterios de revascularización y riesgo de aspiración, se administra acetilsalicilato de lisina i.v. (450 mg/día; 1/2 ampolla) como alternativa al ácido acetilsalicílico vía oral y al clopidogrel vía oral.

Respuesta Correcta: D





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

83. ¿Cuál de las siguientes características NO define al síndrome confusional agudo?

- A) Cursa con agitación psicomotriz pero no con somnolencia o letargo.
- B) Su origen es orgánico y suele ser reversible.
- C) Alteración aguda de déficit de atención y de evolución fluctuante.
- D) Es sinónimo de delirio o encefalopatía tóxica-metabólica.

Respuesta Correcta: A

84. ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos clínicos NO se corresponde con la posible neuralgia afectada?

- A) Dolor retroocular con visión borrosa: Neuralgia del nervio oculomotor (par craneal III)
- B) Dolor punzante y paroxístico en la región facial: Neuralgia del nervio trigémino (par craneal V)
- C) Dolor intenso y pulsátil en la región occipital: Neuralgia occipital (generalmente relacionada con el nervio occipital mayor, que no es un par craneal)
- D) Dolor en la mandíbula con dificultad para abrir la boca: Neuralgia del nervio glosofaríngeo (par craneal X)

Respuesta Correcta: D

85. ¿Sobre las cefaleas cuál es CIERTA?

- A) Los síndromes de cefalea primaria son: migraña, cefalea de tensión y cefalea en racimos.
- B) Las causas de cefaleas secundarias en Urgencias son: atribuida a infecciones fuera del SNC, atribuida a toxicidad por sustancia, abuso o abstinencia, a atribuida a emergencia hipertensiva, psicógena, después de la punción lumbar.
- C) No solicitar una tomografía computarizada (TC) sin contraste urgente a un paciente con criterios de alarma en su presentación puede ser considerado como una mala praxis en la actuación médica, aunque una TC en solitario no excluye completamente la patología cerebral grave de riesgo vital.
- D) Todas son ciertas.

Respuesta Correcta: D





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

86. De los síntomas o signos indicativos de una posible cefalea secundaria (Sociedad Española y Americana de Neurología) y sus criterios de alarma cuáles no son criterios de solicitud de tomografía computarizada (TC) urgente?

- A) Cefalea en pacientes que dudan del diagnóstico, en quienes existe una marcada ansiedad o que expresan temor ante un eventual proceso intracraneal grave
- B) Cefalea refractaria a un tratamiento teóricamente correcto
- C) Cefalea de presentación predominantemente nocturna
- D) Todas las anteriores tienen criterios para solicitud de una TC urgente

Respuesta Correcta: D

87. ¿Cuál NO es cierta de las siguientes afirmaciones sobre el síndrome confusional agudo (SCA)?

- A) A menudo en ancianos es infradiagnosticado en las formas hipoactivas (somnolencia o letargo).
- B) Es habitual la fluctuación en cuestión de minutos u horas desde una presentación hiperactiva (agitación psicomotriz o hipervigilia) hacia la presentación hipoactiva (somnolencia o letargo).
- C) Los cambios de ubicación, la realización de pruebas diagnósticas o la falta de acompañamiento familiar no se consideran un factor precipitante del SCA durante su estancia en Urgencias.
- D) El tratamiento farmacológico es mejor evitar su uso, pues puede empeorar el SCA, y administrar como tratamiento sintomático en caso de que el comportamiento del paciente entrañe peligrosidad o interfiera con los cuidados médicos.

Respuesta Correcta: C

88. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el síndrome meníngeo agudo es CIERTA?

- A) El signo de la rigidez de nuca conlleva no solo rigidez sino también dolor a la flexión y a la rotación del cuello.
- B) La tinción de Gram es una técnica de detección tardía por lo que no tiene relevancia en el tratamiento antibiótico en Urgencias





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) En una mujer de 18 años con síndrome meníngeo agudo, fiebre, rash y otalgia de 24 horas se puede esperar por el resultado del LCR antes de ponerle cefotaxima y vancomicina para evitar la yatrogenia.
- D) Todas son falsas

Respuesta Correcta: D

89. En la primera crisis de vértigo que no se autolimita en 24 horas ¿qué es CIERTO?

- A) Los infartos cerebrales que no afectan a la arteria cerebral posterior ni a la arteria cerebelosa también producen vértigo.
- B) Dentro de las primeras 24-48 horas la anamnesis y la exploración física tiene más importancia en el diagnóstico que la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RMN-DWI).
- C) El síndrome vestibular agudo tiene en la neuritis vestibular y el infarto del tronco encefálico o cerebelo sus presentaciones más frecuentes en Urgencias.
- D) Todas son ciertas.

Respuesta Correcta: D

90. ¿Entre las siguientes presentaciones de una primera crisis de vértigo cuál NO es característica de un origen cerebeloso o tronco encefálico?

- A) Otalgia
- B) Nistagmo alternante
- C) Ataxia
- D) Focalidad neurológica sobre todo si es instauración progresiva

Respuesta Correcta: A

91. Un varón de 39 años sin AP de interés es traído al Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) en una ambulancia de soporte vital básico porque tras una comida presenta náuseas, vómitos y ahora sin síntomas y refiere que se empezó a sentir mal y ya no se acuerda de nada más, solo que despertó y le han dicho que se desmayó durante un minuto, sin traumatismo y se recuperó totalmente. Como médico de urgencias ¿cuál de las siguientes considera que NO es una actitud prudente?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Si el paciente está consciente, orientado y colaborador no es necesario recabar la información de testigos.
- B) Siempre tener los datos TA, FC, FR T°C y SatO₂ y no olvidarse de la Glucemia.
- C) Mantener en observación o incluso ingresar si esa pérdida transitoria de conocimiento fue precedida de palpitaciones
- D) Debe plantear el ingreso u observación prolongada si se acompaña de dolor torácico, disnea o cefalea.

Respuesta Correcta: A

92. Dentro de la definición del síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Es debido a una alteración de la membrana capilar pulmonar.
- B) Radiológicamente se objetivan opacidades bilaterales no explicadas por derrame pleural, atelectasia o nódulos pulmonares.
- C) Es necesario que exista una presión de oclusión de la arteria pulmonar (POAP) >18 mmHg.
- D) El cociente PaO₂/FiO₂ debe ser menor o igual a 200 mmHg.

Respuesta Correcta: C

93. Un paciente ingresado por pancreatitis aguda, comienza con taquipnea, taquicardia, sudoración y cianosis progresiva. La PaO₂ es de 55 mmHg (cociente PaO₂/FiO₂ <200 mmHg). La radiografía de tórax muestra infiltrados alveolares bilaterales. La presión de enclavamiento capilar pulmonar es normal. La oxigenoterapia no mejora la situación. ¿Qué diagnóstico es el más probable?

- A) Neumonía nosocomial.
- B) Insuficiencia cardíaca.
- C) Tromboembolismo pulmonar.
- D) Distrés respiratorio.

Respuesta Correcta: D

94. En un paciente que acude con una crisis asmática, ¿cuál de los siguientes hallazgos es el que indica peor evolución?

- A) Silencio auscultatorio.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Taquipnea.
- C) Espiración prolongada.
- D) Presencia de sibilancias a la auscultación.

Respuesta Correcta: A

95. Un paciente asmático de 55 años acude a Urgencias con una agudización. Una hora después de la administración de oxígeno suplementario y dos nebulizaciones de salbutamol el paciente no mejora. A la exploración respira a 42 rpm con tiraje supraclavicular y presenta sibilancias inspiratorias y espiratorias diseminadas. El flujo pico ha bajado de 310 a 220 l/ min. Una gasometría extraída con oxígeno al 28% muestra una pO₂ de 54 mmHg y una pCO₂ de 35 mmHg. ¿Cuál de las siguientes actitudes le parece MENOS indicada?

- A) Aumentar el flujo de oxígeno.
- B) Administrar 80 mg de metilprednisolona i.v.
- C) Nebulizar bromuro de ipratropio junto con salbutamol cada 20 minutos.
- D) Iniciar ventilación mecánica no invasiva.

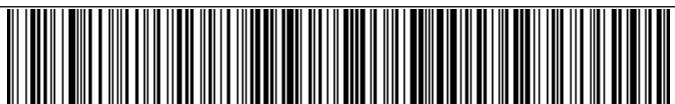
Respuesta Correcta: D

96. Hombre de 72 años con antecedentes de EPOC con obstrucción grave al flujo aéreo, con dos exacerbaciones graves en el último año, que acude a urgencias con taquipnea y uso de musculatura accesoria. Está alerta. En la gasometría arterial basal se objetiva: pH 7,29, PaCO₂ 68 mmHg, PaO₂ 51 mmHg. Se inicia tratamiento broncodilatador, esteroideo, antibioterapia empírica y se ajusta la oxigenoterapia para conseguir una SatO₂ entre 88 y 92%. Tras una hora repite la gasometría arterial con gafas nasales a 2 lpm y presenta pH 7,28, PaCO₂ 70 mmHg, PaO₂ 62 mmHg. Señale la actuación correcta:

- A) Iniciar ventilación mecánica no invasiva.
- B) Proceder a la intubación orotraqueal e iniciar ventilación mecánica.
- C) Incrementar la oxigenoterapia hasta obtener una SatO₂ de al menos 99%.
- D) Combinar benzodiacepinas con altos flujos de oxígeno para asegurar una disminución de la taquipnea y mejorar el patrón ventilatorio.

Respuesta Correcta: A

97. Sobre la broncoaspiración ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) El sondaje nasogástrico u orogástrico está indicado en pacientes ancianos o con disminución del nivel de consciencia o alteraciones de la deglución
- B) Un esputo de buena calidad se define por la presencia de más de 25 leucocitos por campo y menos de 10 células de epitelio escamoso
- C) La neumonía aspirativa se recomienda tratar empíricamente amoxicilina/clavulánico 2 g/8 h y si existe gravedad con ertapenem 1 g/24 h
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

98. El médico de salvamento marítimo valora a un varón adulto joven del que desconoce su estado de vacunación, que durante la travesía de 4 días presentó un cuadro catarral y desde hoy está con fiebre termometrada de 40°C, mal estado general, ausencia de tos con estridor inspiratorio, tiraje supraclavicular marcado, aleteo nasal, cuello extendido, boca abierta con sialorrea y babeo ¿Cuál de las siguientes es CIERTA?

- A) El depresor lingual confirma el diagnóstico clínico, a pesar del intenso dolor de garganta la faringe tiene un aspecto normal.
- B) Debe mantener al paciente sentado y evitar el decúbito.
- C) Debe administrar un antiinflamatorio y ceftriaxona 1-2 g intravenoso.
- D) Todas son ciertas.

Respuesta Correcta: D

99. Una de las siguientes intervenciones NO ha demostrado influir en la evolución de los pacientes con EPOC:

- A) Oxigenoterapia en pacientes con hipoxemia crónica.
- B) Cirugía de reducción de volumen en pacientes seleccionados con enfisema.
- C) Tratamiento con N-acetilcisteína.
- D) Interrupción del tabaquismo.

Respuesta Correcta: C

100. Hombre de 73 años de edad, ex fumador, antecedentes de HTA, obesidad grado II, diabetes tipo 2 y EPOC grave con oxigenoterapia crónica domiciliaria. Acude a Urgencias por aumento progresivo de su disnea habitual, expectoración purulenta y temperatura de 37.9 °C de 4 días de evolución. Su médico de cabecera





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

le había prescrito 2 días antes moxifloxacino, paracetamol, deflazacort, aerosolterapia y aumento del flujo de oxígeno. A la exploración física el paciente se encuentra con regular estado general, consciente, tendencia al sueño, taquipneico a 28 rpm y utilización de musculatura accesoria, temperatura 38,2 °C, saturación de oxígeno de 87%, TA 115/62 mmHg, frecuencia cardíaca 110 lpm; murmullo vesicular disminuido globalmente, sibilancias y la analítica destaca leucocitosis 16.500/uL con 14.900 neutrófilos, hemoglobina 14 g/dL, glucosa 240 mg/dL, urea 56 mg/dL, creatinina 1.3 mg/dL, Na 133 mEq/L, K 3.7 mEq/L. En el ECG se objetiva taquicardia sinusal. La gasometría arterial muestra: pH 7,29, pCO₂ 64 mmHg, pO₂ 59 mmHg, HCO₃ 28 mg/dL. En la radiografía de tórax no se aprecia condensación ni derrame pleural. ¿Cuál de las siguientes opciones de manejo clínico instauraría en primer lugar?

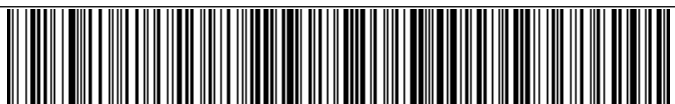
- A) Iniciar tratamiento con diuréticos intravenosos, oxígeno con mascarilla a alto flujo al 50% y seguir con el resto de tratamiento ya prescrito.
- B) Iniciar tratamiento con aerosoles de salbutamol y esteroides, añadir al tratamiento antibiótico una cefalosporina, intensificar la oxigenoterapia con oxígeno en gafas nasales a 4 litros por minuto y mantener deflazacort.
- C) Iniciar tratamiento de la acidosis con bicarbonato 1M, corregir la hiperglucemia, mantener tratamiento antibiótico y prescribir esteroides más diuréticos intravenosos.
- D) Iniciar el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva (modo presión positiva de dos niveles), prescribir aerosoles de salbutamol y esteroides intravenosos y mantener tratamiento antibiótico por vía intravenosa.

Respuesta Correcta: D

101. Un paciente con EPOC grave acude agudizado a Urgencias y presenta una gasometría arterial extraída con FiO₂ del 31% a nivel del mar con una PaO₂ de 86 mmHg, PaCO₂ 65 mmHg, pH 7,13 y Bicarbonato de 27 mmol/litro. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) El paciente está hiperventilando.
- B) El gradiente alveoloarterial de oxígeno está elevado.
- C) El paciente está en acidosis respiratoria.
- D) Se debería considerar iniciar ventilación mecánica.

Respuesta Correcta: A





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

102. La causa más frecuente de hemoptisis leve-moderada es:

- A) Bronquiectasias.
- B) Carcinoma broncogénico.
- C) Infarto pulmonar.
- D) Neumonía.

Respuesta Correcta: A

103. Varón de 35 años, trasladado a urgencias tras un accidente de tráfico. A su ingreso se observa una puntuación en la escala de Glasgow de 15, tensión arterial de 140/90 mmHg, frecuencia respiratoria de 35 rpm y frecuencia cardiaca de 110 lpm, con una saturación de oxígeno basal del 91%. En la exploración hay hipofonesis torácica derecha y timpanismo a la percusión. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción?

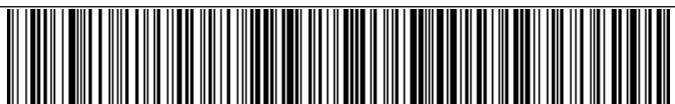
- A) Taponamiento cardíaco traumático.
- B) Neumotórax a tensión derecho.
- C) Hemotórax masivo derecho.
- D) Contusión pulmonar.

Respuesta Correcta: B

104. Un hombre de 38 años acude a urgencias por disnea progresiva y tos seca de una semana de evolución. No tiene antecedentes de interés. Las constantes vitales son: temperatura 37,8 °C, presión arterial 110/70 mmHg, frecuencia cardiaca 105 lpm y frecuencia respiratoria 30 rpm. En la exploración respiratoria destaca matidez a la percusión, disminución del frémito táctil (vocal) y disminución de los ruidos respiratorios en la base del hemitórax derecho. El resto de la exploración física es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Derrame pleural.
- B) Neumonía lobar.
- C) Bronquitis aguda.
- D) Neumotórax.

Respuesta Correcta: A





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

105. De las siguientes enfermedades, una de ellas puede manifestarse con ausencia de pulso venoso yugular:

- A) Pericarditis constrictiva.
- B) Síndrome de vena cava superior.
- C) Insuficiencia tricúspide.
- D) Insuficiencia cardíaca.

Respuesta Correcta: B

106. Sobre el síndrome de vena cava superior (SVCS) ¿cuál de las siguientes es FALSA?

- A) El tratamiento con dexametasona no está indicado.
- B) La incidencia del SVCS debido a la trombosis asociada a catéter venoso central ha aumentado su incidencia.
- C) Las neoplasias son la causa principal del SVCS.
- D) La anticoagulación solo está indicada si existe trombosis.

Respuesta Correcta: A

107. Mujer de 27 años acude a Urgencias con tos no productiva, fiebre y dolor pleurítico de un mes de evolución. En la radiografía de tórax se objetiva un derrame pleural izquierdo. El análisis del líquido pleural muestra un exudado linfocítico con pH 7,32, glucosa 66 mg/dL y adenosin-deaminasa 59 U/L. ¿Cuál es la etiología más probable?

- A) Insuficiencia cardíaca.
- B) Síndrome de Meigs.
- C) Quilotórax.
- D) Tuberculosis pleural.

Respuesta Correcta: D

108. Al introducir un drenaje torácico por el tercer espacio intercostal-línea media claviclar como tratamiento del neumotórax espontáneo, ¿qué estructuras atravesará para conseguir la reexpansión pulmonar?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Piel - tejido subcutáneo-músculo dorsal ancho - musculatura intercostal - pleura visceral.
- B) Piel - tejido subcutáneo - músculo serrato lateral - musculatura intercostal - pleura parietal.
- C) Piel - tejido subcutáneo - musculatura pectoral - musculatura intercostal - pleura parietal.
- D) Piel - tejido subcutáneo - músculo infraespinoso - musculatura intercostal - pleura parietal.

Respuesta Correcta: C

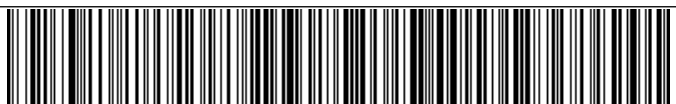
109. Entre las siguientes situaciones indique cuál de ellas NO requiere un drenaje torácico como tratamiento de elección:

- A) Neumotórax espontáneo primario derecho del 50% en paciente de 30 años con saturación basal de 89% y dolor sobre hemitórax derecho.
- B) Hombre de 59 años de edad con semiología –24– radiológica de velamiento de todo el hemitórax izquierdo con desplazamiento mediastínico contralateral, hipotensión de 70/40 mm de Hg y frecuencia cardiaca de 120 latidos por minuto, tras accidente de tráfico.
- C) Paciente de 67 años con adenocarcinoma pulmonar de tercio distal del bronquio principal derecho con extensión sobre bronquio intermediario con obstrucción completa de lóbulo inferior derecho y lóbulo medio que presenta disnea a grandes esfuerzos y semiología radiológica de velamiento del tercio inferior del hemitórax derecho con desplazamiento ipsilateral mediastínico.
- D) Paciente fumador de 45 años con neumonía neumocócica de lóbulo superior izquierdo e hipofonesis basal izquierda en la auscultación. Radiológicamente derrame pleural ipsilateral que ocupa tercio inferior del hemitórax izquierdo y toracocentesis diagnóstica con pH del líquido pleural de 6,7.

Respuesta Correcta: C

110. La práctica de una radiografía posteroanterior de tórax en espiración forzada es de gran utilidad para el diagnóstico de:

- A) Derrame pleural loculado.
- B) Neumotórax mínimo.
- C) Hemotórax.
- D) Atelectasia pulmonar.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: B

111. Paciente de 47 años, sin antecedentes patológicos de interés. Presenta un cuadro de fiebre y dolor en punta de costado derecho y ha sido diagnosticado de neumonía adquirida en la comunidad en su Centro de Salud. En una radiografía simple de control, realizada 3 días después del inicio del tratamiento antibiótico, se objetiva un derrame pleural ipsilateral que ocupa un tercio del hemitórax derecho. Señale la Respuesta Correcta:

- A) Se puede establecer el diagnóstico de empiema pleural si se realiza una toracocentesis y el pH del líquido pleural es de 7,4.
- B) El diagnóstico de empiema pleural solo queda confirmado si se halla un microorganismo en el cultivo de líquido pleural.
- C) Debe sospecharse un empiema pleural si el paciente presenta persistencia de fiebre y leucocitosis.
- D) La presencia de un derrame pleural es suficiente para establecer el diagnóstico de empiema pleural y colocar un drenaje pleural derecho.

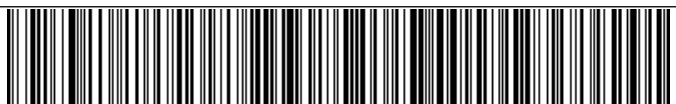
Respuesta Correcta: C

112. Hombre de 72 años que presenta desde hace 48 horas fiebre de 38,7°C, tos, expectoración purulenta y disnea. Constantes: TA 85/60 mmHg, frecuencia cardiaca 100 lpm, frecuencia respiratoria 35 rpm, SatO2 80%. Destaca la presencia de confusión y de crepitantes en el campo pulmonar inferior izquierdo. La radiografía de tórax confirma la existencia de una neumonía de la llingula y del lóbulo inferior izquierdo. ¿Cuál sería el lugar de atención adecuado?

- A) Tratamiento ambulatorio en su domicilio.
- B) Ingreso en una unidad de observación de urgencias.
- C) Ingreso hospitalario en planta.
- D) Ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Respuesta Correcta: D

113. Un paciente de 64 años de edad, agricultor, exfumador (5 años), EPOC y afecto de artritis reumatoide en tratamiento corticoideo. Consulta en urgencias por presentar cefalea intensa de 2 días de evolución con desviación de comisura bucal. Como antecedente, relata que tras cuadro gripal hace un mes, persisten tos, expectoración purulenta y ocasionalmente hemoptoica, febrícula, anorexia, astenia





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

y pérdida de peso. A su llegada se aprecia la existencia de fiebre de 38.2 °C, abscesos cutáneos múltiples en manos, espalda y nalgas (algunos con trayectos fistulosos) y parálisis facial central derecha, infiltrados apicales con pequeño derrame pleural asociado en la radiografía de tórax y leucocitosis con neutrofilia. Entre los siguientes diagnósticos de sospecha consideraría MÁS probable:

- A) Neoplasia pulmonar con metástasis cerebrales.
- B) Tuberculosis diseminada.
- C) Nocardiosis.
- D) Aspergilosis.

Respuesta Correcta: C

114. Paciente de 60 años que acude a urgencias del hospital por cuadro de dolor torácico izquierdo, con tos y expectoración amarillenta, temperatura de 38.7 °C, sensación de falta de aire. Saturación arterial de oxígeno 80%. Hemograma leucocitos 12000/uL con 86% de polimorfonucleares. Rx de tórax: infiltrado alveolar en base izquierda con broncograma aéreo. Ante la sospecha de neumonía, se hace Ag de neumococo en orina que es positivo y se envía cultivo de esputo al servicio de Microbiología. ¿Qué tratamiento antibiótico empírico de los indicados es el más correcto en espera de resultados microbiológicos?

- A) Ceftazidima.
- B) Azitromicina
- C) Ceftriaxona
- D) Doxiciclina.

Respuesta Correcta: C

115. Paciente de 70 años de edad diagnosticado hace tres años de mieloma múltiple que está en periodo de neutropenia tras un ciclo de quimioterapia. Acude a Urgencias por fiebre, tos y expectoración amarillenta. La radiografía de tórax muestra una imagen de condensación en hemitórax derecho. El diagnóstico más probable es:

- A) Neumonitis tóxica postquimioterapia.
- B) Neumonía neumocócica.
- C) Neumonía vírica por virus respiratorio comunitario.
- D) Neumonía por citomegalovirus.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: B

116. Mujer de 25 años, sin antecedentes de interés, que presenta una adenopatía cervical indolora de 3 cm de diámetro, de crecimiento lento y de dos meses de evolución. La enferma refiere fiebre y sudoración nocturna. Se le practicó una biopsia de la adenopatía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Sarcoidosis.
- B) Toxoplasmosis.
- C) Tuberculosis.
- D) Linfoma.

Respuesta Correcta: C

117. ¿Cuál es la pauta estándar actual, en nuestro medio, de tratamiento de la tuberculosis pulmonar?

- A) Isoniazida + rifampicina + pirazinamida (6 meses).
- B) Isoniazida + rifampicina + pirazinamida + etambutol (2 meses) seguido de isoniazida + rifampicina (4 meses).
- C) Isoniazida + rifabutina + etambutol (9 meses).
- D) Isoniazida + rifampicina + pirazinamida (2 meses) seguido de isoniazida + rifampicina (4 meses).

Respuesta Correcta: B

118. Le avisan a las 2 de la madrugada porque hay un paciente en urgencias que se está asfixiando. La Enfermería tiene preparado un gotero con teofilina y un bisturí para realizar una traqueotomía. Sin dudar, usted elige el bisturí porque:

- A) El paciente presenta estridor espiratorio y signos evidentes de edema pulmonar.
- B) El paciente está muy cianótico.
- C) El paciente está taquicárdico y sudoroso.
- D) El paciente presenta estridor inspiratorio y tiraje.

Respuesta Correcta: D

119. Varón de 50 años que acude al servicio de Urgencias hospitalario con fiebre de 38,5 °C, odinofagia intensa y voz gangosa, de 2 horas de evolución. Se establece el





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

diagnóstico de epiglotitis aguda. Señalar la actitud más correcta de las que se relacionan a continuación:

- A) Prescribir corticoides asociados a amoxicilina-clavulánico por vía oral, y alta hospitalaria.
- B) Toma de muestra para hemocultivo, posponiendo el tratamiento hasta conocer el resultado de aquél.
- C) Intubación orotraqueal e ingreso en UVI.
- D) Ingreso hospitalario, tratamiento i.v. con corticoides y cefalosporina de 3.^a generación, y vigilancia estrecha de la evolución.

Respuesta Correcta: D

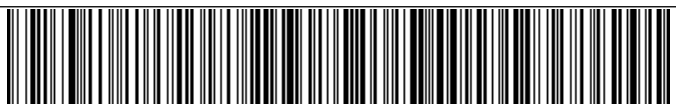
120. Sobre el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) que pone en marcha el llamado Código Infarto en el SCS (CODICAN) ¿cuáles de las siguientes es FALSA?

- A) En Triage debe realizarse tras descartarse el origen traumático del dolor torácico de realizarse el ECG de 12 derivaciones antes de 10 minutos.
- B) Si existe clínica compatible y ECG es dudoso, debe repetirse ECG en 10 minutos y reevaluar.
- C) En menores de 40 años para la V₂ y V₃ se requiere elevación persistente (>20 minutos) de al menos 2 mm persistente del segmento ST
- D) En mujeres para la V₂ y V₃ se requiere elevación persistente (>20 minutos) de al menos 1,5 mm persistente del segmento ST.

Respuesta Correcta: C

121. Sobre los criterios de Sgarbossa-Smith predictores de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) en presencia de bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH) de nueva aparición o desconocido ¿cuáles de las siguientes es FALSA?

- A) Los criterios de Sgarbossa-Smith tienen una sensibilidad del 80% y una especificidad del 98%.
- B) El criterio A en cualquier derivación es la elevación del ST > 1 mm concordante con el complejo QRS. El criterio B en V₁, V₂, V₃ es la depresión del ST < 1 mm concordante con el complejo QRS. El criterio C es que la amplitud del ST respecto a la onda S, ST/S > 0.25





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) Tiene que estar presentes los tres criterios de Sgarbossa-Smith para considerar isquemia aguda en BRIHH de nueva aparición o desconocido.
- D) Tiene uno de los tres criterios de Sgarbossa-Smith para considerar isquemia aguda en BRIHH de nueva aparición o desconocido.

Respuesta Correcta: C

122. Sobre los criterios clínicos del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) según el documento del Código Infarto en el SCS (CODICAN) ¿cuáles de las siguientes es FALSA?

- A) Dolor torácico no traumático de más de 20 minutos de duración, descrito como opresivo e intenso, aunque no siempre, y que no cede con nitroglicerina sublingual.
- B) La localización suele ser precordial/retroesternal, con o sin irradiación. La irradiación suele ser a cuello/mandíbula, miembro superior izquierdo y/o espalda. En ocasiones se describen otras irradiaciones como al miembro superior derecho, epigastrio etc.
- C) Con frecuencia se acompaña de síntomas asociados como sudoración, náuseas, vómito, disnea, palpitaciones, síncope, dolor abdominal, etc.
- D) Los pacientes con síntomas atípicos (dolor epigástrico, dolor torácico no descrito como opresivo, disnea creciente etc.), suelen consultar más precozmente y suelen ser mujeres, personas ancianas, personas diabéticas y pacientes postoperados o críticos.

Respuesta Correcta: D

123. Sobre la notificación al teléfono 112 del SUC (Servicio de Urgencias Canario) en función de los criterios del ECG de 12 derivaciones y su correspondiente actuación en caso de dolor torácico isquémico ¿cuáles de las siguientes es FALSA?

- A) ECG: IAMCEST (elevación del segmento ST en dos derivaciones contiguas) - Actuación: NOTIFICAR PROBABLE código infarto.
- B) ECG: IAMSEST (depresión del segmento ST o cambios en la onda T) - Actuación: ACTIVAR 112 (vía habitual).
- C) ECG: BRIHH (con criterios de Sgarbossa-Smith compatible con isquemia aguda) - Actuación: NOTIFICAR PROBABLE código infarto.
- D) ECG: Ritmo ventricular estimulado por marcapasos - Actuación: ACTIVAR 112 (vía habitual).





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

124. Hombre de 65 años de edad con dolor torácico opresivo de características isquémicas de 30 minutos de duración que acude por sus propios medios a urgencias hospitalarias donde se objetiva en el ECG elevación del segmento ST en derivaciones II-III y aVF con descenso en V1-V2-V3. ¿Cuál de estas actitudes terapéuticas o diagnósticas NO debe realizarse?

- A) Prescribir al paciente 180 mg de ticagrelor como dosis de carga previa a la angioplastia primaria.
- B) Solicitar Troponina T de muy alta sensibilidad y esperar resultados para decidir la realización de angioplastia primaria.
- C) Prescribir al paciente 300 mg de ácido acetil salicílico como dosis de carga previa a la angioplastia primaria.
- D) Administrar oxígeno sólo a pacientes con hipoxemia ($\text{SaO}_2 < 90\%$ o $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg).

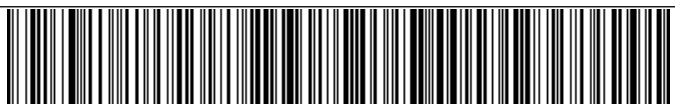
Respuesta Correcta: B

125. Una mujer de 51 años, con antecedentes de hipertensión arterial tratada con diuréticos, acude al centro de salud porque después de que le notificaron el accidente de un hijo 30 minutos antes, presenta nerviosismo, dolor en el centro del pecho con náuseas y sudoración intensa. En la exploración física la paciente se encuentra agitada y nerviosa, tiene una frecuencia cardiaca de 86 lpm y una presión arterial de 132/87 mmHg. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir?

- A) Tranquilizarla, explicarle que la exploración es normal, administrar un ansiolítico y recomendarle que si el cuadro no mejora acuda nuevamente al centro.
- B) Realizar una determinación de troponinas cardiacas.
- C) Realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones.
- D) Realizar una radiografía de tórax.

Respuesta Correcta: C

126. Un hombre de 65 años, fumador y diabético, es traído al Servicio de Urgencias por presentar desde hace aproximadamente una hora un dolor centrotorácico opresivo e intensa sudoración. En el ECG realizado se observa ritmo sinusal a 80





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

lpm y un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Cuál será nuestra actitud correcta del médico de Urgencias?

- A) Realizar una determinación analítica de troponina y esperar su resultado para confirmar la presencia de un infarto agudo de miocardio.
- B) Tratar al paciente como si fuera un infarto con elevación del segmento ST, planteando una terapia de perfusión lo más precoz posible.
- C) Implantar un marcapasos transcutáneo ante la posibilidad de que desarrolle un bloqueo más avanzado.
- D) Como pudiera tratarse de una pericarditis aguda administramos AINEs.

Respuesta Correcta: B

127. Un paciente acude al servicio de Urgencias por un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. A su llegada está hipotenso, presenta crepitanes y se ausculta un soplo sistólico 3/6. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?

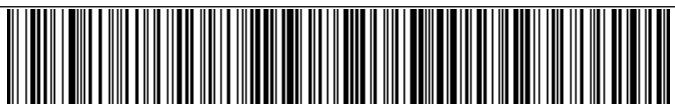
- A) Shock cardiogénico.
- B) Ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo.
- C) Insuficiencia mitral aguda por rotura de músculo papilar.
- D) Taponamiento cardíaco.

Respuesta Correcta: C

128. ¿En qué paciente se realizaría una coronariografía urgente?

- A) Mujer de 66 años diabética con un único episodio de dolor en reposo y elevación de troponinas.
- B) Hombre de 77 años que ingresa por dos episodios de dolor de 30 minutos de duración con descenso del segmento ST en el ECG durante el episodio de dolor.
- C) Hombre de 55 años que tras una semana de tratamiento con doble antiagregación acude a urgencias con un dolor de 15 minutos de duración y presenta onda Q en la cara anterior.
- D) Paciente de 55 años que ingresa por dolor torácico y disnea saturando al 80% a pesar de la administración de oxígeno y con un ECG con descenso del ST en la cara anterolateral que no revierte con la administración de nitroglicerina intravenosa.

Respuesta Correcta: D





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

129. ¿Cuál de las siguientes es FALSA?

- A) En pacientes con edema agudo de pulmón en la asistencia prehospitalaria el uso de la presión positiva continua en la vía aérea con válvula de Boussignac (B-CPAP, por sus siglas en inglés) puede ser de utilidad dado que es fácil de usar, no tiene efectos secundarios, y además puede mejorar de forma más rápida los parámetros respiratorios y la oxigenación.
- B) En caso de disnea la ausencia de crepitantes y edemas periféricos descarta la existencia de insuficiencia cardiaca.
- C) La insuficiencia cardiaca es frecuente en el síndrome de tako-tsubo.
- D) La falta de adherencia al tratamiento y las infecciones son los factores desencadenantes o las causas más frecuentes de la insuficiencia cardiaca aguda.

Respuesta Correcta: B

130. Mujer de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, obesidad grado I e insuficiencia renal crónica. Se encuentra en tratamiento con enalapril 10 mg cada 12 h, furosemida 40 mg una al día, metformina 850 mg cada 12 h, simvastatina 20 mg cada 24h y lorazepam 1 mg por las noches. Acude a urgencias por empeoramiento de su disnea hasta hacerse de mínimos esfuerzos. A la exploración física destaca PA 176/98 mmHg, FC 103 lpm. Se encuentra taquipneica con tendencia al sueño y una saturación de oxígeno del 88%. A la auscultación está arritmica a 108 lpm con crepitantes bilaterales hasta campos medios. Presenta edemas en miembros inferiores. ¿Cuál de las siguientes es INCORRECTA?

- A) Debemos administrar oxigenoterapia, furosemida y nitroglicerina para el control de su disnea.
- B) Es esperable encontrar valores de NT-proBNP inferiores a 450 pg/mL dado que la paciente tiene obesidad grado I.
- C) Se debería monitorizar la función renal durante el ingreso ya que es un marcador pronóstico.
- D) No se puede descartar la presencia de síndrome de apnea del sueño como factor agravante de la disnea en esta paciente.

Respuesta Correcta: B

131. Hombre de 76 años de edad con antecedentes de insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular crónica, con disfunción sistólica severa (fracción de eyección





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

33%). Tiene una adherencia correcta a su dieta y a su tratamiento con inhibidor de enzima convertidora de la angiotensina, betabloqueante y diurético tiazídico. Pese a ello, la nieta lo trae por sus propios medios al servicio de Urgencias porque tiene disnea a moderados esfuerzos. Entra andando a la consulta de Urgencias, está hemodinámicamente estable y sin insuficiencia respiratoria y no ha evidenciado ninguna causa o factor desencadenante en la anamnesis, exploración física ni en las pruebas complementarias. ¿Cuál sería la actitud a seguir?

- A) Añadiría espironolactona y alta con seguimiento ambulatorio.
- B) Suspendería tratamiento betabloqueante durante el ingreso hospitalario.
- C) Añadiría al tratamiento amiodarona y alta con seguimiento ambulatorio.
- D) Añadiría al tratamiento verapamil y alta con seguimiento ambulatorio.

Respuesta Correcta: A

132. Mujer de 73 años de edad que ingresa por cuadro de disnea progresiva hasta hacerse de reposo, ortopnea y aumento de 4 kg de peso. En la exploración física se aprecia presión arterial de 150/84 mm Hg, frecuencia cardíaca 100 latidos/ minuto, aumento de la presión venosa yugular, crepitantes en ambas bases y edemas maleolares. Tratamiento habitual: enalapril 5 mg cada 12 horas, furosemida 80 mg al día. ¿Cuál es el plan terapéutico y destino más adecuado a seguir en el servicio de Urgencias?

- A) Administrar furosemida por vía intravenosa e ingreso hospitalario.
- B) Aumentar dosis de enalapril según tolerancia, administrar furosemida por vía intravenosa e ingreso hospitalario.
- C) Iniciar un beta-bloqueante e ingreso hospitalario.
- D) Añadir tratamiento con amlodipino y alta con seguimiento ambulatorio.

Respuesta Correcta: B

133. Paciente de 79 años, hipertenso, hiperlipidémico, diabético y con EPOC en tratamiento con anticolinérgicos inhalados. Presenta fibrilación auricular crónica en tratamiento anticoagulante con dicumarínicos. Tras un cuadro de 3 días de tos, expectoración amarilla y fiebre de 38 °C, presenta en las últimas 24 h empeoramiento progresivo con disnea de esfuerzo, ortopnea y edemas maleolares. A la exploración destaca una TA de 170/95 mmHg, disnea con frecuencia respiratoria de 20 rpm y auscultación con sibilancias bilaterales y crepitantes en





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

bases. Taquiarritmia a 110 lpm. Discretos edemas maleolares. ¿Cuál es el plan diagnóstico y terapéutico a seguir?

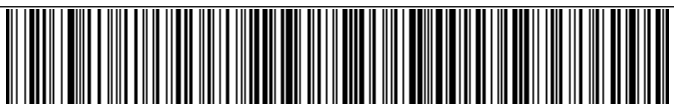
- A) El paciente probablemente presente una neumonía y lo prioritario es realizar una Rx de tórax para confirmarlo.
- B) Probablemente se trate de una agudización de su EPOC debido a una sobreinfección respiratoria. Reforzar el tratamiento de base con un beta-2 inhalado, corticoides y antibióticos y vigilar evolución.
- C) Es probable que tenga un componente de insuficiencia cardiaca izquierda asociada a una infección respiratoria febril. Sería prioritario el tratarlo con vasodilatadores y diuréticos además del tratamiento que corresponda a su infección respiratoria, broncodilatadores, etc.
- D) Un ecocardiograma sería la primera exploración a realizar para descartar un posible componente de insuficiencia cardiaca asociado al cuadro de EPOC agudizado que presenta el paciente.

Respuesta Correcta: C

134. Mujer de 80 años que es llevada al Servicio de Urgencias a las 3 de la madrugada por referir disnea de reposo de aparición súbita con tos seca y dolor torácico opresivo irradiado al cuello. Antecedentes de HTA esencial de larga evolución e infarto agudo de miocardio. A la exploración: TA 220/130 mmHg, Fc 100 lpm Fr 30 rpm. Saturación de O₂ a 70%. Auscultación: ruidos rítmicos, rápidos, con crepitantes y sibilancias generalizadas en ambos hemitórax. ECG: taquicardia sinusal a 110 lpm, con inversión de la onda T en VI-V6. Radiografía de tórax portátil: patrón en “alas de mariposa”. El péptido natriurético pro-BNP es 400 pg/ml (normal <100 pg/ml). Señale lo FALSO respecto a las medidas terapéuticas iniciales:

- A) Le colocaría ventilación no invasiva pues mejora la oxigenación, la función cardiaca y reduce la necesidad de intubación orotraqueal.
- B) Le administraría morfina porque reduce la precarga y mejora la disnea y la ansiedad.
- C) Le administraría nitroglicerina intravenosa por sus efectos venodilatadores y vasodilatadores coronarios.
- D) El nitroprusiato es el vasodilatador recomendado en esta crisis hipertensiva.

Respuesta Correcta: D





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

135. En una persona diagnosticada de insuficiencia cardiaca crónica cuál NO es un factor desencadenante de insuficiencia cardiaca aguda:

- A) Acecumarol
- B) Bisoprolol
- C) Dexametasona
- D) Ibuprofeno

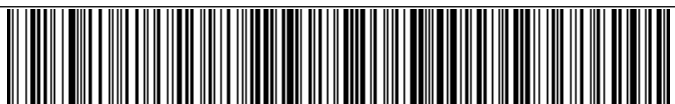
Respuesta Correcta: A

136. Paciente de 90 años controlada en domicilio con frecuentes demandas de atención domiciliaria. En esta ocasión la cuidadora avisa al teléfono 112 del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que la traslada al servicio de Urgencias hospitalario (SUH) por presentar malestar general, náuseas, pérdida de apetito, molestias abdominales inespecíficas, cansancio, ligero aumento de su disnea habitual, y detección de pulso lento al controlar la cuidadora la presión arterial en domicilio esta mañana. En el SUH se consulta en su historia clínica digital que está diagnosticada de doble lesión aórtica, fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca, isquemia por embolia en pierna izquierda e HTA. Se confirma con su cuidadora que está en tratamiento con furosemida 40 mg 2 comprimidos por las mañanas, suplementos de potasio, digoxina 5 comprimidos de 0,25 mg a la semana, bisoprolol 1.5 mg/día, acenocumarol 1 mg/día y losartan 100 mg/día. En la exploración, eupneica en reposo, saturación O2 transcutánea 95%, PA 143/58 mmHg, FC 48 latidos por minuto. Ligeros edemas maleolares, auscultación pulmonar normal, auscultación cardiaca soplo sistólico en foco aórtico. Temperatura y pulsos distales sin cambios, palpación abdominal normal. ECG: FA a 48 rvp con bigeminismo. ¿Qué resultado de laboratorio le confirmará su sospecha diagnóstica inicial?

- A) INR 3,3.
- B) Digoxinemia 4,3 ng/ml.
- C) Benzodiacepinas en orina positivo.
- D) Potasemia 4,3 mmol/ml

Respuesta Correcta: B

137. Sobre las pruebas complementarias al diagnóstico de sospecha de insuficiencia cardiaca aguda (ICA) ¿Cuál es FALSA?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) El BNP o NT-proBNP normales en las 2 primeras horas de evolución descartan el edema agudo de pulmón.
- B) Apoya el diagnóstico de insuficiencia cardiaca la existencia de derrame pleural, congestión pulmonar por líneas B de Kerley o la redistribución vascular en la radiografía de tórax, incluso en decúbito.
- C) La ecocardiografía urgente solo es necesaria si existe inestabilidad hemodinámica.
- D) El electrocardiograma difícilmente es normal en la insuficiencia cardiaca aguda y es útil para descartar fibrilación auricular rápida o síndrome coronario agudo como desencadenante de la ICA.

Respuesta Correcta: A

138. Ante un paciente con pericarditis aguda y derrame pericárdico grave ¿cuál de las siguientes medidas es INCORRECTA?

- A) Ingreso para monitorización estrecha de la aparición de signos de taponamiento.
- B) Administración de diuréticos que faciliten la desaparición del derrame.
- C) Ingreso y consideración de pericardiocentesis.
- D) Administración de antiinflamatorios no esteroideos.

Respuesta Correcta: B

139. Hombre de 45 años diagnosticado de hipertensión arterial con mal control ambulatorio, que acude al servicio de Urgencias andando y refiere fiebre de 38,8°C desde 2 días antes, dolor retroesternal intenso que se irradia al cuello y a ambos brazos, que disminuye cuando se inclina hacia delante y aumenta con el decúbito supino. En el ECG se observa elevación del segmento ST en las derivaciones I, II y AVF y de V1 a V6, sin alteración del complejo QRS. En el ecocardiograma se observa un derrame pericárdico moderado. ¿Cuál de los siguientes criterios indica mal pronóstico y aconseja el ingreso hospitalario?

- A) Curso agudo (comienzo agudo del dolor torácico).
- B) Antecedente de hipertensión arterial mal controlada.
- C) Fiebre superior a 38°C.
- D) La presencia de derrame pericárdico.

Respuesta Correcta: C





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

140. En la pericarditis aguda ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- A) El dolor torácico es agudo y punzante, mejora con la sedestación.
- B) Se puede auscultar un roce en el borde esternal izquierdo, que se aprecia mejor con el paciente en decúbito, al final de la inspiración.
- C) La presencia de fiebre superior a 38°C aconseja su ingreso hospitalario por ser un criterio de mal pronóstico.
- D) El tratamiento es ibuprofeno con dosis de carga durante dos semanas y de mantenimiento durante otras 3 semanas, asociado a colchicina con dosis de carga el primer día y de mantenimiento durante 3 meses, sin olvidar el inhibidor de la bomba de protones.

Respuesta Correcta: B

141. Le avisan desde Triage para valorar a un varón de 36 años que acude por sus propios medios al servicio de Urgencias que desde 2 días tiene dolor retroesternal intenso irradiado al cuello y a ambos brazos y la enfermera refiere que llegó asintomático con todas las constantes vitales normales pero durante la realización del electrocardiograma en la camilla le vuelve el dolor por lo que le realiza un segundo ECG y en ambos muestran una elevación del segmento ST en las derivaciones I, II y AVF y de V1 a V6, sin alteración del complejo QRS. De las siguientes indicaciones que le hace a la enfermera, ¿cuál es INCORRECTA?

- A) Administrar 600 mg de ibuprofeno oral en Triage.
- B) Administrar 1000 mg de ácido acetilsalicílico oral en Triage.
- C) Sentarlo en una silla de ruedas para valoración médica de Urgencias.
- D) Derivarlo al área de urgencias vitales.

Respuesta Correcta: D

142. Está trasladando en la ambulancia de soporte vital avanzado (ASVA) a un hombre de 45 años, con antecedentes de un cuadro febril y dolor torácico desde hace dos días que presenta disnea, buen estado de conciencia, sudoroso, Fc 132 l/min, presión arterial 82/52 mmHg, Fr 24 por min, saturación de oxígeno del 97%, ingurgitación yugular importante que aumenta con la inspiración, pulso paradójico, sin crepitantes ni sibilantes respiratorios, ruidos cardiacos disminuidos y palpación algo dolorosa en hipocondrio derecho, sin edemas periféricos. ¿Qué actuación sería INCORRECTA?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Perfundir con suero salino fisiológico al 0,9 %
- B) Administrar 20 mg de furosemida intravenosa
- C) Mantener la cabecera de la camilla de traslado erguida
- D) Administrar oxígeno

Respuesta Correcta: B

143. Acude al servicio de Urgencias hospitalario acompañado de varios familiares un hombre de 34 años, deportista, que presenta un cuadro de dolor torácico opresivo, continuo, irradiado a espalda que se acentúa con la inspiración profunda, de 4 días de evolución, sin fiebre. Refiere un cuadro de amigdalitis hace 2 meses. Tiene buen aspecto general, sin fiebre, todas las constantes vitales son normales. La auscultación cardíaca pulmonar es rítmica sin soplos y no tiene crepitantes ni sibilantes. El electrocardiograma está en ritmo sinusal a 64 rpm, con elevación cóncava del segmento ST en V3-V4, DII, DIII y aVF con descenso del intervalo PR en las mismas caras y ascenso del PR en aVR. Tras esta primera valoración debe informar al paciente y al familiar por él autorizados, de que su diagnóstico más probable, a la espera del resultado de los marcadores de lesión miocárdica, es:

- A) Infarto subagudo de miocardio anteroseptal.
- B) Angina inestable.
- C) Miocardiopatía de estrés (tako-tsubo).
- D) Pericarditis aguda.

Respuesta Correcta: D

144. En un paciente con clínica de insuficiencia cardíaca que presenta una ascitis desproporcionadamente elevada en relación al edema periférico, la etiología más probable sería:

- A) Una estenosis aórtica grave.
- B) Una miocardiopatía dilatada con disfunción ventricular izquierda significativa.
- C) Una miocardiopatía hipertrófica obstructiva.
- D) Una pericarditis constrictiva.

Respuesta Correcta: D

145. Hombre de 71 años con antecedentes personales de recambio valvular con plastia mitral por prolapso mitral hace diez años, flutter auricular que requirió





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

cardioversión hace dos años, y anemia microcítica que requirió ferroterapia unos meses antes. En tratamiento con sintrom y pantoprazol. Refiere un cuadro de pérdida de peso de 6 kg en los últimos tres meses acompañado de astenia e hiporexia con fiebre vespertina entre 37,5 °C y 38,2 °C y sudoración nocturna. En la exploración física está estable hemodinámicamente, con saturación de 97% basal y Tª de 37,9 °C. En la auscultación se aprecian tonos rítmicos con soplo sistólico en borde esternal izquierdo. El abdomen está blando y depresible, sin hepatomegalia. No tiene edemas. En la analítica de Urgencias destaca Hb 8,7 g/dL con VCM 83,2 fL, VSG 79 mm/h, ug/dL, transaminasas y LDH en rango, PCR 7,72 mg/dL (normal hasta 0,5), INR 3,4. La radiografía de tórax no tiene hallazgos de significación patológica y el TC abdominal informa que en el bazo se ve una lesión hipodensa, subcortical y con forma más o menos triangular, que sugiere como primera posibilidad un infarto esplénico. ¿Cuál de las siguientes pruebas realizarías a continuación?

- A) Una esofagogastroduodenoscopia con toma de biopsia gástrica.
- B) Un drenaje guiado por ecografía de absceso hepático.
- C) Una colonoscopia por sospecha de neoplasia de colon.
- D) Un ecocardiograma para descartar endocarditis bacteriana.

Respuesta Correcta: D

146. Sobre la endocarditis infecciosa es FALSO:

- A) La bacteriemia persistente se define con más de cultivos positivos separados por al menos 12 h o más de 3 cultivos con al menos 1 hora de diferencia o positividad del 75 % de los hemocultivos (cuando se realizan al menos 4).
- B) La evidencia de imagen compatible con afectación endocárdica en un criterio mayor de Duke.
- C) Infarto esplénico es un criterio mayor de Duke.
- D) Hemorragias subconjuntivales es un criterio menor de Duke

Respuesta Correcta: C

147. Existe indicación de implante de marcapasos en:

- A) Pacientes asintomáticos cuando la frecuencia sinusal es inferior a 50 latidos por minuto.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Presencia de bloqueo AV de primer grado asintomático cuando el PR es superior a los 200 msg.
- C) El bloqueo alternante de ramas del haz de His.
- D) Cualquier situación con bloqueo AV de segundo grado Mobitz I a nivel nodal.

Respuesta Correcta: C

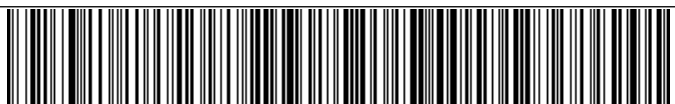
148. Un hombre de 72 años, fumador, EPOC, sin cardiopatía conocida sufre bruscamente una pérdida de consciencia mientras estaba sentado viendo la televisión. En pocos segundos el paciente recupera la consciencia. Acude a urgencias, refiriendo encontrarse bien. Al realizarse un ECG se constata un bloqueo AV 2º Mobitz II. ¿Cuál es el planteamiento más lógico o más correcto ante este paciente?

- A) Se le debería ingresar, hacerle un Holter electrocardiográfico de 24 h y en función de su resultado, decidir si ponerle un Holter insertable o un marcapasos definitivo.
- B) No requiere más estudios diagnósticos para decidir que necesita el implante de un marcapasos definitivo.
- C) Antes de continuar el estudio cardiológico se le debería hacer una RM cerebral para descartar origen neurológico.
- D) Al ser el primer episodio sincopal, bastaría con hacer un seguimiento en consulta de forma periódica.

Respuesta Correcta: B

149. Una paciente de 38 años sin antecedentes de cardiopatía ni problemas broncopulmonares conocidos acude al servicio de Urgencias por presentar palpitaciones rápidas y regulares de comienzo brusco. La TA es de 110/80 mmHg, el pulso es regular a 195 lpm y la saturación arterial de O₂, respirando aire ambiente, es de 96%. El ECG muestra una taquicardia regular de QRS estrecho a 195 lpm en la que no es discernible la onda P. ¿Cuál sería el tratamiento de primera elección?

- A) Adenosina 6 mg i.v. en bolo.
- B) Amiodarona 5 mg/kg i.v. en 30 minutos.
- C) Flecainida 2 mg/kg i.v. en 20 minutos.
- D) Cardioversión eléctrica con choque DC sincronizado de 200 Julios.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

150. Es traído al servicio de Urgencias un varón de 70 años ex-fumador con criterios de bronquitis crónica, hipertenso tratado inhibidores de la angiotensina refiriendo disnea progresiva en la última semana y ortopnea. La exploración física muestra un paciente afebril con presión arterial de 140/70 mmHg, consciente y orientado, taquipneico. La saturación de oxígeno es del 94%. Ingurgitación yugular. El pulso es rápido e irregular. La auscultación del tórax revela estertores crepitantes en ambos campos pulmonares de predominio inferior. Tonos cardiacos rápidos e irregulares sin soplos. La radiografía de tórax muestra un patrón alveolar bilateral. En el ECG de 12 derivaciones muestra una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, siendo el resto inespecífico. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción del que debe informar al paciente y al acompañante autorizado?

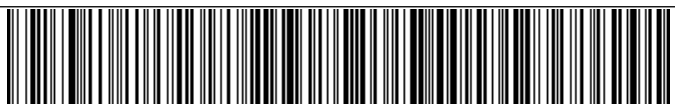
- A) Insuficiencia respiratoria crónica agudizada por sobreinfección vírica.
- B) Insuficiencia cardíaca aguda por disfunción ventricular secundaria a infarto agudo de miocardio complicado con una taquicardia ventricular.
- C) Insuficiencia cardíaca aguda secundaria a fibrilación auricular persistente.
- D) Edema agudo de pulmón secundario a miocardiopatía hipertrófica obstructiva complicada con caída en fibrilación auricular.

Respuesta Correcta: C

151. Paciente de 76 años, con hipertensión y diabetes mellitus, que acude a Urgencias porque desde hace 72 horas ha comenzado con un cuadro de palpitaciones y disminución de su capacidad para hacer esfuerzos. A su llegada se documenta una fibrilación auricular con respuesta ventricular en torno a 120 lpm. ¿Cuál de las siguientes opciones es FALSA?

- A) Este paciente debe estar anticoagulado oralmente de por vida, salvo contraindicación.
- B) Si decidimos realizar una cardioversión a su llegada a Urgencias, sería necesario hacer previamente una ecocardiografía transesofágica.
- C) Al ser el primer episodio de fibrilación auricular es el candidato idóneo para realizar una ablación con catéter.
- D) Para frenar la frecuencia cardíaca podríamos emplear betabloqueantes.

Respuesta Correcta: C





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

152. Un joven de 26 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, acude al Servicio de Urgencias por palpitaciones de algo más de una hora de duración. Está consciente y la presión arterial es de 95/60 mm de Hg. El ECG muestra una taquicardia irregular con anchura variable de los QRS y los QRS más anchos tienen en su inicio una muesca que recuerda a una onda delta. ¿Cuál de los siguientes le parece el diagnóstico más probable?

- A) Taquicardia paroxística supraventricular por reentrada intranodal.
- B) Fibrilación auricular en un paciente con síndrome de Wolf-Parkinson-White.
- C) Taquicardia ventricular.
- D) Fibrilación ventricular.

Respuesta Correcta: B

153. Ante el ECG en el que se observa una taquicardia regular de QRS ancho, a unos 220 lpm y sabiendo que corresponde a un paciente de 78 años con antecedentes de infarto anterior extenso y disfunción ventricular moderada residual, ¿cuál sería su primera sospecha diagnóstica?

- A) Taquicardia auricular.
- B) Taquicardia supraventricular por reentrada intranodal.
- C) Taquicardia ventricular.
- D) Flutter auricular atípico.

Respuesta Correcta: C

154. El paciente con ECG que muestra una taquicardia regular de QRS estrecho a unos 160 lpm, recibe un fármaco. Después de ese fármaco el segundo ECG muestra ondas P sinusales con bloqueo AV completo y latidos de escape de 2 morfologías, y posteriormente bloqueo AV 2:1. Finalmente, el tercer ECG muestra recuperación del ritmo sinusal. Esta secuencia electrocardiográfica se ha producido en 1 minuto. ¿Cuál es el fármaco administrado?

- A) Verapamilo.
- B) Atenolol.
- C) Adenosina.
- D) Digoxina.

Respuesta Correcta: C





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

155. Una mujer de 83 años alérgica a betalactámicos está en el servicio de Urgencias pendiente de ingreso en hospitalización por pielonefritis aguda y vómitos. Toma amiodarona desde hace 3 años por fibrilación auricular paroxística. Se le ha administrado levofloxacino y metoclopramida. Llegó agitada y volvió a tener otro episodio de agitación nocturna por lo que se añade haloperidol. A la mañana siguiente sufre un síncope del que se recupera a los pocos segundos. El ECG muestra ritmo sinusal a 50 lpm, QRS estrecho y QTc 510 ms. En este contexto clínico, ¿qué etiología explicaría el síncope?

- A) Una taquicardia ventricular polimorfa.
- B) Un infarto agudo de miocardio.
- C) Un ictus cardioembólico.
- D) Un bloqueo auriculoventricular completo.

Respuesta Correcta: A

156. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) Se define hipertensión arterial cuando en 3 ocasiones separadas por un intervalo superior a una semana con presión arterial sistólica mayor de 140 mmHg o con presión arterial diastólica superior a 90 mmHg.
- B) Se define hipertensión arterial con una única medición de presión arterial sistólica mayor de 210 mmHg o con presión arterial diastólica superior a 120 mmHg.
- C) Hay al menos 8 presentaciones clínicas de la urgencia hipertensiva, pero solo 1 una presentación clínica de emergencia hipertensiva.
- D) En la emergencia hipertensiva hay que reducir antes de que transcurran 2 horas la presión arterial sistólica a 160 mmHg, o con presión arterial diastólica a 100 mmHg o reducir en un 25% la presión arterial media.

Respuesta Correcta: C

157. En caso de emergencia hipertensiva ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) En la eclampsia el tratamiento hipotensor de elección es el nitroprusiato sódico intravenoso.
- B) En el ACV isquémico que va a recibir fibrinólisis la PAS debe mantenerse menor de 185 mmHg y la PAD menor de 110 mmHg.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) En el síndrome coronario agudo el tratamiento hipotensor de elección es la nitroglicerina intravenosa.
- D) En el edema agudo de pulmón el tratamiento hipotensor de elección es la furosemida y la nitroglicerina intravenosa.

Respuesta Correcta: A

158. Un hombre de 58 años, a las tres semanas de un esguince grave de tobillo presenta, de forma rápidamente progresiva, disnea de reposo, mareo y síncope. Al llegar al servicio de Urgencias hospitalario tiene hipotensión (PA sistólica 80 mmHg, diastólica 40 mmHg) y mala perfusión. Es intubado y conectado a ventilación mecánica y se inicia noradrenalina. El ecocardiograma muestra signos de hipertensión pulmonar. En la angio-TC se observan múltiples defectos de repleción ocupando ambas arterias pulmonares principales. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se asociaría a una mejoría hemodinámica más rápida en este caso?

- A) Heparina sódica en perfusión intravenosa.
- B) Tromboendarterectomía.
- C) Fibrinólisis sistémica con rt-PA (alteplase) 100 mg intravenoso.
- D) Filtro en vena cava inferior.

Respuesta Correcta: C

159. Una mujer de 59 años con antecedentes personales de cáncer de mama intervenida hace 8 meses y osteoporosis, sufre una caída y tiene una fractura de cuello de fémur derecho. Es intervenida quirúrgicamente y permanece ingresada en reposo con escayola durante 10 días. A la semana siguiente de su alta nota de forma súbita falta de aire que la lleva a consultar a su médico de cabecera que nota que su pantorrilla derecha tiene edema y dolor a la palpación. ¿Qué elementos clínicos NO serían importantes a la hora de determinar que tiene un riesgo clínico alto de padecer una tromboembolia pulmonar?

- A) El antecedente de cáncer de mama.
- B) La historia de osteoporosis.
- C) El antecedente de haber estado más de 3 días en reposo.
- D) La presencia de edema unilateral de la pantorrilla derecha.

Respuesta Correcta: B





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

160. Un hombre de 37 años sin antecedentes de interés acude a Urgencias por haber sufrido un síncope mientras caminaba. Había comenzado dos días antes con disnea de esfuerzo. Exploración: peso 75 kg, TA 75/50 mmHg. Saturación de oxígeno 89%. Auscultación pulmonar normal. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos taquicárdicos a 130 lpm. Abdomen normal. Extremidades: sin alteraciones. Hemograma: normal. Troponina: 1,2 ng/ml (normal: <0,04). ECG: Taquicardia sinusal a 130 lpm. T invertida en V1-V4. AngioTC torácica: defecto de repleción en ambas arterias pulmonares principales. Una hora después de su llegada a Urgencias persiste TA 70/55 mmHg. ¿Cuál sería el tratamiento inicial más adecuado?

- A) Heparina no fraccionada, 10000 U i.v. ante la sospecha clínica. Fibrinólisis con activador tisular del plasminógeno (tPA), 100 mg i.v., una vez confirmado el diagnóstico.
- B) Enoxaparina: 80 mg sc cada 12 horas, comenzando ante la sospecha diagnóstica.
- C) Enoxaparina: 80 mg sc cada 12 horas, comenzando tras la confirmación diagnóstica.
- D) Fondaparinux 7,5 mg sc diarios.

Respuesta Correcta: A

161. Un hombre de 78 años de edad es remitido al servicio de Urgencias hospitalario por presentar unas horas antes en su domicilio disnea de comienzo brusco. Había sido intervenido quirúrgicamente para implantación de prótesis total de cadera tres semanas antes. El paciente fue tratado con heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas hasta el alta hospitalaria. No presentaba fiebre, expectoración ni ningún otro síntoma acompañante. En la exploración física existía TA 150/90, taquicardia a 110 lat por min y taquipnea siendo el resto normal. Como único antecedente patológico cinco años antes tuvo un episodio de trombosis venosa profunda de miembro inferior derecho. ¿Cuál es la actitud inicial correcta?

- A) Se debe realizar un estudio complejo para llegar a un diagnóstico inicial, pudiendo descartar de entrada la existencia de embolia de pulmón dado que se realizó tratamiento profiláctico con heparina tras la cirugía.
- B) Aunque la probabilidad clínica de embolia de pulmón es baja debe realizarse una TC de arterias pulmonares para descartarla, antes de iniciar ningún tratamiento.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) La probabilidad clínica de embolia de pulmón es alta debiendo iniciarse tratamiento con heparina y después realizar con una TC de arterias pulmonares para confirmar el diagnóstico.
- D) El paciente probablemente padece una embolia de pulmón y debe iniciar tratamiento fibrinolítico.

Respuesta Correcta: C

162. La presencia de una presión arterial diastólica >140 mmHg con hemorragias y/o exudados retinianos y/o edema de papila es más característico de:

- A) Hipertensión arterial de inicio y se debe disminuir la presión en menos de 48 horas.
- B) Hipertensión arterial no controlada y se debe disminuir la presión en menos de 48 horas.
- C) Urgencia hipertensiva y se debe disminuir la presión en menos de 1 hora.
- D) Hipertensión arterial maligna y se debe disminuir la presión en menos de 1 hora.

Respuesta Correcta: D

163. ¿Cuál de los siguientes síntomas asociados con la hipertensión arterial tiene peor pronóstico?

- A) Pérdida brusca de fuerza de pierna y brazo derechos de 10 minutos de duración.
- B) Epistaxis de 30 minutos de duración.
- C) Cefalea nuchal vespertina.
- D) Taquicardia y temblor.

Respuesta Correcta: A

164. Señale en cuál NO sospecharía una hipertensión secundaria:

- A) Mujer de 25 años con un soplo abdominal.
- B) Hipertensión arterial con hipopotasemia en un hombre de 50 años que no toma fármacos.
- C) Mujer de 55 años con índice de masa corporal 28 y dislipemia.
- D) Mujer de 78 años que desde hace 3 meses no se controla con 3 fármacos.

Respuesta Correcta: C





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

165. Un hombre de 65 años fumador, con claudicación intermitente y al que hace un mes por hipertensión arterial le indican tratamiento con valsartán e hidroclorotiazida, acude a urgencias por malestar general, astenia, pérdida de apetito y de peso. La presión arterial es 215/105 mm Hg y no tiene edemas. La analítica sanguínea muestra hemoglobina de 10 g/dL, urea 172 mg/dL, creatinina 6,4 mg/dL, potasio 6,3 mEq/L, bicarbonato 17,2 mmol/L. En orina proteínas 75 mg/dL y sedimento normal. Una ecografía muestra riñón derecho de 10 cm y riñón izquierdo de 7 cm de longitud, ambos de contorno liso y sin dilatación pieloureteral. ¿Cuál es su actitud?

- A) Transfundir un concentrado de hematíes, indicarle dieta pobre en sal y en potasio, subir la dosis de valsartán y pedir una angioTC ambulatoriamente.
- B) Hacer un electrocardiograma, indicarle dieta pobre en sodio y en potasio, suspender valsartán e hidroclorotiazida, indicarle amlodipino y bicarbonato y pedirle un ecodoppler renal.
- C) Hacerle un electrocardiograma, indicarle dieta pobre en sodio y en potasio, subir valsartán y pedirle una TC abdominal.
- D) Bajar urgentemente la presión arterial con captopril sublingual y furosemda, pedir TC urgente y dializar al paciente.

Respuesta Correcta: B

166. ¿En cuál de las siguientes causas de fracaso renal agudo es INFRECIENTE la presencia de cilindros hemáticos en el sedimento urinario?

- A) Nefritis intersticial inmunoalérgica.
- B) Vasculitis.
- C) Glomerulonefritis IgA.
- D) Síndrome hemolítico-urémico.

Respuesta Correcta: A

167. Hombre de 35 años. Antecedentes de epilepsia y adicción a drogas no parenterales. Ingresa en Urgencias tras ser encontrado comatoso en la calle. Al ingreso estuporoso, sin focalidad neurológica. Exploración cardiovascular normal. Tensión arterial 135/78 mmHg. Dolor difuso a la compresión en miembros superior e inferior derechos, con pantorrilla derecha caliente y edematosa. Tras sondaje vesical se recuperan 200 ml de orina oscura. Analítica: hemoglobina 14,4 g/dl, 7.800 leucocitos/mm3, glucemia 68 mg/dl, urea 114 mg/dl, creatinina 4,4





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

mg/dl, calcio 7,0 mg/dl. Analítica de orina: densidad 1012, pH 5,5, proteinuria +, sedimento normal, sodio urinario 64 mmol/l. Ecografía renal normal. ¿A cuál de las siguientes pruebas o determinaciones analíticas le ve más utilidad inmediata para identificar la causa de la insuficiencia renal de este paciente?

- A) Nivel de creatinkinasa (CK) en sangre.
- B) Patrones de citolisis y colestasis hepática.
- C) Hemocultivos seriados y urocultivo.
- D) Estudio radiológico vascular, tanto de riñones como de miembro inferior derecho.

Respuesta Correcta: A

168. El patrón urinario característico de la depleción de volumen arterial efectivo con fracaso renal agudo prerrenal consiste en:

- A) Oliguria con orina concentrada y concentración de sodio alta.
- B) Oliguria con orina isotónica y sodio bajo.
- C) Diuresis conservada con osmolaridad alta.
- D) Oliguria con osmolaridad alta y sodio bajo.

Respuesta Correcta: D

169. La nefritis túbulo-intersticial aguda no parece muy frecuente pero la mayoría de sus causas son medicamentos de uso frecuente. Debe sospecharse si se presenta una insuficiencia renal, cuya causa no se identifica con alta probabilidad, en enfermos que tomen medicación. Todos los siguientes medicamentos son causa potencial de nefritis tubulointersticial, EXCEPTO:

- A) AINE.
- B) Salbutamol.
- C) Sulfamidas.
- D) Alopurinol.

Respuesta Correcta: B

170. Una paciente de 72 años fue vista en Urgencias un mes antes por caída casual y traumatismo de rodilla. Consulta de nuevo por dolor lumbar bilateral y orinas oscuras desde hace una semana. Como antecedentes destacan HTA, diabetes





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

mellitus no insulino dependiente, dislipemia, obesidad y gonartrosis. Sigue tratamiento con enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5 mg/día, naproxeno a demanda, atorvastatina 20 mg/día y metformina 850 mg/día. En la analítica de urgencia destaca: anemia microcítica moderada; CPK 45 U/L; creatinina 1,9 mg/dL; urea 75 mg/dL; Na 138 mEq/L; K 5,6 mEq/L. En la orina: microhematuria ++, proteinuria - y muy abundantes células descamativas. No se observan bacterias. En la visita anterior a Urgencias hace 1 mes, todos los parámetros eran normales. Una ecografía urgente es informada como posible necrosis papilar bilateral. ¿A qué puede deberse el cuadro actual?

- A) Fracaso renal agudo por enalapril.
- B) Progresión de una nefropatía diabética.
- C) Nefropatía por AINE.
- D) Rabdomiolisis por estatinas.

Respuesta Correcta: C

171. En cuanto a los índices urinarios en el diagnóstico del fracaso renal agudo prerrenal, indique la afirmación INCORRECTA:

- A) La osmolalidad urinaria es superior a 400 mOsm/Kg.
- B) El sodio urinario es inferior a 20 mEq/l.
- C) El índice de fallo renal (IFR) es superior a 1.
- D) La excreción fraccional de Sodio (EFNa) es inferior al 1%.

Respuesta Correcta: C

172. En una paciente con artritis reumatoide en tratamiento con metotrexate, prednisona e indometacina que presenta de forma aguda edemas y aumento de la creatinina plasmática con un sedimento de orina poco expresivo y proteinuria escasa la causa más probable es:

- A) Amiloidosis renal.
- B) Glomerulonefritis secundaria a la artritis reumatoide.
- C) Insuficiencia renal por antiinflamatorios no esteroideos.
- D) Nefritis intersticial por metotrexate.

Respuesta Correcta: C





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

173. Sospecharemos insuficiencia renal aguda de origen pre-renal en presencia de:

- A) Hipotensión, elevación de las cifras de urea y creatinina sérica, osmolaridad en orina inferior a 500 mOsm/kg y excreción fraccional de sodio superior a 1%.
- B) Intolerancia digestiva, elevación de las cifras de urea y creatinina séricas, osmolaridad en orina superior a 500 mOsm/kg y excreción fraccional de sodio inferior a 1%.
- C) Administración intravenosa previa de contraste iodado, elevación de las cifras de urea y creatinina séricas, osmolaridad en orina inferior a 500 mOsm/kg y excreción fraccional de sodio superior a 1%.
- D) Administración previa de un antibiótico aminoglucósido, elevación de las cifras de urea y creatinina séricas e isostenuria.

Respuesta Correcta: B

174. Mujer de 37 años sin otros antecedentes de interés que una apendicectomía. Acude a urgencias por dolor en fosa renal derecha de 3 días de evolución y fiebre de 39°C. En la analítica destaca leucocitosis ($14 \times 10^3/\mu\text{L}$ con neutrofilia) y proteína C reactiva 15 mg/dL. El sistemático de orina muestra hematuria microscópica, leucocituria y piuria significativas. Ingresa con el diagnóstico de pielonefritis aguda y se inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona intravenosa. Tres días después persiste fiebre de 38,5°C, aumento de la leucocitosis y deterioro de la función renal. Teniendo en cuenta la sospecha diagnóstica, ¿qué prueba solicitaría a continuación?

- A) Tomografía axial computarizada con contraste intravenoso.
- B) Urografía intravenosa.
- C) Resonancia magnética nuclear abdominal.
- D) Ecografía urológica.

Respuesta Correcta: D

175. Una mujer de 25 años de edad, sin antecedentes patológicos destacables, acude a urgencias refiriendo disuria, polaquiuria, tenesmo y urgencia miccional. Niega tener flujo vaginal. Hace tres días había regresado de su luna de miel. En la exploración está con buen estado general y afebril. Se realiza una prueba de orina mediante una tira reactiva que muestra nitritos positivos y un test de embarazo que resulta negativo. ¿Cuál es la actitud adecuada a seguir?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Solicitar un cultivo de orina y diferir el inicio del tratamiento antibiótico hasta tener el resultado definitivo.
- B) Solicitar un cultivo de orina e iniciar a continuación el tratamiento antibiótico empírico ambulatorio hasta tener el resultado definitivo.
- C) Debe considerarse el tratamiento empírico de la paciente y su pareja.
- D) No solicitar ningún estudio más e iniciar el tratamiento antibiótico empírico ambulatorio.

Respuesta Correcta: D

176. Hombre de 35 años que acude a urgencias por cuadro de 48 horas de evolución de fiebre de 39 °C, tiritona, mal estado general, polaquiuria, disuria, tenesmo vesical y dolor perianal. En la analítica presenta valores de creatinina de 0,9 mg/dL, procalcitonina de 1,5 ng/mL, leucocitos de 20.000/uL y PSA de 45 ng/mL. ¿Cuál es la actitud a seguir en este paciente?

- A) Sueroterapia, antitérmicos, toma de urocultivo, antibioterapia y TC toracoabdominal.
- B) Sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia previa a la realización de biopsia prostática.
- C) Sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia durante tres semanas y repetir niveles de PSA en tres meses.
- D) Sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia. Solicitar niveles de fosfatasa ácida prostática.

Respuesta Correcta: C

177. Una mujer acude a urgencias tres días después de ser sometido a litotricia extracorpórea por ondas de choque sobre un cálculo de 2,1 cm de diámetro máximo situado en el riñón izquierdo. Presenta mal estado general, dolor en fosa renal izquierda, náuseas y fiebre de 39,2 °C. Se realiza Rx simple en la que se aprecian varios cálculos, de pequeño tamaño, en el área del uréter distal izquierdo. El radiólogo nos informa de que en la ecografía observa la existencia de dilatación grado II pielocalicial izquierda. El siguiente paso debe ser:

- A) Ureteroscopia de urgencia dada la existencia de uropatía obstructiva de causa litiásica.
- B) Ingreso con hidratación intravenosa, así como tratamiento antibiótico, dada la sospecha de infección urinaria.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) Derivación urinaria urgente (cateterismo ureteral o nefrostomía percutánea) dada la sospecha de uropatía obstructiva complicada.
- D) Nueva sesión de litotricia extracorpórea por ondas de choque, previo tratamiento sintomático del paciente con antiinflamatorios, tratamiento antibiótico e hidratación intravenosa.

Respuesta Correcta: C

178. ¿Cuál de los siguientes factores NO favorece el desarrollo de pielonefritis aguda?

- A) Nefrolitiasis.
- B) Riñón de herradura.
- C) Quiste renal simple.
- D) Tumor de urotelio.

Respuesta Correcta: C

179. En la relación con la nefrolitiasis señale la respuesta FALSA:

- A) Las litiasis de ácido úrico responden bien a la alcalinización de la orina.
- B) La litotricia extracorpórea por ondas de choque es el método elegido para el tratamiento de la mayoría de los cálculos no expulsables, sobre todo, en los casos de pionesfrosis.
- C) La nefrolitiasis es la causa más frecuente de obstrucción urinaria en el varón joven.
- D) La eliminación de dos cálculos menores de 5 mm es espontánea en el 80% de los casos.

Respuesta Correcta: B

180. Hombre de 28 años de edad que acude a urgencias del hospital por presentar hematuria macroscópica. ¿Cuál de las siguientes alteraciones en el análisis de orina apoyaría el diagnóstico de glomerulonefritis?

- A) Hematíes dismórficos y/o cilindros hemáticos.
- B) Proteinuria de 1 g/día, con resultado negativo en tira reactiva y con microalbuminuria mayor de 300 mg/24 horas.
- C) Coexistencia de hematuria con piuria sin bacteriuria.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Coágulos en la orina a simple vista.

Respuesta Correcta: A

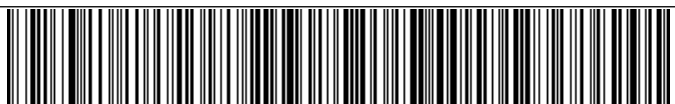
181. Varón de 79 años, exfumador, sin otros factores de riesgos cardiovasculares, presenta desde hace cuatro días edemas que empeoran a lo largo del día, localizados en cara, miembros inferiores y genitales y ahora acude por intolerancia digestiva y dolor en miembro inferior izquierdo donde presenta un eritema, caliente y doloroso en su pantorrilla. Buen estado general, edematoso, con edemas que dejan fovea en miembros inferiores, Tª 37°C, TA 145/90, FC 80, FR 22, SatO2 basal a 95%, tolera el decúbito, sin ingurgitación yugular, tonos cardiacos rítmicos, sin soplos, murmullo vesicular sin crepitantes ni sibilancias, abdomen no doloroso y sin ascitis, pulsos periféricos difíciles de explorar y se marca eritema de 10 cm x10 cm en área gemelar izquierda. En la tira de orina se aprecian 4 + para proteínas, cilindruria sin hematuria. El ECG está en ritmo sinusal a 80 rpv, sin alteraciones. La creatinina e iones séricos están en rango normal. En espera de completar el estudio, de entre las siguientes medidas del tratamiento precoz en Urgencias, ¿cuál es INCORRECTA?

- A) Dieta con restricción hídrica a 1.000 ml/día, hiposódica inferior a 2-3 g/día, normoproteica e hipercalórica.
- B) Dieta con restricción hídrica a 1.000 ml/día, hiposódica inferior a 2-3 g/día, hipoproteica (30 g/día).
- C) Mantener la TA por debajo de 130/80 mmHg con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o con antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARAI)
- D) Furosemida 20 mg/6 h hasta un máximo de 250 mg/día.

Respuesta Correcta: B

182. El síndrome NEFRÍTICO agudo independientemente del proceso etiológico (infeccioso, metabólico, tóxico o secundario a enfermedades sistémicas) que desencadene la glomerulonefritis aguda de entre las siguientes medidas del tratamiento precoz en Urgencias, ¿cuál es INCORRECTA?

- A) Reposo en cama en la fase aguda, dieta baja en proteínas, baja en sodio <2-3 g de sal al día.
- B) Ingesta hídrica 1500-2000 cc/día.
- C) Furosemida 20 mg/6 h hasta un máximo de 250 mg/día.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- D) Control de la hipertensión arterial con IECA si no se controla con furosemida y no hay insuficiencia renal.

Respuesta Correcta: B

183. En la uropatía obstructiva, señale la FALSA:

- A) Ante un globo vesical se sigue practicando el vaciado gradual de la vejiga, aunque no existen estudios que apoyen la realización de una descompresión gradual al vaciar la vejiga.
- B) La dificultad para la eliminación total o parcialmente de la orina en una mujer no es frecuente la presencia de tumor uterino, cervical u ovárico.
- C) La uropatía obstructiva es más común en los hombres, sobre todo después de los 60 años de edad, por la alta prevalencia de hiperplasia benigna y cáncer de próstata.
- D) En la uropatía obstructiva el dolor frecuentemente está ausente, incluso en la obstrucción aguda, excepto si hay distensión de la vejiga, infección, litiasis o masas.

Respuesta Correcta: B

184. Hombre de 57 años, exfumador, con antecedentes de pancreatitis aguda alitiásica, gastritis crónica por AINES y disfunción eréctil en tratamiento con pantoprazol y sildenafil. Consulta por dolor torácico opresivo a las 7:30 h a.m. mientras se encontraba en reposo. PA 148/82 mmHg, FC 85 lpm, SatO2 de 98% basal. AC: rítmico, sin soplos. AP: murmullo vesicular conservado. No edemas, pulsos presentes y simétricos. ECG: ritmo sinusal y elevación del segmento ST y onda Q en DII, DIII, aVF, con descenso de ST V2-V4, DI-aVL. ¿Cuál de los siguientes fármacos está CONTRAINDICADO en este paciente?

- A) Morfina.
- B) Dinitrato de isosorbida.
- C) Atenolol.
- D) Meperidina.

Respuesta Correcta: B

185. En el síndrome escrotal agudo, ¿qué afirmación de las siguientes es FALSA?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) La torsión testicular es una emergencia médica que es indicación de tratamiento quirúrgico antes de las 4 a 6 horas del inicio del dolor.
- B) La torsión de apéndice testicular (hidátide de Morgagni) es una urgencia quirúrgica de la hidátide trombosada.
- C) El procedimiento quirúrgico en la torsión testicular en testículo viable es la orquidopexia bilateral y en testículo no viable es la orquiectomía ipsilateral con orquidopexia contralateral.
- D) La detorsión testicular manual en sentido lateral provoca alivio instantáneo del dolor.

Respuesta Correcta: B

186. Un varón de 16 años con dolor testicular izquierdo de inicio súbito en la madrugada, por vergüenza no avisa antes a sus padres, pero que inmediatamente lo traen al servicio de Urgencias después de 8 horas de inicio del dolor sin fiebre ni clínica miccional previa. Impresiona de dolor, nauseoso, camina despacio arrastrando la pierna izquierda. En bipedestación se observa el teste izquierdo ascendido y horizontalizado y epidídimo en posición anterior (signo de Gouverneur), el reflejo cremastérico está abolido y el signo de Prehn aumenta desproporcionadamente el dolor. La detorsión testicular izquierda en sentido lateral alivia el dolor, pero al incorporarse por una arcada se reproduce el dolor. ¿Cuál de las siguientes actuaciones es la más CORRECTA?

- A) Avisar inmediatamente a Urología a pesar de llevar más de 6 horas de inicio del dolor.
- B) Solicitar una ecografía doppler porque existe duda diagnóstica.
- C) Administrar ceftriaxona 1 g i.m. en dosis única.
- D) Colocar suspensorio.

Respuesta Correcta: A

187. En el manejo de la hematuria en Urgencias, señale la FALSA:

- A) En caso de hematuria leve o escasa con proteinuria, cilindruria en principio debe realizarse interconsulta a Nefrología, sobre todo, si hay edemas o hipertensión arterial.
- B) En la hematurias leves-moderadas, monosintomáticas, sin grandes coágulos y estables hemodinámicamente, se deberá evitar el sondaje vesical.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) En los casos en los que sea necesario realizar sondaje vesical durante 4-5 días no se recomienda el uso de antibioterapia profiláctica.
- D) En la hematuria abundante sin coágulos no se recomienda el lavado continuo vesical con suero fisiológico.

Respuesta Correcta: D

188. Sobre la hematuria, ¿qué es FALSO?

- A) En la uretrorragia la expulsión de la sangre coincide con la micción.
- B) La hematuria macroscópica de color marrón o coñac sufre origen glomerular.
- C) Cuando la tira de orina mostrará sangre positiva pero no encontraremos hemáties en el sedimento sugiere hemólisis o rhabdomiólisis.
- D) La causa más frecuente de hematuria en los varones de edad media (40-60 años) es el tumor vesical, seguido de litiasis e infecciones.

Respuesta Correcta: A

189. En el síndrome del cascanueces todo es cierto, EXCEPTO:

- A) En la variante anterior la compresión de la vena renal izquierda se produce entre la arteria aorta y la arteria mesentérica superior; y en la variante posterior la compresión de la vena renal izquierda se produce entre la arteria aorta y el cuerpo de la vértebra.
- B) Se manifiesta por hematuria macroscópica, sobre todo después de permanecer en bipedestación o tras el ejercicio.
- C) Entre sus manifestaciones no incluye la proteinuria ortostática.
- D) Entre sus manifestaciones incluye el varicocele izquierdo asintomático.

Respuesta Correcta: C

190. Hombre de 60 años de edad que acude a urgencias por presentar hematuria macroscópica asintomática. ¿En qué patología deberíamos pensar en primer lugar?

- A) Hiperplasia benigna de próstata.
- B) Carcinoma de próstata.
- C) Carcinoma vesical.
- D) Litiasis renal.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: C

191. La citología de orina es una prueba útil para el diagnóstico de:

- A) Carcinoma vesical y tumor del tracto urinario superior.
- B) Adenocarcinoma de próstata.
- C) Hiperplasia benigna de próstata.
- D) Tumor de testículo.

Respuesta Correcta: A

192. En relación a los cuerpos extraños en el esófago, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto?:

- A) El bolo alimentario es la causa más frecuente de obstrucción esofágica en los países occidentales.
- B) En ocasiones puede realizarse un estudio con bario para objetivar el nivel de la impactación.
- C) En ocasiones se puede diferir la extracción del cuerpo extraño vía endoscópica 24 horas.
- D) La extracción endoscópica de las pilas de botón se recomienda realizarla de forma inmediata por el alto riesgo de perforación.

Respuesta Correcta: B

193. En el tratamiento de la encefalopatía hepática, ¿cuál de las siguientes no es una medida general de su tratamiento?

- A) Asegurar la vía aérea, con aspiración de secreciones y administración de oxigenoterapia.
- B) Corregir las alteraciones iónicas y del equilibrio ácido- base.
- C) Mantener condiciones adecuadas de hidratación, vigilando el deterioro de la función renal.
- D) En caso de agitación, contener al paciente con el uso de sedantes tipo benzodiacepinas, para evitar lesiones.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

194. Ante la sospecha de una perforación esofágica, ¿cuál de los siguientes ítems es incorrecto?

- A) El TAC es la técnica de elección diagnóstica.
- B) Cuando exista sospecha clínica y resto de pruebas normales, debemos realizar una endoscopia digestiva alta para confirmar el diagnóstico.
- C) El síndrome de Boerhaave es una posible causa.
- D) La radiografía con contraste hidrosoluble (gastografía), puede resultar útil para localizar el lugar y la extensión de la perforación.

Respuesta Correcta: B

195. Señale de entre las siguientes exploraciones complementarias en el diagnóstico de una perforación esofágica, cuál está contraindicada:

- A) Radiografía de contraste soluble (gastografía).
- B) Radiografía anteroposterior y lateral cervical.
- C) Tomografía computarizada.
- D) Endoscopia digestiva alta.

Respuesta Correcta: D

196. Ante un paciente inmunodeprimido con clínica de odinofagia intensa, pirosis, e incluso disfagia a sólidos y parcialmente a líquidos, que en endoscopia digestiva alta presenta hallazgos de úlceras en pared de esófago en sacabocados, ¿el germen más frecuente implicado será?

- A) *Cándida albicans*
- B) *Pneumocystis*
- C) Citomegalovirus
- D) Virus herpes simple tipo 1

Respuesta Correcta: C





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

197. ¿Cuál de los siguientes no es un factor desencadenante de encefalopatía hepática?

- A) Tratamiento con diuréticos tiazídicos
- B) Tratamiento con diuréticos de asa
- C) Administración de sedantes como benzodiazepinas
- D) Tratamiento con diuréticos ahorradores de potasio

Respuesta Correcta: D

198. ¿Cuál de los siguientes datos clínicos NO es característicos de la encefalopatía hepática grado II?

- A) Desorientación temporal, bradipsiquia o disartria
- B) Fetor hepático y asterixis (Siempre presente en este estadio)
- C) Cambios en la personalidad o disminución de la memoria.
- D) Rigidez involuntaria al realizar movimientos pasivos, hiperreflexia y clonus, así como signos de Babinski positivo.

Respuesta Correcta: D

199. El tratamiento de elección de la esofagitis esofágica candidiásica es:

- A) Fluconazol, 400 mg/8h durante 5 días
- B) Fluconazol, 1200 mg/24h durante 7 días
- C) Fluconazol, 400 mg en dosis única
- D) Fluconazol, en dosis inicial de 400 mg/24 horas vía oral o intravenoso, 1 día, seguido de 200- 400 mg/vía oral durante 2- 3 semanas

Respuesta Correcta: D

200. ¿Cuál de los siguientes es un fármaco utilizado en el tratamiento hemostático de la hemorragia por varices esofágicas?

- A) Terlipresina





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Dopamina
- C) Dobutamina
- D) Noradrenalina

Respuesta Correcta: A

201. Varón de 25 años que acude al Servicio de urgencias tras una ingesta etílica importante con vómitos, los últimos hemáticos. A su llegada TA 120/60, FC 90 lpm. Su diagnóstico más probable es:

- A) Síndrome de Mallory- Weiss.
- B) Úlcera péptica.
- C) Úlcera Curling.
- D) Divertículo Meckel.

Respuesta Correcta: A

202. En la valoración en el servicio de urgencias hospitalario de un paciente con dolor abdominal agudo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- A) El inicio, la localización y severidad del dolor son útiles en el diagnóstico diferencial.
- B) La palpación es el aspecto más importante de la exploración física.
- C) La ecografía es una prueba de imagen útil y cada vez más utilizada en el diagnóstico del dolor abdominal.
- D) No debe administrarse medicación analgésica hasta que el cirujano valore al paciente porque puede enmascarar el diagnóstico.

Respuesta Correcta: D

203. Al valorar el dolor abdominal en el anciano en urgencias, todo lo siguiente es cierto, excepto:

- A) Hasta un 40% de los pacientes mayores de 65 años necesitan cirugía.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Debemos de considerar la posibilidad de una isquemia mesentérica cuando hay un dolor desproporcionado frente a los hallazgos en la exploración física.
- C) Se deben limitar los estudios de imagen.
- D) No es recomendable achacar el vómito o la diarrea a una probable gastroenteritis.

Respuesta Correcta: C

204. ¿Cuál de los siguientes parámetros analíticos nos permitiría diferenciar si el sangrado digestivo es de origen alto o bajo?

- A) Valor del hematocrito.
- B) Estudio de coagulación.
- C) Fracción excreción de sodio
- D) Cociente urea/creatinina.

Respuesta Correcta: D

205. ¿Cuál de las siguientes puede ser causa de Pseudohematemesis?

- A) Ingesta de ácido acetilsalicílico
- B) Ingesta de espinacas
- C) Ingesta reciente de vino tinto
- D) Ingesta de regaliz

Respuesta Correcta: C

206. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto con respecto a la isquemia mesentérica?

- A) Es más frecuente el sexo masculino
- B) Debe sospecharse en personas de edad avanzada, con personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) La exploración física inicialmente puede ser anodina, con simplemente un abdomen distendido, con timpanismo difuso y ausencia de signos de irritación peritoneal
- D) Se caracteriza clínicamente por un dolor abdominal difuso, inicialmente de carácter cólico y luego continuo, que puede estar acompañado de náuseas o vómitos, así como hematoquecia o melenas.

Respuesta Correcta: A

207. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en un paciente de 70 años, con antecedentes de Hipertensión arterial, que acude a urgencias por un dolor abdominal de inicio brusco, localizado en fosa renal derecha, con EVA 9, acompañado de sudoración y frialdad e hipotensión?

- A) Isquemia mesentérica
- B) Cólico renoureteral derecho
- C) Aneurisma de aorta abdominal
- D) Pancreatitis aguda

Respuesta Correcta: C

208. ¿Qué origen más probable tendrá un dolor que irradia hacia la espalda y la raíz de los muslos?

- A) Aórtico
- B) Biliar
- C) Pancreático
- D) Irritación del nervio frénico

Respuesta Correcta: A

209. Con respecto a la terapia cuádruple sin bismuto para el tratamiento erradicador del *Helicobacter Pylori*, ¿Qué dosis es incorrecta?

- A) Pantoprazol 40 mg cada 12 horas durante 14 días





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Claritromicina 500 mg cada 12 horas durante 14 días
- C) Amoxicilina 875 mg cada 8 horas durante 14 días
- D) Metronidazol 500 mg cada 12 horas durante 14 días

Respuesta Correcta: C

210. Señale la Respuesta Correcta respecto al tratamiento de la colitis pseudo-membranosa por *Clostridium difficile*:

- A) Los agentes probióticos son el tratamiento de elección de la colitis pseudomembranosa.
- B) En el tratamiento de esta enfermedad están indicados los opiáceos
- C) El tratamiento antibiótico para la colitis pseudomembranosa es la azitromicina en dosis única de 1 g por vía oral.
- D) En el tratamiento antibiótico en cuadros de colitis pseudomembranosa de mayor gravedad pue-de utilizarse metronidazol o vancomicina oral.

Respuesta Correcta: D

211. ¿En cuál de los siguientes microorganismos pensaría, si un paciente presentara una diarrea con moco, sangre y pus?

- A) Salmonella.
- B) Shigella.
- C) Escherichia coli enterotoxigénica.
- D) Virus.

Respuesta Correcta: B

212. ¿Cuál de las siguientes no es una complicación del síndrome emético?

- A) Síndrome de Boerhaave
- B) Síndrome de Mallory- Weiss
- C) Acidosis metabólica





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Hipopotasemia

Respuesta Correcta: C

213. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es característico del síndrome diarreico por Cólera?

- A) Los fármacos antiseoretos, como el racecadotriilo, no son útiles en las formas graves.
- B) Suelen cursar con diarrea acuosa profusa como “agua de arroz”, vómitos, mialgias, rápida deshidratación y fiebre elevada.
- C) Las heces contienen mucosidad y escaso material sólido, con un olor característico a pescado.
- D) En su tratamiento tienen cabida diferentes pautas antibióticas, como: Azitromicina 1 gramo en dosis única; Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas durante 3 días o Doxiciclina 300 mg en dosis única

Respuesta Correcta: B

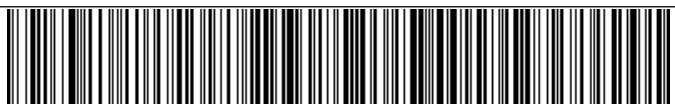
214. ¿Cuál de las siguientes características NO es propia de la colitis ulcerosa?

- A) Mayor incidencia durante la tercera y cuarta década de la vida.
- B) Habitualmente comienza afectando al recto
- C) Es frecuente la emisión anal de pujos de moco y sangre reiterados
- D) Afecta a toda la pared intestinal de manera segmentaria.

Respuesta Correcta: D

215. ¿Cuál de las siguientes características NO es propia de la Enfermedad de Crohn?

- A) No son frecuentes los síntomas de afectación sistémica.
- B) Suele iniciarse entre los 15 y los 40 años
- C) Afecta con más frecuencia al intestino delgado
- D) La clínica incluye diarrea de más de 6 semanas y no suele contener sangre





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

216. ¿Cuál es el tratamiento de elección en los brotes moderados de colitis ulcerosa extensa y distal?

- A) Vedolizumab
- B) Anticuerpos antifactor de necrosis tumoral
- C) Ustekinumab
- D) Mesalazina

Respuesta Correcta: D

217. ¿Cuál de los siguientes fármacos está formalmente contraindicado en una mujer embarazada con enfermedad inflamatoria intestinal?

- A) Prednisona
- B) Mesalazina
- C) Metrotexato
- D) Azatioprina

Respuesta Correcta: C

218. ¿Cuál de los siguientes NO se considera un criterio diagnóstico del Megacolon tóxico?

- A) Evidencia radiológica de dilatación colónica
- B) Fiebre mayor de 38°C
- C) Leucopenia (<4000/microl)
- D) Deshidratación

Respuesta Correcta: C

219. ¿Cuál sería el tratamiento inicial de un brote leve y moderado de enfermedad de Crohn de íleon terminal y colon derecho?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Prednisona
- B) Mesalazina
- C) Budesonida
- D) Azatioprina

Respuesta Correcta: C

220. Ante un caso clínico con el diagnóstico de obstrucción intestinal, ¿cuál es la exploración complementaria a la que hay que recurrir para confirmar el diagnóstico?

- A) TC de abdomen en decúbito lateral o supino.
- B) Ecografía abdominal en bipedestación y/o decúbito supino.
- C) Resonancia magnética abdominal
- D) Radiografía simple de abdomen en bipedestación

Respuesta Correcta: D

221. ¿Cuál sería el hallazgo característico en la Radiografía simple de abdomen de un posible vólvulo intestinal?

- A) Signo del asa centinela
- B) Signo del pseudotumor o grano de café
- C) Presencia de aerobilia
- D) Presencia de niveles hidroaéreos de localización central abdominal.

Respuesta Correcta: B

222. Varón de 80 años con antecedentes personales de cardiopatía, arterosclerosis y fibrilación auricular. Consulta por dolor abdominal intenso, rectorragia, regular estado general con sudoración y dolor precordial. La colonoscopia demuestra la presencia de sangre roja en todo el colon izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- A) Colitis ulcerosa.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Angiodisplasia de colon.
- C) Colitis pseudomembranosa.
- D) Colitis isquémica.

Respuesta Correcta: D

223. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto con respecto a la hemorragia digestiva baja (HDB)?

- A) Supone del 25-40% del total de las hemorragias digestivas.
- B) La HDB aguda suele ser mejor tolerada que la hemorragia digestiva alta y tiene mejor mortalidad.
- C) Puede presentarse en forma de melenas.
- D) Una HDB causada por enfermedad diverticular suele acompañarse de dolor abdominal intenso.

Respuesta Correcta: D

224. Ante un varón joven que acude por hematoquecia, con estabilidad hemodinámica, con buen estado general, sin fiebre, ¿sospecharíamos como primera posibilidad?

- A) Divertículo de Meckel.
- B) Enfermedad inflamatoria intestinal.
- C) Diverticulitis aguda.
- D) Angiodisplasia de colon.

Respuesta Correcta: A

225. Con respecto a las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja según la edad, indique la opción correcta:

- A) La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en adultos mayores de 60 años es la enfermedad inflamatoria intestinal crónica.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Las causas más frecuentes, independientemente de la edad, son las hemorroides y las fisuras anales.
- C) En adolescentes y adultos jóvenes, la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es la angiodisplasia colónica.
- D) En adultos mayores de 60 años, la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es la enfermedad diverticular.

Respuesta Correcta: B

226. ¿En cuál de las siguientes circunstancias está indicada la antibioterapia en la obstrucción intestinal?

- A) Íleo paralítico.
- B) En toda obstrucción intestinal.
- C) Íleo espástico.
- D) En la obstrucción intestinal con sospecha de afectación vascular.

Respuesta Correcta: D

227. ¿Cuál de las siguientes no es una causa de obstrucción intestinal mecánica?

- A) Obstrucción de la luz intestinal por cálculos biliares.
- B) Diverticulitis aguda
- C) Isquemia intestinal
- D) Adherencias postquirúrgicas

Respuesta Correcta: C

228. Señale la opción correcta con respecto a la Apendicitis aguda

- A) Nunca origina estreñimiento
- B) Generalmente los vómitos preceden al dolor abdominal
- C) En todos los casos aparece leucocitosis





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- D) La migración del dolor desde el epigastrio a la fosa iliaca derecha es muy característica

Respuesta Correcta: D

229. En cuanto a la clasificación de las hemorroides, ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto?

- A) Las hemorroides grado I corresponden a aquellas que no prolapsan a través del canal anal.
- B) Las hemorroides grado II corresponden a aquellas que prolapsan con la defecación, pero se reducen de forma espontánea.
- C) Las hemorroides grado III corresponden con aquellas que prolapsan con la defecación y se reducen manualmente.
- D) Las hemorroides grado IV con aquellas que han sufrido algún tipo de complicación (trombosis hemorroidal, sangrado rectal, etc.).

Respuesta Correcta: D

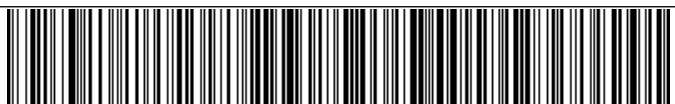
230. ¿Cuál es la causa más frecuente de Hemorroides?

- A) Cirrosis hepática
- B) Embarazo
- C) Estreñimiento
- D) Idiopática

Respuesta Correcta: D

231. Señale lo correcto en relación con el sangrado hemorroidal:

- A) Se manifiesta como hematoquecia
- B) El prurito no forma parte de los síntomas
- C) La sangre se expulsa al final de la deposición
- D) Siempre que existe sangrado hemorroidal, existe trombosis hemorroidal





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: C

232. Señale la respuesta incorrecta con respecto a la Diverticulitis aguda:

- A) El dolor se localiza en la fosa iliaca izquierda
- B) Es frecuente en mujeres mayores de 60 años
- C) Ante la sospecha clínica, se debe realizar un TAC abdominal urgente, incluso en pacientes que se han dado de alta recientemente con dicho diagnóstico
- D) Siempre se debe prescribir tratamiento antibiótico

Respuesta Correcta: D

233. Señale la opción correcta sobre la diverticulitis aguda del colon sigmoideo:

- A) Es más frecuente en varones menores de 45 años
- B) El dolor se localiza en fosa iliaca derecha
- C) El dolor suele empeorar con la defecación
- D) Nunca cursa con diarrea

Respuesta Correcta: C

234. Señale la INCORRECTA con respecto a las Hernias abdominales:

- A) La hernia abdominal complicada suele manifestarse como una obstrucción intestinal.
- B) En todo paciente con obstrucción intestinal es obligado explorar la posible existencia de hernias complicadas
- C) En la hernia estrangulada, se produce un daño vascular inicialmente arterial y luego venoso.
- D) En Hernia de Richter, se produce una afectación parcial del asa intestinal, que permite el tránsito, evolucionando de forma más tórpida

Respuesta Correcta: C





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

235. ¿Cuál es el tratamiento de elección de los abscesos de la región anorrectal en su fase de absceso?

- A) Antiinflamatorios no esteroideos
- B) Ciprofloxacino + Metronidazol
- C) Amoxicilina- ácido clavulánico
- D) Desbridamiento y drenaje quirúrgicos

Respuesta Correcta: D

236. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre el prolapso rectal es incorrecto?

- A) Es frecuente la estrangulación por prolapso irreductible
- B) La reducción con sedación suele ser efectiva, pudiendo demorar el tratamiento quirúrgico definitivo
- C) Se exterioriza la pared completa, donde son evidentes los anillos de la mucosa colónica
- D) De aparecer estrangulación, esta debe tratarse mediante el procedimiento de Altemeier (resección perineal del rectosigma)

Respuesta Correcta: A

237. Unas hemorroides internas que prolapsan por el orificio anal con la defectación y requieren reducción manual se corresponde con un grado:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV

Respuesta Correcta: C

238. Con respecto a la pancreatitis aguda, todo es cierto menos:

- A) La mayoría de los casos están producidos por litiasis biliar.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) La mortalidad por pancreatitis grave puede alcanzar hasta el 50%.
- C) La amilasa puede ser normal hasta en el 10% de los casos.
- D) La pancreatitis aguda leve puede tratarse de forma ambulatoria, sin ingreso.

Respuesta Correcta: D

239. Con respecto al tratamiento de la pancreatitis aguda, señale la respuesta incorrecta:

- A) Reposo digestivo
- B) Tratamiento analgésico que sea necesario, incluyendo opioides menores o mayores vía parenteral si fuera necesario.
- C) Administración de inhibidores de la bomba de protones para profilaxis de hemorragia digestiva.
- D) Profilaxis antibiótica si existe evidencia de pancreatitis aguda necrosante

Respuesta Correcta: D

240. Respecto a la ascitis, señale la Respuesta Correcta:

- A) Se denomina ascitis a la acumulación de líquido serofibrinoso libre en la cavidad peritoneal en cantidad superior a 100 ml.
- B) La dosis de albúmina recomendada al realizar una paracentesis evacuadora es de un vial de 50 ml (10 g) por cada 1.5 litros de líquido ascítico extraído.
- C) La administración de aminoglucósidos no está contraindicada en la peritonitis bacteriana espontánea.
- D) La cuantía de líquido ascítico evacuado no debe superar los 5 litros, para evitar disfunciones hidroelectrolíticas.

Respuesta Correcta: B

241. En pacientes con ictericia es aconsejable el ingreso hospitalario en las siguientes circunstancias, excepto en:

- A) Encefalopatía hepática.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Sepsis de cualquier localización.
- C) Hepatitis aguda con actividad protrombótica inferior al 50%.
- D) Enfermedad de Gilbert.

Respuesta Correcta: D

242. ¿Cuál no es una causa de aumento de hiperbilirrubinemia de predominio indirecto?

- A) Cirrosis biliar primaria.
- B) Enfermedad de Gilbert
- C) Sepsis
- D) Hemolisis

Respuesta Correcta: A

243. Todas las siguientes son causas de hiperamilasemia, excepto:

- A) Rotura de embarazo ectópico
- B) Parotiditis
- C) Tratamiento con opioides
- D) Administración de contrastes iodados

Respuesta Correcta: D

244. ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecográficos esperaría encontrar en una colecistitis aguda?

- A) Presencia de barro biliar
- B) Engrosamiento de la pared vesicular >6 mm
- C) Signo Cullen positivo
- D) Dilatación de la vía biliar intrahepática

Respuesta Correcta: A





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

245. Señale la incorrecta con respecto al síndrome hepatorenal

- A) Complicación grave que puede aparecer en paciente con cirrosis y ascitis
- B) El tratamiento de elección es el trasplante hepático
- C) La lesión renal que se produce es de origen prerrenal por vasodilatación
- D) Deben suspenderse la administración de diuréticos

Respuesta Correcta: C

246. Dentro de las principales causas de colestasis intrahepáticas, no figura:

- A) Hepatitis C
- B) Cirrosis o enfermedad hepática de origen alcohólica
- C) El hígado graso
- D) Coledocolitiasis

Respuesta Correcta: D

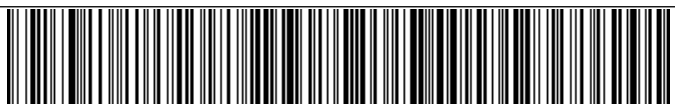
247. La presencia de un líquido ascítico de aspecto turbio; con proteínas > 2.5 g/dl; Cociente Amilasa sérica/amilasa en líquido ascítico <1.1, leucocitos >500/microlitro y con Polimorfonucleares >50%, sugiere como diagnóstico:

- A) Peritonitis bacteriana espontánea
- B) Peritonitis bacteriana secundaria
- C) Neoplasia
- D) Tuberculosis

Respuesta Correcta: B

248. La acidosis metabólica con anión gap aumentado, pueden ser producidas por todas las siguientes causas menor una. Señálela:

- A) Cetoacidosis diabética.
- B) Acidosis láctica.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) Diarrea aguda.
- D) Insuficiencia renal aguda.

Respuesta Correcta: C

249. ¿Cuál de las siguientes neoplasias no es causa habitual de hiponatremia por síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética (SIADH)?

- A) Glioblastoma multiforme.
- B) Carcinoma de próstata.
- C) Carcinoma de pulmón.
- D) Adenocarcinoma pancreático.

Respuesta Correcta: B

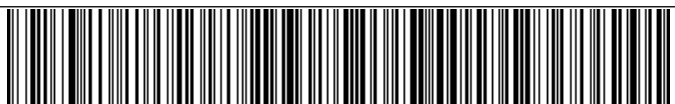
250. En relación a las alteraciones del equilibrio ácido- básico señale la respuesta incorrecta:

- A) La sangre venosa refleja el grado de acidosis con la misma exactitud que la arterial.
- B) El mecanismo compensador de la acidosis metabólica es la disminución del PaCO₂ por hiperventilación.
- C) La acidosis metabólica con Anión GAP normal se denomina también normoclorhémica
- D) Una de las causas de acidosis metabólica con anión GAP elevado es la cetoacidosis diabética.

Respuesta Correcta: C

251. Respecto a las alteraciones de los trastornos hidroelectrolíticos, señale la Respuesta Correcta:

- A) La hiponatremia se clasifica como grave en concentraciones séricas inferiores a 115 meq/l, o cuando, independientemente de la natremia existan síntomas neurológicos acompañantes.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) La hipopotasemia se clasifica como grave si la concentración de potasio sérico se encuentra entre 2.5- 2.9 meq/l.
- C) En la hipernatremia, la corrección de déficit de agua debe realizarse rápidamente en las primeras 5 horas.
- D) En la hiperpotasemia no está indicada la retirada de IECAs o ARA- II.

Respuesta Correcta: A

252. Entre las causas de hipopotasemia, se encuentran todas excepto:

- A) Diarrea
- B) Hiperaldosteronismo.
- C) Insuficiencia suprarrenal
- D) Alcalosis metabólica de cualquier causa

Respuesta Correcta: C

253. Con respecto a la hipermagnesemia, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto?

- A) Se considera hipermagnesemia grave, cifras de magnesio >5 mg/dl
- B) La causa más frecuente de hipermagnesemia es la insuficiencia renal grave, asociado al aporte externo de magnesio, generalmente a través de antiácidos y laxantes.
- C) La hipermagnesemia severa puede provocar coma por depresión del sistema venoso central.
- D) En el tratamiento de la hipermagnesemia grave se debe administrar gluconato cálcico al 10% o cloruro cálcico al 10% en bolo intravenoso lento

Respuesta Correcta: C

254. ¿Para el diagnóstico diferencial de qué procesos utilizaría el anión gap?

- A) Acidosis y alcalosis metabólica
- B) Entre grupos de acidosis metabólica





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) Acidosis metabólica y respiratoria
- D) Acidosis y alcalosis respiratoria

Respuesta Correcta: B

255. ¿Cuál es la alteración cardiológica característica de la hipocalcemia?

- A) Descenso del Segmento ST
- B) Aparición de ondas U
- C) Ondas T picudas y simétricas
- D) Prolongación del intervalo QT

Respuesta Correcta: D

256. ¿En cuál de los siguientes procesos aparece el Signo de Trousseau?

- A) Hipercalcemia
- B) Hipomagnesemia
- C) Hipocalcemia
- D) Hipermagnesemia

Respuesta Correcta: C

257. ¿Cuál de los siguientes enunciados con respecto a la administración de la Calcitonina para el tratamiento de la Hipercalcemia aguda sintomática NO es cierta?

- A) Tiene una acción antirresortiva, con lo disminuye la concentración sérica de calcio
- B) El tratamiento debe mantenerse de 5 a 7 días
- C) Se puede administrar por vía intramuscular y subcutánea
- D) Su indicación fundamental es el tratamiento de la hipercalcemia aguda secundaria al hiperparatiroidismo

Respuesta Correcta: B





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

258. ¿Qué síntoma es más frecuente y característico de la Insuficiencia suprarrenal crónica primaria?

- A) Hipotensión arterial.
- B) Anorexia.
- C) Hiperpigmentación difusa.
- D) Confusión.

Respuesta Correcta: C

259. Hay una serie de situaciones que pueden desencadenar una crisis tirotóxica. Todas son CORRECTAS menos una:

- A) Tiroiditis de Hashimoto
- B) Gestación
- C) Intoxicación por organofosforados
- D) Administración de amiodarona

Respuesta Correcta: A

260. Varón de 49 años. Antecedentes personales de Fibrilación Auricular en tratamiento con amiodarona. Acude por un cuadro de fiebre de 38°, agitación, vómitos y diarrea. A la exploración presenta una taquicardia sinusal 130 lpm, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este paciente?

- A) Crisis mixedematosa
- B) Shock cardiogénico
- C) Crisis tirotóxica
- D) Síndrome de Liddle

Respuesta Correcta: C

261. La crisis Addisoniana o Insuficiencia suprarrenal aguda es una emergencia médica. ¿Cuál de estos tratamientos no es el adecuado?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Perfusión de insulina rápida
- B) Hidrocortisona intravenosa
- C) Dexametasona intravenosa
- D) Tratamiento de la depleción hidrosalina para corregir la deshidratación y la hiponatremia

Respuesta Correcta: A

262. ¿Cuál de los siguientes no es un predictor de mortalidad en la crisis mixedematosa?

- A) Hipertermia refractaria a pesar del tratamiento
- B) Necesidad de ventilación mecánica.
- C) Hipotensión y bradicardia en el momento del diagnóstico
- D) Baja puntuación en la escala de Glasgow

Respuesta Correcta: A

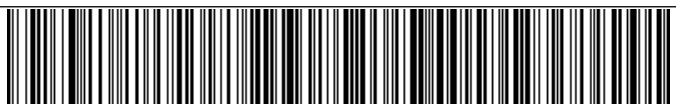
263. ¿Cuál de los siguientes signos NO es característico del hipertiroidismo?

- A) Hiperreflexia
- B) Temblor fino
- C) Bradicardia
- D) Hipertensión arterial

Respuesta Correcta: B

264. ¿Cuál de las siguientes alteraciones analíticas no se detecta habitualmente en el hipotiroidismo?

- A) Aumento de la concentración sérica de creatinina
- B) Cifras normales de urea plasmática
- C) Elevación de transaminasas
- D) Hiponatremia con hiperosmolaridad





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

265. El tratamiento de una apoplejía hipofisaria en su fase aguda se basa en la administración de:

- A) Glucocorticoides solubles
- B) Mineralocorticoides
- C) Hormonas tiroideas
- D) Estrógenos o testosterona, según el sexo del paciente

Respuesta Correcta: A

266. ¿Cuál de los siguientes fármacos es de elección en el tratamiento de una crisis addisoniana en un paciente no diagnosticado previamente de insuficiencia suprarrenal?

- A) Fludrocortisona
- B) Dexametasona
- C) Hidrocortisona
- D) Fluocinolona

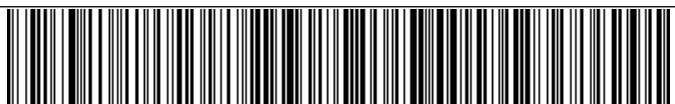
Respuesta Correcta: B

267. ¿Qué signo clínico no esperaría encontrar en un paciente con coma hiperosmolar hiperglucémico no cetósico?

- A) Conservación del nivel de consciencia.
- B) Signos secundarios a deshidratación severa.
- C) Anomalías neurológicas transitorias.
- D) Hipotonía muscular.

Respuesta Correcta: A

268. ¿Cuál de estas medidas es incorrecta con respecto al tratamiento de la Cetoacidosis diabética?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Administración de antibioterapia empírica si existe un foco infeccioso como desencadenante.
- B) Administración de bicarbonato sódico 1M, siempre que el ph sea inferior a 7.2
- C) Si la concentración de magnesio es <1.8 mg/dl, se recomienda administrar 1.5 g/h de sulfato de magnesio en las primeras dos horas.
- D) Si las concentraciones de potasio son iguales o superiores a 5.5 mEq/l, no debe administrarse.

Respuesta Correcta: B

269. Ante un paciente joven, con un cuadro brusco y rápidamente evolutivo, de dolor abdominal, náuseas, vómitos, y respiración rápida y profunda, sospecharía:

- A) Infección por SARS-2.
- B) Infección por burundanga.
- C) Situación hiperosmolar.
- D) Cetoacidosis diabética.

Respuesta Correcta: D

270. Es cierto en la cetoacidosis diabética:

- A) Se presenta habitualmente en paciente con diabetes mellitus tipo 2.
- B) Siempre debe administrarse bicarbonato sódico
- C) La acidosis metabólica se produce como consecuencia de acumulación de cuerpos cetónicos en sangre
- D) La perfusión de insulina se suspenderá con cifras de glucemia inferiores a 250 mg/dl.

Respuesta Correcta: C

271. Respecto a la descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica, señale la respuesta FALSA:

- A) Se da habitualmente en los diabéticos tipo 2.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) La glucemia será inferior a 600 mg/dl.
- C) La velocidad de instauración es en días.
- D) La cetonemia/cetonuria serán negativas o positivas débiles.

Respuesta Correcta: B

272. Señale la INCORRECTA respecto a la patología diabética.

- A) Se considera cetonemia grave cuando es superior a 2 mmol/l
- B) Más del 90% de las hipoglucemias son exógenas o inducidas
- C) La hiperventilación (respiración de Kussmaul) forma parte de los síntomas y signos característicos de la cetoacidosis diabética.
- D) Si la clínica neurológica persiste 30 minutos después de la normalización de la glucemia, habrá que descartar otras alteraciones metabólicas o lesiones neurológicas estructurales.

Respuesta Correcta: A

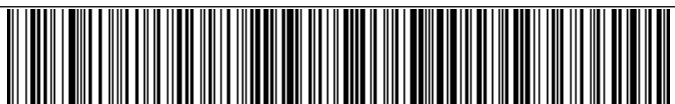
273. La hipoglucemia grave es en la que:

- A) La glucemia es inferior a 50 mg/dl
- B) Hay síntomas neuroglucopénicos
- C) Se requiere asistencia de otra persona para que se resuelva
- D) La glucemia es inferior a 70 mg/dl y se acompaña de síntomas colinérgicos

Respuesta Correcta: C

274. ¿Cuál de los siguientes fármacos reduce los requerimientos de glucosa en la hipoglucemia producida por sobredosis de sulfonilureas, por lo que se puede utilizar de forma adicional al tratamiento convencional para reducción de recurrencias?

- A) Somatostatina
- B) Glucagón





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) Octreótida
- D) Hidrocortisona

Respuesta Correcta: C

275. Con respecto al manejo de la hiperglucemia secundaria al tratamiento con corticoides, ¿qué es incorrecto?

- A) En pacientes con dosis altas de corticoides o con descompensación metabólica muy acentuada, debe iniciarse tratamiento con infusión de insulina intravenosa
- B) El patrón de hiperglucemia se suele caracterizar por una gran elevación de la glucemia en ayunas, y por una mínima elevación después de las comidas, sobre todo por la tarde y la noche.
- C) La hiperglucemia inducida por corticoides es una situación reversible
- D) En la mayoría de las situaciones puede utilizarse una pauta subcutánea (basal-bolus- corrección), teniendo en cuenta que debe incrementarse las dosis calculadas para los bolos.

Respuesta Correcta: B

276. ¿Qué dosis de insulina subcutánea al día administraría a un paciente con diabetes, con un peso de 70 kg, que se trataba con 2 comprimidos de metformina y que tiene una glucemia de 180 mg/dl, en el momento del ingreso?

- A) 21 UI
- B) 28 UI
- C) 35 UI
- D) 42 UI

Respuesta Correcta: B

277. Un paciente de 11 años acude al servicio de urgencias por dolor inguinal, cojera y síndrome febril de 24 horas de evolución. Ante la sospecha clínica de una artritis séptica de cadera, es cierto que:

- A) La elevación de la proteína C reactiva confirma el diagnóstico





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) La punción articular tiene valor diagnóstico y en algunos casos terapéutico.
- C) La ecografía es poco sensible para detectar la presencia del líquido articular.
- D) La resonancia magnética es la prueba de elección para el despistaje de infección.

Respuesta Correcta: B

278. Ante un paciente con artritis aguda de rodilla, ¿cuál sería el procedimiento diagnóstico más adecuado?

- A) Determinar los niveles de ácido úrico.
- B) Determinar el recuento de leucocitos en sangre.
- C) Realizar una punción articular diagnóstica- terapéutica.
- D) Radiografía articular.

Respuesta Correcta: C

279. Ante una monoartritis séptica aguda, ¿cuál es el dato más concluyente para su diagnóstico?

- A) Presencia de signos sistémicos, fiebre y decaimiento.
- B) La historia de dolor e inflamación articular sin traumatismo previo.
- C) La valoración del líquido sinovial (artrocentesis diagnóstica).
- D) Las pruebas complementarias sanguíneas.

Respuesta Correcta: C

280. ¿Cuál sería el tratamiento antibiótico de elección en un paciente de 27 años, sin antecedentes de interés que presenta una artritis séptica de rodilla derecha, tras un traumatismo con herida local hace 3 semanas?

- A) Ceftriaxona 2 gramos iv cada 24 horas
- B) Cloxacilina 2 gramos iv cada 6 horas + ceftriaxona 2 gramos iv cada 24 horas.
- C) Cloxacilina 2 gramos iv cada 6 horas
- D) Cefepima 2 gramos iv cada 12 horas + Amikacina 1000 mg cada 24 horas iv





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: B

281. ¿Cuál de las siguientes causas de monoartritis o poliartritis es más frecuente en el sexo femenino?

- A) Gota.
- B) Espondilitis anquilosante.
- C) Lupus eritematoso sistémico.
- D) Síndrome de Reiter.

Respuesta Correcta: C

282. Con respecto al lupus eritematoso sistémico (LES), señale la incorrecta:

- A) El 90% de los casos ocurren en el sexo femenino.
- B) Tienen 10 veces más riesgo de desarrollar enfermedad coronaria.
- C) La exposición a la luz solar excesiva puede desencadenar la aparición de un brote de la enfermedad.
- D) Una posible complicación es la endocarditis verrugosa de Libman- Sacks.

Respuesta Correcta: B

283. Requieren ingreso hospitalario todos siguientes pacientes, excepto:

- A) Pacientes con líquido sinovial con 2000 leucocitos/microlitro (30% Polimorfonucleares).
- B) Pacientes con monoartritis séptica.
- C) Paciente con monoartritis febril con duda diagnóstica.
- D) Pacientes con evidencia de líquido sinovial hemático, con trastorno de la coagulación sanguínea demostrado.

Respuesta Correcta: A

284. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la orientación diagnóstica de las monoartritis:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) La artritis séptica presenta habitualmente un comienzo súbito.
- B) La espondilitis anquilosante es predominante en el sexo femenino.
- C) La artritis microcristalina tiene más incidencia en adultos mayores de 50 años.
- D) La gota se localiza en mayor frecuencia en la primera articulación metatarsofalángica

Respuesta Correcta: B

285. ¿Cuál de los siguientes fármacos No se recomienda en la fase aguda de una artritis gotosa?

- A) Naproxeno
- B) Alopurinol
- C) Colchicina
- D) Indometacina

Respuesta Correcta: B

286. Señale cuál de los siguientes fármacos se utiliza en el tratamiento de una crisis renal esclerodérmica:

- A) Labetalol intravenoso
- B) Nitroglicerina intravenosa
- C) Captopril oral
- D) Sotalol intravenoso

Respuesta Correcta: C

287. En relación a las anemias, señale la Respuesta Correcta:

- A) Se considera una anemia moderada cuando la cifra de Hemoglobina está entre 6-8 gr/dl
- B) Las alteraciones neurológicas como parestesias o ataxia, sugieren déficit de Vitamina B12





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) El sulfato ferroso debe administrarse en la anemia ferropénica junto con inhibidores de la bomba de protones para favorecer la tolerabilidad
- D) Las anemias moderadas con buena tolerancia deben ser ingresadas siempre para realizar el estudio etiológico

Respuesta Correcta: B

288. ¿Cuál de éstas no es una causa habitual de anemia macrocítica?

- A) Anemia hemolítica
- B) Déficit de vitamina B12
- C) Alcoholismo
- D) Hipotiroidismo.

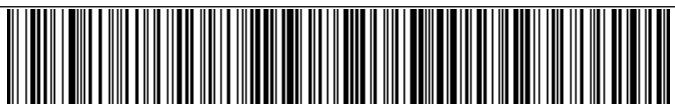
Respuesta Correcta: A

289. Respecto al tratamiento de las anemias, señale la respuesta incorrecta:

- A) El sulfato ferroso para el tratamiento de la anemia ferropénica, se administra preferente en ayunas, evitando su toma simultánea con inhibidores de la bomba de protones.
- B) La Vitamina B12 para el tratamiento de la anemia por déficit de la misma, se administra a dosis inicial de 1 ampolla cada 24 h por vía intramuscular durante la primera semana, para luego pasar 1 mg/semanal por la misma vía durante 1 o 2 meses siguientes, y 1 mg trimestral de manera indefinida como dosis de mantenimiento.
- C) En las anemias macrocíticas por déficit de vitamina B12, se dese administrar dicha vitamina B12 parenteral, evitando el uso conjunto con ácido fólico complementario, ya que puede agravar la clínica neurológica o agravarla.
- D) Las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, se deben tratar inicialmente con esteroides (prednisona a 1- 2 mg/kg/día vía oral), durante 3 semanas, con posterior descenso gradual.

Respuesta Correcta: C

290. ¿Cuáles son las hemorragias más frecuentes en los pacientes con hemofilia?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Hemorragias intracraneales.
- B) Hemorragia digestiva.
- C) Hematuria.
- D) Hemartros.

Respuesta Correcta: D

291. ¿La hemofilia A se produce por un déficit cuantitativo o cualitativo, de qué factor de la coagulación?

- A) Factor IX
- B) Factor X
- C) Factor VIII
- D) Factor VII

Respuesta Correcta: C

292. ¿Cuál de las siguientes alteraciones analíticas NO debería aparecer en una reacción hemolítica aguda?

- A) Hemoglobinemia
- B) Hemoglobinuria
- C) Prueba de Coomb directa positiva
- D) Hiperbilirrubinemia de predominio directo

Respuesta Correcta: D

293. Con respecto al tratamiento de las anemias hemolíticas autoinmunitarias por anticuerpos calientes, señale la respuesta incorrecta:

- A) La esplenectomía y el empleo de inmunosupresores, se reservan para casos en los que no responden a corticoides
- B) Se tratan inicialmente con esteroides, tipo prednisona a dosis de 1- 2 mg/kg/día durante 3 semanas, para posterior descenso gradual





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) Se debe asociar al tratamiento con esteroides, ácido fólico 5 mg/24horas
- D) Ante hemoglobina <8 mg/dl, está indicada la transfusión de concentrado de hematíes

Respuesta Correcta: D

294. ¿Cuál no es una posible causa de anemia normocítica?

- A) Anemia hemolítica
- B) Hemorragia aguda
- C) Anemia por insuficiencia renal
- D) Crioglobulinemia

Respuesta Correcta: D

295. Con respecto a las hemofilias, señale la incorrecta:

- A) Son enfermedades congénitas, de carácter hereditario, que se transmiten de forma dominante, ligada al cromosoma X
- B) Se deben a un déficit cuantitativo o cualitativo en la síntesis del factor VIII (Hemofilia A) o del factor IX (hemofilia B)
- C) Las hemorragias más frecuentes son los hemartros (75%)
- D) Las hemorragias cutaneomucosas son menos frecuentes

Respuesta Correcta: A

296. ¿Cuál de las siguientes causas de pancitopenias es primaria?

- A) Hiperesplenismo
- B) Hemoglobinuria paroxística nocturna
- C) Paludismo
- D) Síndrome hemaagocítico

Respuesta Correcta: B





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

297. ¿Cuál es el tratamiento inicial trombocitopenia inmunitaria idiopática crónica?

- A) Rituximab
- B) Corticoides
- C) Esplenectomía
- D) Análogos de la trombopoyetina

Respuesta Correcta: B

298. La transfusión profiláctica de pool de plaquetas en pacientes adultos estable con trombocitopenia aguda de origen central, está indicada cuando el recuento de plaquetario es:

- A) Siempre
- B) Inferior a 10000/microl
- C) Inferior a 20000/microl
- D) Inferior a 30000/microl

Respuesta Correcta: B

299. ¿Cuál de los siguientes NO se considera un factor predisponente de complicaciones infecciosas en el paciente con neutropenia febril?

- A) Ausencia de comorbilidades
- B) Rapidez del descenso en el número de neutrófilos
- C) Tratamiento previo con corticoides o inmunosupresores
- D) Alteración de la barrera cutaneomucosa

Respuesta Correcta: A

300. ¿Cuál de estos fármacos NO se ha asociado a neutropenia como efecto secundario?

- A) Metamizol magnésico





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Anfotericina B
- C) Carbamacepina
- D) Amlodipino

Respuesta Correcta: D

301. Señale lo incorrecto con respecto a la púrpura trombocitopénica trombótica:

- A) Se trata de un síndrome microangiopático trombótico en el que se producen microtrombos plaquetarios hialinos en los pequeños vasos del sistema nervioso central, riñón, hígado, etc., con el consiguiente fallo orgánico isquémico, consumo de plaquetas y anemia hemolítica mecánica
- B) Debe sospecharse en un paciente que presente trombocitopenia (entre 10000-50000/microl), anemia hemolítica, síntomas neurológicos fluctuantes (paresia, afectación de los pares craneales, crisis convulsivas), insuficiencia renal vs hematuria, y fiebre.
- C) El diagnóstico diferencial se establece con el síndrome hemolítico- urémico
- D) El tratamiento de elección son los corticoides y antiagregantes plaquetarios

Respuesta Correcta: D

302. En cuanto al tratamiento antibiótico empírico en las neutropenias señale lo INCORRECTO.

- A) En la neutropenia grave con fiebre, sin signos de sepsis ni foco infeccioso aparente, el tratamiento de elección es la monoterapia con una de las siguientes alternativas: Imipenem, Meropenem, Piperazilina- tazobactam, Ceftazima o Cefepima.
- B) En caso de enterocolitis o infección perirrectal, se recomienda añadir al betalactámico elegido, Metronidazol 500 mg/8 horas.
- C) Se debe añadir un aminoglucósido a la monoterapia con betalactámico elegido (Imipenem, Meropenem, Piperazilina- tazobactam, Ceftazima o Cefepima), cuando existen criterios de sepsis grave o shock séptico, o sospecha de infección por cocos gram positivos pendiente de tipificar.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- D) Si persiste la fiebre al 5º día, se revalúa el paciente, y se solicitan TAC de alta resolución, antígeno de galactomanano, nuevos hemocultivos y cultivos de muestras de cualquier foco accesible potencialmente infectado.

Respuesta Correcta: C

303. ¿Cuál de las siguientes no es una causa de poliglobulina?

- A) Policitemia Vera
- B) Talasemia menor
- C) Tumor de Wilms
- D) Hipotiroidismo

Respuesta Correcta: D

304. ¿Cuál de las siguientes no es una causa de linfocitosis?

- A) Leucemia aguda linfoblástica
- B) Hipertiroidismo
- C) Síndrome de Guillain Barré
- D) Alcoholismo crónico

Respuesta Correcta: D

305. Señale en qué valores deben mantenerse los niveles de INR (International Normalized Ratios) para que la coagulación sea eficaz y se minimicen los efectos secundarios, en el grupo de pacientes que presentan fibrilación auricular crónica de causa no reumática, y que han padecido recientemente un episodio de isquemia cerebral.

- A) Inferior a 1.
- B) Entre 1 y 2.
- C) Entre 2 y 3.
- D) Entre 3 y 5.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: C

306. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para el tratamiento de un paciente neoplásico con tratamiento quimioterápico activo, con una trombocitopenia moderada y diagnóstico de una trombosis venosa profunda en miembro inferior derecho?

- A) Bemiparina
- B) Enoxaparina
- C) Fondaparinux
- D) Tirzaparina

Respuesta Correcta: C

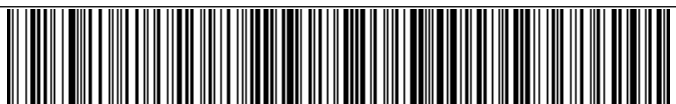
307. La administración de Idarucizumab se utiliza para la reversión rápida del efecto anticoagulante. ¿De cuáles de los siguientes anticoagulantes de acción directa?:

- A) Edoxabán
- B) Dabigatrán
- C) Apixabán
- D) Rivaroxabán

Respuesta Correcta: B

308. Señale la afirmación INCORRECTA en cuanto a las indicaciones de transfusión:

- A) La necesidad de transfusión no depende del volumen del sangrado, del tiempo de evolución, situación hemodinámica y antecedentes del paciente
- B) Hemoglobina igual o inferior a 6 gr/dl casi siempre requiere transfusión
- C) En la Anemia crónica la transfusión generalmente no debe realizarse cuando la concentración de Hb es superior a 10 gr/dl
- D) Con hemoglobina entre 6 y 8 gr/dl estaría indicada la transfusión en pacientes con factores de riesgo o síntomas de hipoxemia o descompensación





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

309. La transfusión de plaquetas está formalmente contraindicada en:

- A) En la trombocitopenia periférica autoinmunitaria
- B) En la púrpura postransfusional
- C) En el síndrome hemolítico urémico
- D) Antes de un procedimiento quirúrgico invasivo si el recuento plaquetario es inferior a 50000/microlitros

Respuesta Correcta: C

310. Con respecto a los componentes sanguíneos disponibles en el banco de sangre para transfusión de urgencias, señale la incorrecta:

- A) Cada concentrado de hematíes transfundido debe elevar el hematocrito en un 3% y la hemoglobina 1 g/dl a las 24 horas de la administración.
- B) Cada unidad para transfundir de plaquetas, es una suspensión de dichas células de 4 – 5 donantes, desplasmarizada un 70% y resuspendida en una solución aditiva, que tiene una caducidad de 5 días.
- C) Está indicada la transfusión de plaquetas en la Púrpura Trombocitopénica trombótica inducida por heparinas.
- D) La transfusión de plasma leucopleccionado está indicado en la Púrpura Trombocitopénica trombótica

Respuesta Correcta: C

311. Señale la respuesta INCORRECTA en relación a la reacción hemolítica aguda postransfusional:

- A) La reacción hemolítica aguda es el efecto adverso más grave.
- B) Los hematíes transfundidos son destruidos masivamente por anticuerpos presentes en el plasma del receptor
- C) La administración de dopamina para el shock secundario está contraindicada.
- D) Su causa más frecuente es la incompatibilidad ABO.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: C

312. Señale la incorrecta con respecto a la Coagulación Intravascular diseminada (CID)

- A) Proceso frecuente en urgencias y potencialmente mortal, en el que coexisten fenómenos hemorrágicos trombóticos, por una activación generalizada de la coagulación en pequeños vasos.
- B) Existe una masiva producción de trombina, de lo que resulta un consumo de factores de la coagulación y plaquetas, y una activación secundaria de la fibrinólisis.
- C) Debe sospecharse ante cualquier paciente con lesiones purpúricas necróticas, sangrados cutáneos, mucosos o por heridas quirúrgicas, tendencia a la hemorragia y afectación orgánica, fundamentalmente renal y sistema nervioso central.
- D) Con respecto a las medidas de apoyo, además del tratamiento de la causa subyacente, se recomienda la transfusión de plaquetas profiláctica, con cifras de plaquetas <40000/microlitro

Respuesta Correcta: D

313. Con respecto a la reversión del tratamiento con antivitaminas K, señale lo INCORRECTO:

- A) En pacientes sin sangrado y con INR <5, es suficiente con dejar de tomar el antivitamina K 1- 2 días, con nuevo control en una semana
- B) En pacientes sin sangrado y con INR >5 es suficiente con dejar de tomar el antivitamina K 1- 2 días y control en 2 días.
- C) En pacientes con sangrado menor, como epistaxis o hematomas de pequeño tamaño, con INR en rango terapéutico o <1.5, bastaría con control local del sangrado.
- D) En pacientes con sangrado mayor (sangrado sintomático en un órgano o área crítica, intramuscular con riesgo de síndrome compartimental, o sangrado con descenso de hemoglobina >2 g/dl, o transfusión de más de 2 concentrados de hematíes), se debe suspender el fármaco antivitamina K, y administrar vitamina





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

K, a dosis de 50 mg por vía intravenosa, así como concentrado protrombínico según INR y peso del paciente.

Respuesta Correcta: D

314. Con respecto a las lesiones elementales, señale la respuesta incorrecta.

- A) Se define por placa a una lesión elevada de la piel formada por la coalescencia de varias pápulas o nódulos.
- B) Se define por petequia a una mácula purpúrica de pequeño tamaño.
- C) Se define por nódulo a una lesión elevada, sólida, de tamaño mayor 10 mm de diámetro (se palpa mejor que se ve)
- D) La excoriación se define por un engrosamiento de la piel como consecuencia del rascado continuado de una lesión pruriginosa.

Respuesta Correcta: D

315. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sobre la necrólisis epidérmica tóxica NO es correcta?

- A) Puede ser provocada por fármacos, como anticonvulsivantes o alopurinol
- B) Afecta a la piel y mucosas
- C) Es una enfermedad muy grave, con una mortalidad que puede alcanzar el 50%.
- D) Presenta un signo de Nikolski negativo

Respuesta Correcta: D

316. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el síndrome de la piel escaldada estafilocócica NO es correcta?

- A) Se debe a la infección por *Staphylococcus epidermidis*
- B) El signo de Nikolsky es positivo
- C) Las lesiones no afectan a mucosas
- D) Las lesiones no complicadas curan sin dejar cicatriz





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

317. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección del síndrome de la piel escaldada estafilocócica?

- A) Cloxacilina intravenosa
- B) Amoxicilina- ácido clavulánico intravenosa
- C) Clindamicina intravenosa
- D) No está indicado el tratamiento antibiótico, al ser una toxina y no el germen, la responsable de la enfermedad

Respuesta Correcta: A

318. ¿Cuál es el germen más frecuentemente implicado en la celulitis?

- A) Staphylococcus aureus
- B) Staphylococcus epidermidis
- C) Streptococcus pyogenes
- D) Streptococcus del grupo A

Respuesta Correcta: D

319. Señale la CORRECTA con respecto al pénfigo ampolloso:

- A) Se caracteriza por ampollas flácidas, que se rompen con facilidad, que aparecen en zonas de piel aparentemente sana, y que una vez rota, dejan un área erosiva húmeda, sin tendencia a la curación.
- B) El signo de Nikolsky es positivo
- C) Es una patología circunscrita a la piel, que no afecta a mucosas ni al estado general del paciente.
- D) Afecta a ambos sexos por igual, y es más frecuente en personas entre los 40 y 60 años.

Respuesta Correcta: C





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

320. ¿Cuál de los siguientes fármacos está indicado en el tratamiento de los casos graves de la púrpura de Schönlein- Henoch?

- A) Azatioprina
- B) Prednisona
- C) Metrotexato
- D) Ciclosporina

Respuesta Correcta: B

321. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA sobre la púrpura de Schönlein Henoch?

- A) Se caracteriza, entre otros, por púrpura palpable en los miembros superiores
- B) Afecta a niños y adultos jóvenes
- C) Suele ir precedida de una infección estreptocócica aguda
- D) Cursa con dolor abdominal de tipo cólico

Respuesta Correcta: A

322. ¿Cuál de las siguientes opciones con respecto al síndrome de Sweet NO es correcta?

- A) Suele presentarse en mujeres de mediana edad
- B) Se caracteriza por fiebre elevada de inicio súbito, con afectación importante del estado general, y presencia de numerosas placas cutáneas eritematosas, edematosas y dolorosas, de superficial irregular, localizadas en cara, cuello y parte superior del tronco.
- C) Es un proceso reactivo a diversas enfermedades, entre las que destacan infecciones
- D) El tratamiento incluye, entre otras medidas, la administración de amoxicilina-ácido clavulánico por vía oral en dosis de 500/125 mg/8 horas.

Respuesta Correcta: D





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

323. En un paciente con intoxicación por cocaína, señale la incorrecta:

- A) Si presenta crisis convulsivas el tratamiento de elección es el midazolam
- B) En el caso de arritmias los B-bloqueantes están contraindicados
- C) Entre las manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda pueden aparecer euforia, miosis hipertermia, agitación y coma
- D) Si presenta agitación psicomotriz se trata con benzodiacepinas

Respuesta Correcta: C

324. Ante un paciente que se encuentra en coma con miosis bilateral, depresión respiratoria y reflejos oculocefálicos y oculovestibulares normales ¿qué administraría?:

- A) Tiamina
- B) Naloxona
- C) Glucosa hipertónica
- D) Flumazenilo

Respuesta Correcta: B

325. ¿Cuál de los siguientes fármacos es tratamiento de primera elección en la intoxicación por cocaína?:

- A) Salbutamol
- B) Haloperidol
- C) Diazepam
- D) Clorpromazina

Respuesta Correcta: C

326. Atiende a una mujer de 22 años por pérdida de conocimiento. Su pareja le comenta que ha consumido éxtasis líquido, indique la afirmación correcta:

- A) El éxtasis líquido es en realidad gamma-hidroxibutírico (GHB)
- B) El éxtasis líquido es una mezcla de ketamina con MDMA





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) El éxtasis líquido es una nueva forma de presentación del éxtasis (MDMA) de acción más rápida
- D) El éxtasis líquido es metaanfetamina depurada en forma de cristales

Respuesta Correcta: A

327. Un varón de 28 años con antecedentes personales de drogadicción en periodo actual de desintoxicación, presenta un cuadro de profunda somnolencia sin otra sintomatología. En su historia clínica se encuentra que sigue un tratamiento con benzodiacepinas y olanzapina ¿qué es lo que debemos hacer en primer lugar?:

- A) Proceder a intubación endotraqueal
- B) Administración de flumazenilo
- C) Administrar naloxona
- D) Esperar a que despierte

Respuesta Correcta: B

328. El fármaco de elección en la intoxicación por opiáceos es:

- A) Adrenalina
- B) Amiodarona
- C) Metadona
- D) Naloxona

Respuesta Correcta: D

329. ¿Qué intoxicación causa normalmente midriasis?:

- A) Plaguicidas organofosforados
- B) Morfina
- C) Cocaína
- D) Benzodiacepinas

Respuesta Correcta: C

330. ¿Qué tipo de intoxicación puede causar taquicardia?:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Benzodiacepinas
- B) Opioides
- C) Plaguicidas carbamatos
- D) Anfetaminas

Respuesta Correcta: D

331. ¿Cuál es el síntoma de mayor importancia médica en la intoxicación aguda por opiáceos?:

- A) Convulsiones
- B) Depresión respiratoria
- C) Arritmias y asistolia
- D) Broncorrea y broncoconstricción

Respuesta Correcta: B

332. En el tratamiento de la intoxicación aguda por ingestión de cáusticos, señale la falsa:

- A) El lavado gástrico y la administración de carbón activado están contraindicados
- B) La terapia dilucional con agua o leche no se recomienda
- C) Los ácidos producen daño tisular por necrosis de coagulación con formación de una escara protectora
- D) No es necesario realizar radiografía de tórax y simple de abdomen

Respuesta Correcta: D

333. El carbón activado no está indicado en la intoxicación por:

- A) Intoxicación por salicilatos
- B) Intoxicación por paracetamol
- C) Intoxicación por litio
- D) Intoxicación por B-bloqueantes

Respuesta Correcta: C





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

334. En el manejo de la intoxicación aguda por antidepresivos tricíclicos ¿qué tratamiento no estaría indicado?:

- A) Carbón activado
- B) Flumazenilo
- C) Bicarbonato sódico 1M
- D) Benzodiacepinas sí agitación o convulsión

Respuesta Correcta: B

335. En caso de intoxicación por cáusticos, señale la respuesta incorrecta:

- A) Se asegurará que la vía aérea es permeable así como la adecuada ventilación-oxigenación del paciente
- B) Administración de carbón activado para neutralizar el ph
- C) Retirada de prendas de vestir y lavado si contacto cutáneo
- D) Administración de antieméticos y dieta absoluta

Respuesta Correcta: B

336. En caso de ingestión de sosa cáustica la actuación correcta es:

- A) Provocar el vómito
- B) Dieta absoluta y administrar antieméticos
- C) Administrar carbón activado
- D) Todas las actuaciones son correctas

Respuesta Correcta: B

337. Varón de 53 años traído por un familiar. Refiere que ha bebido aproximadamente 50 ml de lejía, señale la Respuesta Correcta:

- A) La ausencia de lesiones en boca y faringe descarta afectación esofagogástrica
- B) Se debe administrar carbón activado en dosis única de 40 gramos
- C) Está indicada la profilaxis antibiótica, de elección amoxicilina-clavulánico y como alternativa clindamicina
- D) Todas las anteriores son falsas





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

338. Mujer de 22 años traída a urgencias en estado postcrítico después de crisis convulsiva. TA 80/40 y ECG con un QRS ensanchado. Había comenzado a tomar nortriptilina 2 semanas antes. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

- A) Vía venosa y benzodiacepinas
- B) Vía venosa, lavado gástrico y fisostigmina
- C) Diuresis forzada alcalina
- D) Vía venosa, lavado gástrico, carbón activado y bicarbonato iv

Respuesta Correcta: D

339. Respecto a la intoxicación por paracetamol, señale la respuesta incorrecta:

- A) La dosis tóxica es de 10gr en pacientes sanos y 7.5gr en pacientes etílicos, hepatópatas, malnutrición, etc
- B) El lavado gástrico y carbón activado están contraindicados
- C) El antídoto es la N-acetilcisteína
- D) En el diagnóstico es útil el nomograma de Rumack-Matthews

Respuesta Correcta: B

340. La N-acetilcisteína es el antídoto para la intoxicación por:

- A) Neurolépticos
- B) Salicilatos
- C) Paracetamol
- D) Opiáceos

Respuesta Correcta: C

341. Pertenecen al grupo de insecticidas organofosforados, todas menos:

- A) Paration
- B) Malation
- C) DDT





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Albicarb

Respuesta Correcta: C

342. En las intoxicaciones por setas, señale la falsa:

- A) Pueden producir síntomas colinérgicos
- B) Pueden producir síntomas alucinógenos
- C) Si los síntomas aparecen después de transcurridas 6 horas se trata, generalmente, de intoxicaciones leves
- D) Si presentan hemorragias se administra plasma fresco y vitamina k

Respuesta Correcta: C

343. Señale la Respuesta Correcta en relación con la atención urgente de un enfermo con ingesta accidental de una cantidad tóxica de setas de la especie Amanita Phalloides:

- A) Clínicamente suele producir un síndrome de aparición precoz (minutos) de tipo muscarínico
- B) El pronóstico se establece básicamente por el grado de insuficiencia renal, la hepatotoxicidad no es relevante
- C) La diuresis forzada neutra no ha mostrado utilidad
- D) La terapéutica debe iniciarse con la simple sospecha clínica

Respuesta Correcta: D

344. ¿Cuál de las siguientes intoxicaciones no produce un síndrome colinérgico?

- A) Intoxicación por organofosforados
- B) Intoxicación por carbamatos
- C) Intoxicación por antihistamínicos
- D) Todas las anteriores producen

Respuesta Correcta: C

345. Una paciente de 42 años de edad es traída a la guardia desde su domicilio por sospecha de intoxicación con aumento de secreciones y deterioro del sensorio. Al





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

examen físico se constata miosis, frecuencia cardíaca de 50 por minuto y dificultad respiratoria con aumento de secreciones ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

- A) Intoxicación por organofosforados
- B) Intoxicación por cocaína
- C) Intoxicación por paraquat
- D) Intoxicación por organoclorados

Respuesta Correcta: A

346. En el tratamiento de la intoxicación por organofosforados está indicado el uso de:

- A) Atropina
- B) Oximas
- C) Lavado gástrico y carbón activado
- D) Todas las anteriores son correctas

Respuesta Correcta: D

347. Señale la respuesta incorrecta respecto a la intoxicación por paraquat:

- A) Es una intoxicación con una mortalidad escasa
- B) En su tratamiento está indicado la tierra de Fuller
- C) Está contraindicada la oxigenoterapia: la toxicidad del paraquat aumenta en relación con la concentración de oxígeno alveolar
- D) No existe antídoto

Respuesta Correcta: A

348. En la intoxicación por setas, señale la Respuesta Correcta:

- A) La Amanita Phalloides produce intoxicaciones graves por fallo hepático y renal
- B) Los síntomas de intoxicación por Amanita Phalloides comienzan después de las 6 horas de la ingestión
- C) Cuando los síntomas en una intoxicación por setas aparecen precozmente (antes de 6 horas) suele deberse a una intoxicación leve o menos grave
- D) Todas las anteriores son ciertas





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

349. Unos niveles bajos de acetilcolinesterasa en plasma indican una intoxicación por:

- A) Herbicidas como el paraquat
- B) Organoclorados como el ddt
- C) Organofosforados como malation
- D) Rodenticidas

Respuesta Correcta: C

350. Señale la falsa en relación a la intoxicación por cianuro:

- A) El cianuro se produce por la combustión de materias plásticas y espumas de poliuretano
- B) Origina acidosis metabólica con anión gap elevado
- C) La hidroxycobalamina (B12) asociada o no a tiosulfato sódico es el tratamiento de elección
- D) No produce alteraciones electrocardiográficas

Respuesta Correcta: D

351. Señale la falsa en la intoxicación por monóxido de carbono:

- A) La afinidad de la hemoglobina para el monóxido de carbono es unas 240 veces mayor que para el oxígeno
- B) La pulsioximetría, que determina la saturación periférica de oxígeno, es útil para valorar la satO2
- C) Entre las complicaciones más importantes están el edema agudo de pulmón y el infarto agudo de miocardio
- D) En las víctimas de incendios puede existir intoxicación conjunta por monóxido y cianuro

Respuesta Correcta: B

352. ¿Qué dosis de hidroxycobalamina utilizaría en un niño de 5 años procedente





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

de un incendio que reúne criterios clínicos de administración de este antídoto:

- A) 70 mg/ kg de peso
- B) 1g
- C) 100mg/ kg de peso
- D) 10 mg/ kg de peso

Respuesta Correcta: A

353. Un paciente presenta dolor de cabeza y náuseas tras permanecer una tarde en una casa rural con un brasero encendido. La sospecha es de intoxicación por monóxido de carbono (CO). Al administrar tratamiento con oxígeno normobárico debemos saber que:

- A) La FiO₂ debe ser 0,21
- B) La FiO₂ debe ser 0.5
- C) La FiO₂ debe ser 1
- D) La FiO₂ dependerá de los niveles de carboxihemoglobina

Respuesta Correcta: C

354. ¿En que se fundamenta el uso de la cámara hiperbárica en la intoxicación por monóxido de carbono?:

- A) El aumento de la supervivencia de las víctimas de la intoxicación
- B) La mejora selectiva de la perfusión a nivel miocárdico
- C) La disminución del efecto de la carboxihemoglobina sobre el feto
- D) La disminución de la vida media de la carboxihemoglobina a tan solo 30 minutos

Respuesta Correcta: D

355. Respecto al síndrome neurológico tardío por monóxido de carbono, señale la correcta:

- A) Produce una disfunción neurológica y conductual
- B) Suele aparecer durante los 8 meses siguientes y principalmente en los primeros 21 días tras la intoxicación





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) Reversible en el 50-75 % de los casos tras 1 año
- D) Todas las anteriores son correctas

Respuesta Correcta: D

356. Respecto a la intoxicación por cianhídrico (CNH), indique la Respuesta Correcta:

- A) El cianhídrico (CNH) junto al monóxido de carbono (CO) son los gases asfixiantes más peligrosos de todos los presentes en el humo
- B) La oxigenoterapia hiperbárica sólo estaría indicada en el caso de coexistir una intoxicación por monóxido de carbono
- C) La hidroxibalamina es el único antídoto seguro y eficaz que se puede usar en la sospecha de intoxicación por cianhídrico o cuando ésta está comprobada
- D) Todas las anteriores son correctas

Respuesta Correcta: D

357. En la intoxicación por monóxido de carbono, señale la respuesta incorrecta:

- A) El síntoma más frecuente es la cefalea
- B) Debe sospecharse en todo paciente víctima de un incendio, inhalación de humo de aparatos de combustión como calentadores, estufas, braseros y vehículos mecánicos
- C) Es fundamental en el tratamiento la oxigenoterapia a alta concentración (100%)
- D) La oxigenoterapia hiperbárica no está indicada en el tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono

Respuesta Correcta: D

358. Acuden a la guardia 3 pacientes trasladados en ambulancia procedentes de un incendio en una fábrica de plásticos ¿A qué sustancias sospecha que pudieran estar expuestos?:

- A) Monóxido de carbono y ácido cianhídrico
- B) Metano y cianuro
- C) Metano y monóxido de carbono
- D) Cianuro, monóxido de carbono y ácido sulfhídrico





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

359. Señale la Respuesta Correcta en relación a la neuritis óptica:

- A) Es típica la mácula de color rojo cereza
- B) Hay que descartar esclerosis múltiple y arteritis de la temporal
- C) No ocasiona pérdida de visión
- D) La papila óptica no se encuentra afectada

Respuesta Correcta: B

360. Si un paciente consulta por pérdida brusca de la visión y dolor en un ojo, su primera sospecha diagnóstica será:

- A) Oclusión de la arteria central de la retina
- B) Neuritis óptica
- C) Hemorragia vítrea
- D) Desprendimiento de retina

Respuesta Correcta: B

361. En relación con la conjuntivitis bacteriana aguda, que afirmación no es correcta:

- A) La conjuntivitis bacteriana se diagnostica a partir de los síntomas clínicos
- B) Los folículos son típicos de la conjuntivitis bacteriana
- C) Se caracteriza por una secreción mucopurulenta
- D) El comienzo es inicialmente unilateral con posible afectación del segundo ojo en unos días

Respuesta Correcta: B

362. No es típico de uveítis anterior aguda:

- A) Dolor
- B) Inyección ciliar
- C) Fotofobia





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Midriasis

Respuesta Correcta: D

363. Paciente que acude al servicio de urgencias por presentar fiebre, dolor intenso con la movilidad ocular y sensación de calor periorbitario, señale la actitud más correcta:

- A) Se prescribirán AINES y antibióticos tópicos además de colirio antibiótico
- B) Se prescribirán AINES y antibióticos sistémicos con tratamiento mantenido durante 14 días
- C) Se canaliza vía con hemocultivos seriados y antibióticos sistémicos agresivos y en terapia combinada
- D) Dosis iv/im de cefalosporina de tercera generación y consulta con oftalmología en 24 horas

Respuesta Correcta: C

364. La neuritis del nervio óptico se caracteriza por, señale la falsa:

- A) Pérdida rápida de la visión en unos días
- B) Presencia de ojo rojo
- C) Pérdida de visión cromática
- D) Suele ser monocular

Respuesta Correcta: B

365. El glaucoma NO se caracteriza por uno de los siguientes signos y/o síntomas:

- A) Dolor grave y profundo
- B) Miosis
- C) Agudeza visual muy disminuida
- D) Aspecto de la córnea turbia por edema

Respuesta Correcta: B

366. Siempre es motivo de derivación urgente a oftalmología si en un ojo rojo sospechamos:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Conjuntivitis
- B) Uveítis
- C) Queratitis actínica
- D) Queratitis traumática

Respuesta Correcta: B

367. ¿Cuál de los siguientes es falso en relación con una epiescleritis?:

- A) El tratamiento es con antibióticos tópicos
- B) Ojo rojo
- C) Puede asociarse con artritis reumatoide
- D) Hiperemia aguda sectorial y dolor leve/ moderado

Respuesta Correcta: A

368. Ante un paciente que ha presentado síntomas previos de miodesopsias o ftopsys y aparece una disminución de la visión y una amputación del campo visual, generalmente como "una cortina", pensaremos en:

- A) Una uveítis posterior
- B) Una hemorragia vítrea
- C) Un desprendimiento de retina
- D) Una neuritis óptica

Respuesta Correcta: C

369. Si ante una exploración ocular encontramos signos como una importante disminución de la agudeza visual, un descenso de la presión intraocular(hipotonía), alteración de la forma de la pupila, edema conjuntival y aplanamiento de la cámara anterior, pensaremos en:

- A) Una abrasión ocular
- B) Una perforación del globo ocular
- C) Una queratoconjuntivitis actínica
- D) Una laceración conjuntival

Respuesta Correcta: B





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

370. Mujer de 30 años que acude a urgencias porque su hijo le ha clavado la uña en el ojo izquierdo, presenta dolor intenso y fotofobia sin disminución de la agudeza visual. En la tinción con fluoresceína se aprecia una erosión corneal, ¿cuál de las siguientes actuaciones no se recomienda?:

- A) Antibiótico oral
- B) Colirio y/o pomada antibiótica tópica
- C) Colirio ciclopléjico
- D) Colirio de anestésico para realizar la exploración oftalmológica

Respuesta Correcta: A

371. En en las heridas palpebrales es cierto que:

- A) Las heridas palpebrales superficiales menores de 1cm y/o bordes aproximados no precisan generalmente sutura
- B) Hay que valorar principalmente la heridas muy abigarradas y la posible lesión de las vías y saco lagrimal, ya que requieren una reconstrucción quirúrgica por parte del oftalmólogo
- C) La reparación de las laceraciones palpebrales puede demorarse hasta 24/48 horas si es necesario
- D) Todas las anteriores son ciertas

Respuesta Correcta: D

372. Los cuerpos extraños córneoconjuntivales, ¿cuál es la afirmación falsa?:

- A) Nunca se alojan a nivel del párpado superior por lo que no hay que revisarlo
- B) Con frecuencia son metálicos
- C) Provocan dolor ocular, lagrimeo intenso y fotofobia
- D) El tratamiento consiste en extracción del cuerpo extraño, colirio ciclopléjico y pomada oftálmica antibiótica

Respuesta Correcta: A

373. En la queratoconjuntivitis actínica es falso que:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Son lesiones producidas por la radiación ultravioleta, en los soldadores y en los que practican deportes de invierno
- B) Hay edema palpebral, hiperemia conjuntival y lesiones corneales puntiformes superficiales a la tinción con fluoresceína
- C) Nunca se debe ocluir el ojo afecto
- D) El tratamiento consiste en colirio ciclopléjico, pomada oftálmica antibiótica y oclusión ocular

Respuesta Correcta: C

374. Referente a las prioridades terapéuticas en oftalmología, es falso que:

- A) Las causticaciones oculares necesitan tratamiento inmediato
- B) El desprendimiento de retina necesita tratamiento urgente (en horas)
- C) Las heridas palpebrales necesitan tratamiento inmediato
- D) Los cuerpos extraños corneales necesitan tratamiento urgente (en horas)

Respuesta Correcta: C

375. En el desprendimiento de retina es falso que:

- A) Se diagnostica mediante fondo de ojo
- B) Cursa con pérdida brusca de la visión
- C) Suele ser bilateral
- D) El paciente puede presentar síntomas previos de miodesopsias o fotopsias

Respuesta Correcta: C

376. En las lesiones oculares químicas, señala la Respuesta Correcta:

- A) Las quemaduras por álcalis son más graves que las causadas por ácidos
- B) Eliminar por completo el agente agresor de la superficie ocular mediante lavado abundante debe ser la primera medida del tratamiento
- C) Como tratamiento inicial para disminuir el cuadro inflamatorio está indicado el uso de corticoides tópicos
- D) Todas las anteriores son ciertas





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

377. En el absceso periamigdalino, señale la correcta:

- A) Es más frecuente en ancianos
- B) Clínicamente presenta escaso dolor de garganta y disfagia
- C) Presenta abombamiento unilateral de la amígdala hacia la línea media
- D) Precisa drenaje quirúrgico y antibioterapia con ciprofloxacino

Respuesta Correcta: C

378. ¿Cuál no es etiología de un vértigo periférico?:

- A) Enfermedad de Ménière
- B) Neuritis vestibular
- C) Esclerosis múltiple
- D) Síndrome de Ramsey-Hunt

Respuesta Correcta: C

379. La otitis externa maligna es producida por:

- A) Chlamydia Trachomatis
- B) Estreptococo B-hemolítico del grupo A
- C) Streptococcus Pyogenes
- D) Pseudomona Aeruginosa

Respuesta Correcta: D

380. Señale la respuesta incorrecta en relación con el síndrome de Ménière:

- A) Crisis de vértigo rotatorio de unas horas de duración acompañado de náuseas y vómitos
- B) Acúfenos
- C) Intervalos asintomáticos entre crisis
- D) No presentan hipoacusia

Respuesta Correcta: D





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

381. En el vértigo periférico es típico:

- A) Sensación de caída no de giro
- B) Diplopía y disfagia
- C) El nistagmus se inhibe con la fijación visual
- D) El nistagmus no se inhibe con la fijación visual

Respuesta Correcta: C

382. En la otitis media del adulto, al inicio el tímpano se mostrará:

- A) Perforado central o totalmente
- B) Perforado marginalmente
- C) Opaco, abombado y congestivo
- D) Pálido o normal

Respuesta Correcta: C

383. Son causa de vértigo periférico todas las siguientes excepto:

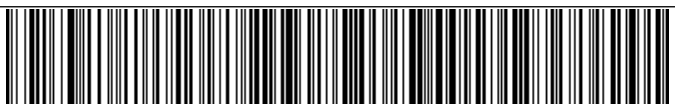
- A) Enfermedad de Ménière
- B) Cuerpos extraños en oído externo
- C) Vértigo paroxístico benigno
- D) Todas las anteriores producen vértigo periférico

Respuesta Correcta: D

384. Una maniobra exploratoria de Dix-Hallpike positiva es útil para el diagnóstico de:

- A) Neuropatía diabética
- B) Vértigo postural paroxístico benigno
- C) Síndrome de Parkinson
- D) Ataxia cerebelosa

Respuesta Correcta: B





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

385. El tratamiento inmediato tras una perforación timpánica de origen traumático por una explosión cercana debe ser:

- A) Tratamiento con gotas anestésicas locales más antibiótico por vía oral
- B) Cirugía inmediata
- C) Actitud expectante, remitir a consultas externas de ORL para seguimiento
- D) Tratamiento con antibióticos por vía oral solamente

Respuesta Correcta: C

386. En relación al embarazo ectópico, señale la respuesta incorrecta:

- A) Su localización más frecuente es la porción ampular o ístmica de la trompa uterina
- B) Suele cursar con la triada clásica de amenorrea, metrorragia y dolor
- C) La ecografía generalmente detecta con nitidez un saco gestacional en el anejo
- D) El tratamiento definitivo puede ser quirúrgico o médico

Respuesta Correcta: C

387. En relación a las hemorragias del segundo y tercer trimestre del embarazo, señale la Respuesta Correcta:

- A) En el desprendimiento de placenta normoinserta, la afectación fetal no depende de la cantidad de placenta desprendida
- B) La cirugía uterina previa no es un factor de riesgo de la placenta previa
- C) La clínica del desprendimiento de placenta normoinserta, cursa con hemorragia vaginal abundante y ausencia de dolor abdominal
- D) Ante una paciente con placenta previa que está estable y el feto no está afectado se debe adoptar una actitud expectante para conseguir la madurez pulmonar

Respuesta Correcta: D

388. Señale la respuesta incorrecta respecto a la patología vulvovaginal:

- A) La tricomoniasis no está considerada como infección de transmisión sexual
- B) La vaginitis más frecuente está producida por candida
- C) El principal motivo de consulta por una vaginosis bacteriana es la leucorrea y el





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

mal olor

- D) El tratamiento del primer episodio del herpes genital se realiza con antivírico oral, ya que la vía tópica no está recomendada

Respuesta Correcta: A

389. En el tratamiento de la preeclampsia grave, señale la respuesta incorrecta:

- A) La prevención farmacológica de convulsiones se hace con sulfato de magnesio
- B) La hidralazina no está contraindicada en enfermedad coronaria
- C) El labetalol está contraindicado en bradicardia materna inferior a 60 latidos por minuto
- D) Se finaliza la gestación si es mayor de 35 semanas

Respuesta Correcta: B

390. En relación con la atención del parto inminente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- A) Se considera parto inminente cuando la mujer presenta pujos intensos con dilatación completa y presentación baja
- B) Cuando el cordón deja de latir se colocan 2 pinzas a unos cuantos centímetros del abdomen del niño y se corta entre ellas
- C) Tras el alumbramiento el útero debe palparse duro y por debajo del ombligo
- D) En medio extrahospitalario o en centros sin presencia de urgencias obstétricas se realizará de forma sistemática episiotomía

Respuesta Correcta: D

391. Una paciente de 32 años con un cuadro clínico de sangrado menstrual irregular, dismenorrea, dispareunia y una esterilidad de 3 años de evolución, presenta una analítica hormonal normal y un estudio ecográfico transvaginal que informa de formaciones quísticas ováricas bilaterales de 4 centímetros ¿Cuál sería la orientación diagnóstica?

- A) Síndrome adherencial pélvico
- B) Hemorragia uterina disfuncional
- C) Síndrome del ovario poliquístico





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Endometriosis

Respuesta Correcta: D

392. Primigesta de 32 años que acude a urgencias refiriendo sangrado genital y prueba de embarazo en farmacia positiva. Se realiza exploración ginecológica y los hallazgos ecográficos y analíticos sugieren el diagnóstico de mola ¿Cuál sería el tratamiento de elección?:

- A) Quimioterapia con metotrexate
- B) Legrado uterino total
- C) Histerectomía con doble anexectomía
- D) Histerectomía simple conservando ovarios

Respuesta Correcta: B

393. En la preeclampsia grave, señale la correcta:

- A) El tratamiento de elección es el nitroprusiato sódico
- B) El tratamiento de elección es la nitroglicerina
- C) El tratamiento de elección es nifedipino sublingual
- D) El tratamiento de elección es el labetalol

Respuesta Correcta: D

394. En la eclampsia son correctas todas excepto:

- A) Administración de sulfato de magnesio intravenoso
- B) No requiere ingreso hospitalario
- C) Parto inmediato mediante cesárea
- D) Si las crisis no se controlan con sulfato de magnesio se puede usar midazolam

Respuesta Correcta: B

395. En un paciente que acude al Servicio de Urgencias por un brote de esquizofrenia ¿Cuál de las siguientes manifestaciones alucinatorias es más frecuente que presente?:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Alucinaciones auditivas
- B) Alucinaciones visuales
- C) Alucinaciones sensitivas táctiles
- D) Alucinaciones olfativas

Respuesta Correcta: A

396. Los factores predictivos de suicidio son múltiples, encontrándose entre ellos los siguientes, excepto:

- A) Intentos de suicidio previos
- B) Cáncer
- C) Consumo de drogas
- D) Embarazo

Respuesta Correcta: D

397. El tratamiento de la crisis de ansiedad incluye:

- A) Calmar al paciente
- B) Mantener al paciente en decúbito supino e indicarle que respire de forma pausada y profunda para evitar hiperventilación
- C) Alprazolam sublingual
- D) Todas las anteriores

Respuesta Correcta: D

398. En el ataque de pánico se dan los siguientes síntomas excepto:

- A) Palpitaciones
- B) Sudoración
- C) Alucinaciones visuales
- D) Parestesias

Respuesta Correcta: C

399. En referencia a las urgencias psiquiátricas, los indicadores siguientes son sugestivos de patología orgánica, señala la respuesta incorrecta:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Inicio brusco sin antecedentes personales de enfermedad psiquiátrica
- B) Alucinaciones visuales, olfativas y táctiles
- C) Alucinosis (alucinaciones con juicio preservado, de las que se realiza crítica)
- D) Alucinaciones auditivas

Respuesta Correcta: D

400. Respecto al intento de suicidio, se consideran intentos graves todos excepto:

- A) Intentos con notas de despedida y preparación en detalle
- B) Intentos con alta probabilidad de rescate
- C) Intentos con armas de fuego, ahorcamiento
- D) Consumo de alcohol para facilitar la ejecución del intento

Respuesta Correcta: B

401. En el episodio psicótico, señale la respuesta falsa:

- A) La sintomatología psicótica intensa que genera gran angustia no es un criterio de ingreso
- B) En la evaluación del paciente psicótico se debe descartar enfermedad orgánica
- C) Es un criterio de ingreso la ausencia de apoyo social y familiar
- D) Son típicas las alucinaciones, lenguaje y comportamiento desorganizado

Respuesta Correcta: A

402. El paciente con agitación psicomotriz, señale la verdadera:

- A) Usar siempre contención mecánica
- B) La contención verbal no es efectiva con estos pacientes
- C) La contención farmacológica debe ser siempre intramuscular
- D) En la agitación no psicótica, si el paciente acepta medicación oral, es suficiente con la administración de benzodiacepinas vía oral.

Respuesta Correcta: D

403. Respecto a la ideación autolítica, señale la afirmación incorrecta:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) No todos los intentos autolíticos deben ser valorados por el psiquiatra
- B) El abuso de alcohol u otros tóxicos es un factor de riesgo de suicidio
- C) Al alta de un paciente con intento autolítico es esencial asegurar que la persona percibe que dispone de recursos de apoyo a su alcance
- D) Si existe alto riesgo de suicidio y el paciente se niega al ingreso, se puede proceder al ingreso involuntario

Respuesta Correcta: A

404. Señale la respuesta falsa en relación a la hipotermia:

- A) Según la escala ICAR-MEDCON hypothermia (HT) scale HT III (28-24°C), cursa con disminución del estado de conciencia sin escalofríos
- B) La hipotermia accidental conjuga un factor imprescindible y un factor predisponente
- C) En la hipotermia moderada desaparece el temblor como reflejo de la incapacidad del organismo para disminuir las pérdidas de calor y aparece rigidez muscular.
- D) En la gasometría arterial inicialmente puede detectarse alcalosis respiratoria y, en fases evolucionadas, acidosis mixta

Respuesta Correcta: A

405. Señale la falsa respecto a las quemaduras térmicas:

- A) Para el cálculo de la superficie corporal quemada total, el sistema recomendado en la actualidad por su mayor precisión es la planilla de Lund y Browder
- B) Vacunación antitetánica. Si el estado de inmunización es desconocido, se administra además inmunoglobulina
- C) Si son necesarios fármacos vasoactivos, solo están indicados en dosis presoras la noradrenalina y dobutamina
- D) Si es necesaria la relajación muscular además de la sedoanalgesia, debe utilizarse, como primera elección la succinilcolina

Respuesta Correcta: D

406. En los pacientes con hipotermia a medida que desciende la temperatura corporal, van apareciendo cambios en el registro del electrocardiograma. ¿Cuál





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

de las siguientes alteraciones se observa en la hipotermia leve?

- A) Bradicardia sinusal con inversión de la onda T y QT ancho
- B) Onda J de Osborn en el complejo QRS
- C) Fibrilación auricular
- D) Arritmias ventriculares

Respuesta Correcta: A

407. En los casos de hipotermia grave, ¿qué parámetros de los siguientes no es típico observar en la analítica sanguínea solicitada en urgencias?

- A) Leucocitosis
- B) Hiperglucemia
- C) Hiperpotasemia
- D) Trombopenia

Respuesta Correcta: A

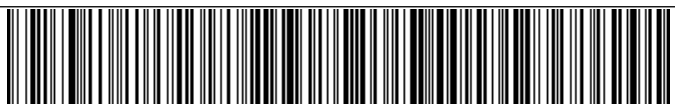
408. Según su localización, son zonas especiales para valorar la gravedad de las quemaduras, todas excepto:

- A) La cara
- B) El abdomen
- C) El periné
- D) Las manos y los pies

Respuesta Correcta: B

409. En el tratamiento de las quemaduras por fuego, son correctas las actuaciones siguientes excepto:

- A) Retirar la vestimenta aplicando agua a temperatura ambiente
- B) Lavado con agua helada
- C) Control del dolor
- D) Desbridar flictenas rotas y con la piel desprendida





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: B

410. Referente a la patología por congelación, todas las respuestas son correctas, excepto:

- A) En el congelamiento superficial la piel está con cianosis importante
- B) Las zonas más afectadas son las partes acras (nariz, orejas, labios, pies, manos)
- C) El congelamiento profundo afecta al músculo y hueso
- D) El tratamiento del congelamiento es sumergir la parte afecta en agua a 38°C durante 15-30 minutos 1 ó 2 veces al día

Respuesta Correcta: A

411. Acude a atender a una paciente que ha sufrido una quemadura con sosa cáustica en el miembro superior izquierdo mientras estaba realizando la limpieza de una habitación poco ventilada. La actuación ante esta paciente incluye:

- A) Valorar siempre si también hay afectación respiratoria por inhalación de la sosa
- B) Si afectación ocular comenzar con irrigación ocular lo antes posible
- C) Retirada inmediata de la ropa e irrigación con agua durante un tiempo prolongado
- D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

412. Respecto a las mordeduras de animales no venenosos, señale la correcta:

- A) La celulitis secundaria a la mordedura es un criterio de ingreso
- B) Evitar la sutura de la herida siempre que sea posible
- C) La profilaxis antibiótica está indicada
- D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

413. Todas las respuestas en relación a las lesiones por electricidad son correctas, excepto:

- A) Hay que desvestir al paciente para permitir la pérdida de calor





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) El rayo es corriente directa que puede producir asistolia con mínimas quemaduras superficiales
- C) Todas las quemaduras eléctricas son graves por definición y requieren ingreso hospitalario, bien en observación del servicio de urgencias si el paciente está hemodinámicamente estable, de lo contrario en una unidad de cuidado intensivos
- D) Vacunación antitetánica si el paciente no está correctamente vacunado

Respuesta Correcta: A

414. En los barotraumatismos los órganos más afectados son:

- A) El pulmón y el árbol bronquial
- B) El oído y los senos paranasales
- C) El sistema ocular
- D) Las fosas nasales y la orofaringe

Respuesta Correcta: B

415. En referencia a la electrocución, es falso que:

- A) La corriente alterna suele producir más daño que la continua
- B) A mayor tiempo de exposición mayor grado de lesión
- C) La midriasis durante la reanimación tiene un valor diagnóstico y pronóstico
- D) Todas las quemaduras eléctricas son graves por definición y requieren ingreso hospitalario

Respuesta Correcta: C

416. Las siguientes son circunstancias que empeoran el pronóstico de los ahogados, excepto:

- A) Ahogamiento en agua salada
- B) Ph arterial < 7
- C) Puntuación en la escala de Glasgow < 6
- D) Ausencia de reactividad pupilar

Respuesta Correcta: A





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

417. Entre los efectos de la electrocución no se encuentra:

- A) Paro respiratorio causado por parálisis del centro respiratorio
- B) Shock distributivo
- C) Isquemia miocárdica por espasmo de las arterias coronarias
- D) Parada respiratoria causada por tetania de los músculos respiratorios

Respuesta Correcta: B

418. Indica la afirmación correcta en relación con los accidentes de buceo:

- A) Los accidentes disbáricos son independientes de la presión o profundidad alcanzada
- B) En los accidentes descompresivos se producen neumotórax y neumomediastino
- C) El accidente descompresivo puede producir en caso de afectación grave lesiones medulares
- D) Los accidentes no disbáricos se producen cuando el buceador asciende de forma demasiado rápida

Respuesta Correcta: C

419. El daño que provoca una corriente eléctrica depende de todos los siguientes factores, excepto uno:

- A) El tipo de corriente
- B) La duración del contacto
- C) Trayectoria de la corriente
- D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

420. Respecto a los accidentes de buceo, indica la respuesta incorrecta:

- A) El barotrauma se produce por el efecto directo de la presión
- B) La enfermedad descompresiva se produce por efectos indirectos de la presión
- C) El tratamiento definitivo de la embolia gaseosa es la cámara hiperbárica
- D) La enfermedad descompresiva tipo I no precisa de tratamiento en la cámara





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

hiperbárica

Respuesta Correcta: D

421. Indica la respuesta falsa en las lesiones producidas por electricidad:

- A) En las lesiones eléctricas no influye el tipo de corriente
- B) La insuficiencia renal aguda por mioglobinuria y hemoglobinuria son bastante frecuentes
- C) Se pueden producir fracturas y luxaciones
- D) La antibioterapia empírica no está indicada

Respuesta Correcta: A

422. En relación a la anafilaxia por picadura de himenópteros, señale la Respuesta Correcta:

- A) El diagnóstico de anafilaxia se basa eminentemente en las pruebas complementarias
- B) El neumotórax a tensión no debe ser considerado un diagnóstico diferencial en los casos de anafilaxia con sintomatología predominantemente respiratoria
- C) Todo paciente con anafilaxia (afectación laríngea, crisis de broncoespasmo) debe ingresar en el área de observación de urgencias
- D) La adrenalina no es el fármaco de primera elección en el tratamiento de la anafilaxia

Respuesta Correcta: C

423. La causa más frecuente de anafilaxia en adultos es:

- A) Alimentos
- B) Contraste radiológico
- C) Picaduras de himenópteros
- D) Fármacos

Respuesta Correcta: D

424. El angioedema caracterizado por el déficit de las concentraciones plasmáticas





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

del inhibidor de la esterasa C1 es:

- A) El angioedema adquirido tipo I
- B) El angiodema adquirido tipo II
- C) El angioedema hereditario tipo II
- D) El angioedema hereditario tipo I

Respuesta Correcta: D

425. El angioedema hereditario se caracteriza por todas las manifestaciones siguientes, excepto:

- A) Edema de dermis profunda y tejido celular subcutáneo
- B) Prurito
- C) Sensación de quemazón y distensión de la piel
- D) Edema del tejido conjuntivo laxo

Respuesta Correcta: B

426. Respecto al tratamiento de la anafilaxia, señale la respuesta falsa:

- A) La adrenalina es el fármaco de primera elección
- B) El glucagón está indicado en pacientes en tratamiento con calcioantagonistas no dihidropirimidínicos
- C) La metilprednisolona es útil para prevenir o disminuir las reacciones tardías
- D) Podemos usar bolos de ringer lactato en la reposición de volumen

Respuesta Correcta: B

427. El angioedema se caracteriza por lo siguiente, señale la verdadera:

- A) Edema de la dermis superficial y del tejido celular subcutáneo
- B) La afección de la mucosa laringea puede ocasionar edema de glotis
- C) Nunca cursa con urticaria
- D) Por la afección de la mucosa gastrointestinal siempre está presente el estreñimiento

Respuesta Correcta: B





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

428. En el diagnóstico de la anafilaxia es cierto que:

- A) Es eminentemente clínico
- B) Las exploraciones complementarias urgentes no aportan nada al diagnóstico
- C) Se realiza gasometría arterial o venosa, si se detectan signos de insuficiencia respiratoria o se sospecha alteración del equilibrio ácido- básico, respectivamente
- D) Todas las anteriores son ciertas

Respuesta Correcta: D

429. En el tratamiento de la anafilaxia está indicado:

- A) Fentanilo sublingual/oral
- B) Adrenalina
- C) Aceclofenaco
- D) Atropina

Respuesta Correcta: B

430. Tras la administración de una dosis única de penicilina intramuscular a un enfermo en el que no se conocían antecedentes alérgicos a la sustancia, aparecen de forma brusca síntomas de enrojecimiento de la piel de forma generalizada, broncoconstricción y angustia. Si tienes a mano los siguientes fármacos ¿cuál de ellos elegirías para administrar?:

- A) Midazolam
- B) Dopamina
- C) Adrenalina
- D) Cloruro mórfico

Respuesta Correcta: C

431. Respecto a la urticaria indica la respuesta falsa:

- A) Es una reacción cutánea mediada por Ig E





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Los pacientes con urticaria no requieren ingreso hospitalario
- C) El tratamiento se basa en corticoides tópicos
- D) El eritema multiforme es una variante de urticaria

Respuesta Correcta: C

432. ¿Cuál de las siguientes escalas refleja un aumento de riesgo de muerte en paciente con shock séptico en el medio hospitalario?:

- A) APACHE II
- B) WELL
- C) SOFA
- D) RANSON

Respuesta Correcta: C

433. Respecto al tratamiento inicial del shock séptico, es cierto:

- A) La noradrenalina no es el fármaco vasopresor de elección en el shock séptico
- B) Se recomienda la administración precoz de antibiótico intravenoso dentro de la primera hora tras el diagnóstico
- C) La reposición de líquidos se realiza en bolos de 1000 ml cada 60 minutos
- D) Los coloides son de primera elección en la reposición de volumen en el shock séptico

Respuesta Correcta: B

434. ¿Cuál de las siguientes propuestas no se considera criterio de ingreso hospitalario en el síndrome febril?:

- A) Paciente pluripatológico con fiebre mayor de 38°C
- B) Fiebre de duración intermedia con imposibilidad de manejo ambulatorio
- C) Fiebre de más de 21 días aunque no presente criterios de gravedad
- D) Síndrome febril sin foco clínico que presente criterios clínicos o analíticos de gravedad independientemente del tiempo de evolución

Respuesta Correcta: A





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

435. Ante un paciente con síndrome febril que acude al Servicio de Urgencias hospitalario; ¿cuál de los siguientes se considera criterio mayor de riesgo de bacteriemia?

- A) Leucocitosis de 18000/mm³
- B) Temperatura mayor de 39,4 °C
- C) Creatinina mayor de 2 mg/dl
- D) Hipotensión arterial con presión sistólica menor de 90 mm Hg

Respuesta Correcta: B

436. ¿Cuál de estos fenómenos clínicos o fisiológicos NO se considera dentro del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica?:

- A) Temperatura
- B) Frecuencia respiratoria
- C) Hipocapnia
- D) Oliguria

Respuesta Correcta: D

437. Respecto al shock séptico, señale lo falso:

- A) Suele existir hipovolemia, por lo que reponer volumen es esencial
- B) Usar noradrenalina en caso de hipotensión que no responda a fluidos
- C) Los corticoides tienen un papel fundamental en este tipo de shock
- D) El tratamiento antibiótico debe iniciarse de forma precoz, en la primera hora de asistencia

Respuesta Correcta: C

438. Paciente con cuadro febril de 2 días de evolución y sin foco aparente, se trataría con:

- A) Antitérmicos como paracetamol
- B) Antitérmicos + claritromicina
- C) Antitérmicos + doxiciclina
- D) Nada de lo anterior





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

439. Ante un paciente trasplantado hepático que acude a urgencias por fiebre de 38,5 °C de 48 horas de evolución, con fórmula leucocitaria normal, la conducta sería:

- A) Administrar antitérmicos y remitir a domicilio para control posterior en consulta correspondiente
- B) Antibioterapia endovenosa y continuar en domicilio con antibioterapia oral
- C) Protección con mascarilla, realizar hemocultivos y administración de antibioterapia empírica
- D) Ninguna de las anteriores

Respuesta Correcta: C

440. Respecto a la neutropenia febril en el paciente oncológico, es cierto:

- A) Se considera cuando hay menos de 1500 neutrófilos/ mm³
- B) Se considerará la etiología infecciosa de la fiebre cuando además haya signos de respuesta inflamatoria sistémica
- C) Iniciaremos el tratamiento antibiótico cuando haya aislamiento microbiológico positivo para así dirigir la antibioterapia
- D) Es criterio de ingreso y de aislamiento

Respuesta Correcta: D

441. La escala qSOFA incluye para la valoración de la existencia de shock séptico, además de la sospecha o confirmación de infección, la presencia de los siguientes criterios, excepto uno:

- A) Taquicardia >120
- B) Alteración del nivel de conciencia
- C) PAS ≤ 100 mm Hg
- D) Frecuencia respiratoria ≥ 22 respiraciones/ minuto

Respuesta Correcta: A

442. En una gangrena gaseosa traumática el patógeno involucrado con mayor





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

frecuencia es:

- A) Staphylococcus Aureus
- B) Pseudomona Aeruginosa
- C) Clostridium Perfringens
- D) Candida Albicans

Respuesta Correcta: C

443. En relación con los abscesos cutáneos es cierto que:

- A) Además de presentarse como proceso localizado, puede presentarse un mayor o menor grado de afectación sistémica
- B) En la exploración insistiremos en descartar presencia de cuerpos extraños
- C) Debemos indagar en la anamnesis sobre situaciones que puedan ensombrecer el pronóstico o condicionar el tratamiento
- D) Todas las anteriores son ciertas

Respuesta Correcta: D

444. En la gangrena gaseosa es cierto que:

- A) Se caracteriza por necrosis muscular rápida y extensa con formación de gas y toxicidad sistémica
- B) Período de incubación de menos de 3 días.
- C) Es una mionecrosis por clostridium
- D) Todas las anteriores son ciertas

Respuesta Correcta: D

445. Respecto a la celulitis en urgencias, señale la Respuesta Correcta:

- A) La celulitis afecta en mucha mayor proporción y gravedad a ancianos, pacientes inmunodeprimidos y a quienes tienen vasculopatía periférica
- B) No es preciso toma de hemocultivos aunque haya afectación sistémica
- C) Siempre se acompaña de fiebre y leucocitosis
- D) Debido a que es una enfermedad de fácil diagnóstico y tratamiento no precisa hospitalización ni antibióticos endovenosos.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

446. Señale la respuesta incorrecta en relación al manejo de los abscesos cutáneos en urgencias:

- A) Las especies estafilocócicas son los patógenos infecciosos usuales en el caso de los abscesos que afectan al cuero cabelludo, tronco y extremidades
- B) En los abscesos secundarios a cuerpos extraños, Estafilococo Aureus es la especie que más frecuentemente se aísla
- C) La presencia de linfadenitis, linfadenopatía localizada o fiebre puede indicar diseminación sistémica de la infección
- D) La incisión y drenaje son el tratamiento de elección, sin precisar en ningún caso antibioterapia

Respuesta Correcta: D

447. Señale la respuesta incorrecta en relación a la gangrena gaseosa:

- A) La gangrena gaseosa o mionecrosis por clostridium es una infección de tejidos blandos de progresión rápida, que pone en grave peligro de muerte al paciente y hace peligrar la extremidad afecta
- B) La ausencia de crepitación en la exploración física no descarta el diagnóstico de gangrena gaseosa
- C) Debe sospecharse en aquel paciente con dolor desproporcionado a los datos físicos y sensación de pesadez de la parte afectada, con o sin febrícula y taquicardia significativa
- D) Su tratamiento consiste en antibioterapia iv, no precisa de desbridamiento quirúrgico

Respuesta Correcta: D

448. Respecto al tratamiento de la celulitis es cierto que:

- A) En pacientes previamente sanos y celulitis leve se recomienda tratamiento vía oral con amoxicilina- clavulánico o cefditoreno
- B) En pacientes sanos con celulitis extensas o graves se recomienda tratamiento vía parenteral con amoxicilina- clavulánico o cloxacilina
- C) En pacientes con comorbilidad o inmunosupresión y celulitis se recomienda





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- tratamiento con ceftriaxona asociada a cloxacilina endovenosa
D) Todas las anteriores son ciertas

Respuesta Correcta: D

449. En las infecciones de la piel y partes blandas, son síntomas y signos de alarma todos los siguientes, excepto:

- A) Dolor desproporcionado a los hallazgos exploratorios u otros signos de síndrome compartimental
- B) Lenta progresión del eritema o del borde de la lesión
- C) Presencia de gas en los tejidos (crepitación o gas en las pruebas de imagen)
- D) Signos de afectación sistémica

Respuesta Correcta: B

450. En las infecciones de la piel y tejidos blandos en urgencias, señala la afirmación correcta:

- A) Son un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias
- B) Su espectro clínico abarca desde procesos banales hasta muy letales
- C) En urgencias es fundamental determinar la gravedad del cuadro, lo que nos permitirá la toma de decisiones, y tendrá implicación pronóstica, en cuadros potencialmente letales como las infecciones necrotizantes
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

451. Niña de 3 años que consulta por fiebre de Tª máxima 40°C de unas 12 horas de evolución que se acompaña de babeo y rechazo de la alimentación. Exploración sin hallazgos salvo varias lesiones aftosas orofaríngeas y sialorrea. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A) Herpangina
- B) Escarlatina





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) Enfermedad de Kawasaki
- D) Gingivoestomatitis herpética

Respuesta Correcta: A

452. ¿Cuál de las siguientes es una complicación no supurativa de la faringoamigdalitis estreptocócica?

- A) Osteomielitis
- B) Absceso hepático
- C) Púrpura anafilactoide
- D) Endocarditis

Respuesta Correcta: C

453. Señale a qué enfermedad corresponde un exantema maculopapuloso que se inicia detrás de los pabellones auriculares y en la raíz del pelo, extendiéndose posteriormente a cara y cuello durante el primer día.

- A) Sarampion
- B) Rubeola
- C) Enfermedad de Kawasaki
- D) Varicela

Respuesta Correcta: A

454. La ocurrencia de 3 episodios de otitis media aguda en 6 meses en el niño se denomina:

- A) Otitis media aguda esporádica
- B) Otitis media aguda persistente
- C) Otitis media aguda recidivante
- D) Otitis media aguda recurrente

Respuesta Correcta: D

455. Niño de 11 meses que consulta por fiebre de Tª 38,7°C de 60 horas de evolución. Ya no utiliza pañal y la exploración es anodina.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Solicita tira de orina por micción espontánea
- B) Solicita hemograma y PCR por tiempo de evolución
- C) Alta a domicilio con antitérmicos y recomendaciones
- D) Alta a domicilio con antibióticos empíricos

Respuesta Correcta: C

456. Señale cuál de las siguientes es característica de las convulsiones febriles típicas de la infancia

- A) Son crisis focales
- B) Su duración es superior a 30 minutos
- C) Presencia de signo de Babinsky en el periodo postcrítico
- D) Se presentan en niños mayores de tres meses

Respuesta Correcta: D

457. Señale cuál de las siguientes es una medida recomendable durante una crisis que esta Ud presenciando en este momento.

- A) Colocar en decúbito lateral izquierdo
- B) Forzar la apertura de la boca para colocar una cánula de Guedel
- C) Administrar fármacos anticomiciales desde el primer momento de la crisis
- D) Tratar la fiebre si la hubiera

Respuesta Correcta: D

458. Señale en cuál de las siguientes situaciones clínicas indicaría la administración de adrenalina intramuscular en el niño con crisis asmática

- A) En toda crisis asmática
- B) En una crisis grave en el contexto de una anafilaxia
- C) Inicialmente en una crisis moderada grave
- D) Nunca está indicada la administración de dicho fármaco

Respuesta Correcta: B





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

459. ¿Qué causas poco frecuentes no debemos pasar por alto en el lactante que llora?

- A) Dedo o pene estrangulado con hilo
- B) Úlcera corneal
- C) Objeto irritante, etiqueta, imperdible ...
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

460. La causa más frecuente de ictericia en el recién nacido es:

- A) Trastorno hepático
- B) Ictericia fisiológica
- C) Hipotiroidismo
- D) Infección grave

Respuesta Correcta: B

461. Se debe extremar las medidas de vigilancia y detección de ictericia precoz en un recién nacido cuando se trata de:

- A) Primer embarazo madre Rh+ y neonato Rh-.
- B) Segundo embarazo madre Rh- y neonato Rh+.
- C) Segundo embarazo madre Rh+ y padre Rh-.
- D) Segundo embarazo padre Rh- y neonato Rh+.

Respuesta Correcta: B

462. Señale la afirmación incorrecta respecto a la intususcepción neonatal:

- A) La intususcepción es la invaginación de un segmento del intestino dentro de otro, por lo general en niños < 3 años.
- B) Los niños por lo general se presentan con dolor abdominal tipo cólico y vómitos, seguidos por la evacuación de heces en jalea de grosellas.
- C) El diagnóstico se realiza con una TAC abdominal
- D) El tratamiento es la reducción por enema de aire y, en algunos casos, cirugía.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: C

463. Una de las siguientes enfermedades está asociada frecuentemente a la invaginación intestinal del neonato:

- A) Fibrosis quística
- B) Hidrocefalia
- C) Cardiopatías congénitas
- D) Criptorquidia

Respuesta Correcta: A

464.Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en la estenosis pilórica:

- A) Los vómitos en chorro se producen poco después de la alimentación en un lactante < 3 meses de edad, en general entre 3 y 6 semanas.
- B) El diagnóstico se realiza con una ecografía.
- C) El tratamiento es la incisión quirúrgica del músculo pilórico hipertrofiado.
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

465. Respecto al tratamiento de la estenosis pilórica, indique la afirmación correcta:

- A) La pilorotomía no tiene grandes tasas de éxito
- B) El tratamiento definitivo consiste en hidratación agresiva con soluciones cristaloides.
- C) El tratamiento inicial de la estenosis pilórica hipertrófica está dirigido a la hidratación y la corrección de las alteraciones electrolíticas.
- D) Todas son falsas

Respuesta Correcta: C

466. El vólvulo intestinal del lactante es:

- A) La malrotación intestinal se presenta en 1/500 nacimientos produciendo sintomatología solo en 1/5.000





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) La malrotación intestinal es un factor predisponente para el vólvulo y la obstrucción intestinal en el periodo neonatal y en la infancia.
- C) La clínica aparece el 75% de las veces en el primer mes de vida y hasta en un 90% en el primer año
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

467. ¿Cuál de los enunciados siguientes es CORRECTO?:

- A) El diagnóstico de vólvulo intestinal requiere un alto índice de sospecha.
- B) Ante una clínica compatible con vólvulo intestinal debe realizarse una radiografía de abdomen como primera prueba
- C) La ecografía abdominal, útil para localizar los vasos mesentéricos y descartar malrotación y posible vólvulo, u otras malformaciones
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

468. Un factor principal de riesgo para la ictericia en un recién nacido es:

- A) Alimentación con biberón exclusivamente
- B) Trabajo de parto de más 36 horas
- C) Prematuridad (35 a 36 semanas de gestación)
- D) Incompatibilidad con el grupo sanguíneo del padre

Respuesta Correcta: C

469. Una afirmación correcta acerca de la ictericia fisiológica en un recién nacido es que la ictericia:

- A) Está siempre presente al nacimiento.
- B) Puede desarrollarse entre 2 y 3 días después del nacimiento.
- C) Siempre requiere de fototerapia.
- D) Generalmente se alivia con una lactancia más frecuente.

Respuesta Correcta: B





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

470. ¿Cuál de las siguientes características NO es correcta sobre la disnea en el síndrome de la vena cava superior?

- A) Empeora con el decúbito
- B) Mejora con la sedestación
- C) Mejora en posición de cuclillas.
- D) Empeora con la flexión del tronco hacia adelante

Respuesta Correcta: C

471. ¿Cuál es el síntoma inicial más frecuente en el síndrome de compresión medular?

- A) Debilidad muscular
- B) Alteraciones sensitivas como parestesias y disestesias
- C) Alteraciones vegetativas, estreñimiento y vaciamiento incompleto vejiga
- D) Empeoramiento progresivo de un dolor de espalda

Respuesta Correcta: D

472. ¿Cuál es el segmento mas afectado en el síndrome de compresión medular?

- A) Cervical
- B) Dorsal
- C) Lumbar
- D) Sacro

Respuesta Correcta: B

473. En relación a la neutropenia febril, señale la opción correcta

- A) La existencia de un foco infeccioso solo se detecta en el 20-30% de los casos
- B) La obtención de hemocultivos no es necesaria antes de iniciar la antibioterapia empírica
- C) La exploración física de los paciente suele ser anodina
- D) La radiografía de tórax solo se solicita en caso de clínica respiratoria

Respuesta Correcta: A





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

474. ¿En relación a la neutropenia febril, señale la opción correcta?

- A) El riesgo de infecciones graves es independiente de la severidad del recuento de neutrófilos
- B) El riesgo de infecciones es mayor cuanto mas se prolongue en el tiempo la neutropenia
- C) La enfermedad de base no influye en el riesgo de contraer infecciones en el paciente con neutropenia febril
- D) La rapidez en la administración de la antibioterapia no influye en el pronóstico

Respuesta Correcta: B

475. ¿Señale cuál de las siguientes opciones definen a la neutropenia febril?

- A) Recuento absoluto de granulocitos inferior a 500/microlitro
- B) Temperatura axilar superior a 38,5°C en el momento de la consulta
- C) Temperatura axilar superior a 38°C en tres determinaciones separadas
- D) Todas las respuestas son correctas

Respuesta Correcta: D

476. ¿Con respecto al síndrome de vena cava superior, es cierto que?:

- A) Los síntomas mas frecuentes son ronquera, síncope, cefalea y mareo.
- B) La radioterapia no suele ser eficaz
- C) La neoplasia mas frecuentemente asociada es el cáncer de pulmón
- D) La mayor parte de los pacientes se deterioran en las dos primeras semanas tras el diagnóstico

Respuesta Correcta: C

477. ¿Cuál de los siguientes fármacos administraría en primer lugar en un síndrome de compresión medular en un paciente oncológico?

- A) Bemiparina
- B) Rasburicasa
- C) Radioterapia





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Dexametasona

Respuesta Correcta: D

478. ¿Cuál de las siguientes alteraciones analíticas NO es frecuente encontrar en el síndrome de lisis tumoral?

- A) Hiperuricemia
- B) Hiperfosforemia
- C) Hiperpotasemia
- D) Hipercalcemia

Respuesta Correcta: D

479. El síndrome de dolorimiento muscular diferido (agujetas) se caracteriza por:

- A) Comienzo entre 24-48 horas tras la realización de la actividad
- B) Tumefacción
- C) Pérdida de hasta el 50% de la fuerza de contracción isométrica
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

480. El síndrome compartimental:

- A) Es mas frecuente en ancianos
- B) El muslo es la parte anatómica en la que se observa mas frecuentemente
- C) El pulso y el relleno capilar pueden estar inalterados en casos severos
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: C

481. La llamada fractura de la marcha o de los reclutas es un ejemplo de:

- A) Fractura patológica
- B) Fractura por fatiga o sobrecarga
- C) fractura de la lamina epifisaria
- D) Fractura de Salter





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: B

482. La prueba de Finkestein positiva se aprecia en:

- A) Síndrome del túnel carpiano carpiano
- B) Contractura de Dupuytren
- C) Tenosinovitis estenosante de Quervain
- D) Quiste ganglionar.

Respuesta Correcta: C

483. Sobre la fractura en tallo verde, señale la respuesta INCORRECTA

- A) Es una fractura característica de la infancia
- B) Ambas corticales óseas están rotas
- C) Afecta principalmente a huesos largos
- D) Su tratamiento habitual es quirúrgico

Respuesta Correcta: B

484. La fractura diafisaria de húmero se asocia con cierta frecuencia a lesiones del nervio:

- A) Circunflejo
- B) Radial
- C) Mediano
- D) d.Cubital

Respuesta Correcta: B

485. ¿Cuál de los siguientes es el mecanismo más habitual de producción de un esguince de tobillo?

- A) Inversión- aducción en flexión plantar
- B) Inversión-abducción en flexión dorsal
- C) Eversión- abducción en flexión dorsal
- D) Inversión pura





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

486. ¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma característico de un esguince de tobillo?

- A) Edema
- B) Equimosis
- C) Dolor intenso que mejora en pocos minutos y empeora en las siguientes 24 horas
- D) Funcionalidad conservada

Respuesta Correcta: D

487. El tratamiento de los esguinces grado I-II se basa en todo lo siguiente SALVO:

- A) Reposo funcional
- B) Inmovilización mediante férula posterior
- C) Elevación
- D) Hielo local durante 24-72 horas

Respuesta Correcta: B

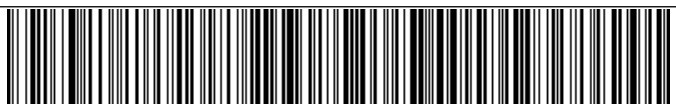
488. ¿Cuál es el patógeno más común en la artritis séptica?

- A) E.coli
- B) Brucella
- C) Streptococcus
- D) S. Aureus

Respuesta Correcta: D

489. ¿Cuál de las siguientes estructuras NO causa dolor cervical de manera directa?

- A) Ligamentos y musculatura paravertebral
- B) Raíces nerviosas
- C) Carillas y capsula de la articulación interapofisaria
- D) Discos intervertebrales





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

490. El estudio de imagen de elección para la valoración de una cervicalgia atraumática es:

- A) TAC
- B) Rx simple
- C) RMN
- D) ArtroRMN

Respuesta Correcta: B

491. ¿Cuál de las siguientes estructuras NO causa dolor cervical de manera directa?

- A) Ligamentos y musculatura parvertebral
- B) Raíces nerviosas
- C) carilla y articulación interapofisaria
- D) Discos intervertebrales

Respuesta Correcta: D

492. En el diagnóstico diferencial entre claudicación neurógena y vascular ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- A) El dolor mejora al ponerse de pie en la neurógena
- B) En la neurógena el dolor no se alivia con la flexión de la columna
- C) En la claudicación vascular los pulsos periféricos suelen estar disminuidos
- D) En la neurógena existe una pérdida de la sensibilidad segmentaria

Respuesta Correcta: B

493. De las características del dolor en una cervicalgia mecánica que se exponen a continuación, indique la FALSA:

- A) Mejora con el reposo





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) No despierta al paciente
- C) Aumenta con los movimientos
- D) No es constante

Respuesta Correcta: C

494. En el estudio RX simple de columna, es cierto que:

- A) Las proyecciones AP-L pueden ser de ayuda a las oblicuas, que son las primeras en solicitar
- B) No es necesaria realizarla siempre. Solo tras una lumbalgia mecánica de 6 semanas de evolución o que existan signos de alarma.
- C) No nos permite valorar la presencia de signos degenerativos
- D) Si se sospecha inestabilidad hay que pedir una proyección lateral

Respuesta Correcta: B

495. En cuanto al estudio del dolor lumbar existen una serie de “red flags” que nos deben de poner en alerta, ¿cuál de las siguientes no se considera así?

- A) Ganancia de peso >10Kg en 6 semanas
- B) Disminución del tono del esfínter anal o incontinencia fecal
- C) Pie caído
- D) Déficit neurológico progresivo

Respuesta Correcta: A

496. ¿Qué se considera lumbalgia aguda?

- A) Dolor lumbar con una duración de entre 6-12 semanas
- B) Dolor lumbar con una duración de >12 semanas
- C) Dolor lumbar con una duración de entre 6-12 meses
- D) Dolor lumbar con una duración de <24 horas

Respuesta Correcta: A

497. Un paciente en coma con los miembros superiores en extensión, aproximación y rotación interna, y los inferiores en extensión indica:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Estado postcrítico
- B) Rigidez de decorticación
- C) Rigidez de descerebración
- D) Lesión protuberancial inferior

Respuesta Correcta: C

498. Paciente que traen al servicio de Urgencias con traumatismo facial y en la exploración maxilar se objetiva que la arcada superior y la raíz nasal son móviles, pero la sutura frontomalar restá estable. El diagnostico correcto es :

- A) Fractura de LeFort I
- B) Fractura de LeFort II
- C) Fractura de LeFort III
- D) Fractura de LeFort IV

Respuesta Correcta: B

499. Traen a un paciente al Servicio de Urgencias con un TCE y un CGS de 15 puntos. Según los criterios de Nueva Orleans habría que realizar un TAC craneal si presenta:

- A) Cefalea
- B) Edad >60 años
- C) Amnesia anterograda
- D) Todas la anteriores

Respuesta Correcta: D

500. En el Traumatismo Craneoencefálico:

- A) La infusión precoz de albúmina parece disminuir la mortalidad en estos pacientes.
- B) La hipotensión permisiva, especialmente en ancianos, puede ser beneficiosa como estrategia neuroprotectora
- C) La hipocapnia puede empeorar la isquemia cerebral





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Todas son falsas

Respuesta Correcta: C

501. En los traumatismos craneales:

- A) La mayor parte de las fracturas craneales lineales en adultos no tienen relevancia clínica
- B) Las fracturas de la base de cráneo no se asocian con un riesgo significativo de hematoma epidural
- C) El signo de Battle aparece de forma característica de forma precoz tras una fractura de bases de cráneo
- D) Ninguna de las anteriores es cierta

Respuesta Correcta: A

502. En relación a las fracturas orbitarias, señale la opción correcta

- A) Se puede encontrar en la exploración física enfisema subcutáneo orbicular
- B) Su tratamiento siempre es quirúrgico
- C) La lesión del nervio orbitario se produce generalmente en las fracturas del suelo orbitario
- D) La valoración radiológica se realiza mediante una Rx de cráneo

Respuesta Correcta: A

503. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos NO indica necesariamente fractura de la base del cráneo?

- A) Otolicuarrea
- B) Signo de Battle
- C) Otorragia
- D) Rinoliciorrea

Respuesta Correcta: C

504. Pueden ser manifestaciones clínicas de la hipertensión alacranera todas las siguientes excepto:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Cefalea
- B) Taquicardia
- C) Disminución del nivel de conciencia
- D) Alteraciones del ritmo respiratorio

Respuesta Correcta: B

505. ¿Cuál de las siguientes circunstancias define a un traumatismo craneoencefálico como grave?

- A) CGS mayor o igual a 13 puntos
- B) CGS igual o menor a 9 puntos
- C) Intoxicación por alcohol
- D) Amnesia

Respuesta Correcta: B

506. ¿Cuál de los siguientes NO es un mecanismo de producción de una fractura vertebral?

- A) Flexión
- B) Compresión axial
- C) Flexión-hiperextensión
- D) Todas ellas

Respuesta Correcta: D

507. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico para las fracturas vertebrales son:

- A) Fracaso tratamiento ortopédico
- B) Déficit neurológico establecido y completo
- C) Fracturas inestables
- D) Todas ellas

Respuesta Correcta: D

508. La presencia del reflejo bulbo-cavernoso indica:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Resolución shock medular y que la posible lesión es irreversible
- B) Presencia de función motora y sensitiva normal
- C) Se mantiene la capacidad de movimientos contra gravedad
- D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: A

509. Ante un lesionado medular, que presenta en la radiografía transoral de odontoides una fractura del cuello de la apófisis odontoides del axis, señale lo correcto

- A) Se manifiesta clínicamente por cervicalgia irradiada a la zona retroauricular
- B) Es una lesión inestable
- C) Se produce por mecanismo de hiperflexión o hiperextensión
- D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

510. ¿Cuál de las siguientes circunstancias NO se relaciona con un mayor riesgo de lesión raquimedular en el paciente politraumatizado?

- A) Embriaguez
- B) Impacto por encima de las clavículas
- C) Impacto con desaceleración brusca
- D) Utilización de casco protector en motoristas

Respuesta Correcta: D

511. Señale cuál de las siguientes aseveraciones es correcta respecto a los corticoides en el tratamiento de la lesión medular aguda traumática

- A) Se recomiendan corticoides a altas dosis
- B) Se recomiendan corticoides a dosis bajas, estandard
- C) No recomiendan
- D) Solo se recomiendan en traumatismos medulares penetrantes

Respuesta Correcta: C





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

512. Señale cuál de las siguientes es la causa más frecuente de lesión medular en nuestro medio

- A) Accidente de tráfico
- B) Caídas
- C) Agresiones
- D) Zambullidas

Respuesta Correcta: B

513. El manejo terapéutico del shock medular por lesión medular NO incluye:

- A) Fluidoterapia intravenosa
- B) Corticoides
- C) Administración de noradrenalina
- D) Administración de agentes vasocativos

Respuesta Correcta: B

514. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones son propias al shock medular?

- A) Respiración diafragmatica
- B) Hipotensión arterial
- C) Bradicardia
- D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

515. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alerta de lesión medular aguda en un paciente víctima de un impacto traumático?

- A) Priapismo
- B) Vómitos
- C) Dolor lumbar
- D) Taquicardia con sudoración profusa

Respuesta Correcta: A





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

516. Las fracturas vertebrales en la infancia se producen fundamentalmente por:

- A) Accidentes tráfico
- B) Maltrato
- C) Caídas a cierta altura
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

517. El tratamiento de las fracturas vertebrales en la infancia suele ser:

- A) Tratamiento conservador
- B) Tratamiento quirúrgico
- C) Cifoplastia
- D) Ninguna de ellas

Respuesta Correcta: A

518. El tratamiento quirúrgico en las fracturas osteoporóticas está indicado en:

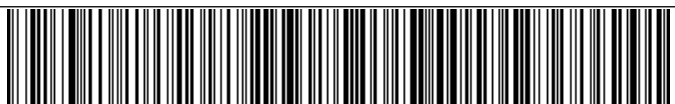
- A) Deformidad progresiva con cifosis marcada y dolor refractario
- B) Inestabilidad vertebral con o sin déficit neurológico asociado
- C) Cuando generan estenosis del canal
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

519. Ante la sospecha de una fractura vertebral por fragilidad, en la Rx simple se pueden observar varios patrones de fractura:

- A) Acuñaamiento anterior
- B) Aplastamiento uniforme
- C) Aplastamiento central
- D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

520. ¿Cuál es el segmento vertebral más afectado en las fracturas osteoporóticas?

- A) L1-L5
- B) T7-L2
- C) T1-T12
- D) L4-L5

Respuesta Correcta: B

521. La mayoría de los pacientes con fracturas vertebrales se tratan mediante:

- A) Descompresión anterior
- B) Descompresión posterior
- C) Inmovilización y deambulación precoz
- D) Ninguna de las anteriores

Respuesta Correcta: C

522. La realización de RX dinámicas de la columna cervical deben de realizarse solo si:

- A) Tras la realización de estudios previos se tiene la certeza de que no hay signos de inestabilidad
- B) Existe mala alineación de las apófisis espinosas en la proyección AP
- C) Se sospecha fractura de odontoides
- D) Deben de realizarse de entrada

Respuesta Correcta: A

523. En el manejo de un paciente con esguince cervical tras un accidente de tráfico, una de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- A) El estudio radiológico debe incluir radiografías AP, L y transoral para descartar lesión
- B) El tratamiento en la fase aguda consiste en AINES, relajantes musculares, calor seco local e inmovilización de la columna cervical con collarín al menos 15 días.
- C) La listesis anterior mayor de 3,5mm en vertebrales superiores a C4 es un signo radiográfico de gravedad





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- D) La separación anormal entre apofisis espinosas o fractura horizontal en ellas es signo radiológico de gravedad

Respuesta Correcta: B

524. Señale la Respuesta Correcta sobre una fractura por compresión simple a nivel de la columna vertebral:

- A) Suelen ser lesiones estables
- B) Afectan al pilar anterior vertebral
- C) La altura de la porción posterior del cuerpo vertebral no esta afectada
- D) Todas las anteriores son correctas

Respuesta Correcta: D

525. La fractura-luxación de Bennet es la fractura de:

- A) Base del primer metacarpiano
- B) Cuello del quinto metacarpiano
- C) Olécranon
- D) Estiloides radial

Respuesta Correcta: A

526. La fractura diafisaria del húmero se asocia con cierta frecuencia a lesiones del nervio:

- A) Circunflejo
- B) Radial
- C) Mediano
- D) Cubital

Respuesta Correcta: B

527. Según la clasificación de Rockwood y Matsen, señale que tipo de luxación acromioclavicular corresponde a una luxación posterior, con rotura completa de los ligamentos acromio y coracoclaviculares, así como del deltoides y del trapecio con desplazamiento posterior de la clavícula:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Tipo I
- B) Tipo II
- C) Tipo III
- D) Tipo IV

Respuesta Correcta: D

528. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta en relación a la fractura del escafoides carpiano?

- A) Se produce por caída sobre la mano extendida
- B) Existe tumefacción y dolor a la palpación en la tabaquera anatómica, que se intensifica con movimientos de lateralización radial de la mano
- C) Siempre es visible en la radiografía desde el inicio.
- D) Su tratamiento ortopédico requiere inmovilización muy breve de 4 semanas

Respuesta Correcta: B

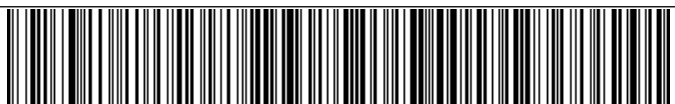
529. Señale la opción INCORRECTA respecto a la fractura supracondílea de humero:

- A) Suele producirse por caídas sobre la mano con el codo en flexión o en extensión, o por el impacto directo sobre el codo
- B) Tras traumatismo, el codo puede quedar en flexión o en extensión
- C) La complicación más importante es la isquemia aguda de la extremidad
- D) En las fracturas no desplazadas está indicado el tratamiento quirúrgico

Respuesta Correcta: D

530. La fractura del radio distal:

- A) Es la más frecuente de la extremidad superior
- B) Afecta principalmente a mujeres entre 40-60 años
- C) En los niños es la fractura más frecuente de todo su cuerpo
- D) Todas son ciertas





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

531. La maniobra de Kocher se usa para reducir:

- A) Luxación acromioclavicular
- B) Luxación glenohumeral anterior
- C) Luxación glenohumeral posterior
- D) Fractura-luxación de hombro

Respuesta Correcta: B

532. En las fracturas del escafoides carpiano, señale la respuesta INCORRECTA

- A) Se producen en caídas sobre la mano extendida
- B) Son frecuentes en adultos jóvenes
- C) La consolidación retardada es la complicación más frecuente
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

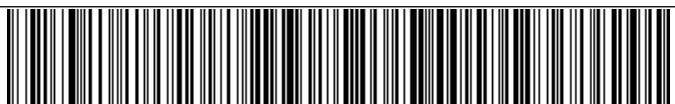
533. En la fractura del tubérculo menor o troquín de la extremidad proximal del humero es cierto que:

- A) Son más frecuentes que las fracturas del tubérculo mayor
- B) Sufren un desplazamiento hacia fuera por efecto de la contracción muscular
- C) Afectan al labio externo de la correa bicipital cuando la fractura es desplazada
- D) Pueden acontecer aisladamente o coexistir con una luxación anterior

Respuesta Correcta: C

534. Mujer de 65 años que sufrió caída sobre mano derecha extendida. Presentaba deformidad de la muñeca en tenedor y Rx se confirma la presencia de fractura, por lo que se realiza tratamiento conservador con yeso cerrado antebraquial 6 semanas. A las 2 semanas de retirar el yeso acude a Urgencias por la imposibilidad para extender el primer dedo de la mano afecta. La lesión que sospecharíamos es:

- A) Lesión diferida del nervio radial
- B) Rotura diferida del extensor largo del pulgar





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) Lesión diferida del nervio mediano
- D) Rotura diferida del extensor corto del pulgar

Respuesta Correcta: B

535. De los criterios de Gurd y Wilson para diagnóstico de Síndrome de embolia grasa, cuál no es un criterio mayor:

- A) Petequias subconjuntivales y xilares
- B) Anemia súbita inexplicable
- C) Insuficiencia respiratoria
- D) Depresión SNC

Respuesta Correcta: B

536. En un paciente de 80 años con acortamiento-aducción y rotación interna del miembro inferior sospecharemos:

- A) Fractura de cadera
- B) Fractura diafisaria de femur
- C) Luxación anterior de cadera
- D) Luxación posterior de cadera

Respuesta Correcta: D

537. En una fractura-luxación de tobillo será urgente:

- A) Reducir la fractura
- B) Reducir la luxación
- C) Colocar una inmovilización
- D) Instaurar analgesia

Respuesta Correcta: B

538. El tratamiento inicial de la fractura del anillo pelviano no conlleva:

- A) Soporte hemodinámico
- B) Soporte ventilatorio





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) Sondaje vesical
- D) Estabilización pelviana

Respuesta Correcta: C

539. Para minimizar el síndrome de aplastamiento es fundamental:

- A) Liberación rápida de la extremidad aplastada
- B) Aplicación previa a la extracción de torniquete
- C) Administración precoz de volumen
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: C

540. Sobre los traumatismos de rodilla, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) En traumatismos directos de rodilla la rótula se fractura en varios segmentos.
- B) La exploración física es fundamental en el diagnóstico de las lesiones ligamentosas de rodilla.
- C) La rotura de ligamentos laterales es causa frecuente de hemartros.
- D) La fractura diafisaria de fémur precisa vigilancia hemodinámica.

Respuesta Correcta: C

541. Acerca de la fractura del 5º metatarsiano, señale la afirmación correcta:

- A) Suelen ser por traumatismo directo
- B) La fractura de Jones se produce por avulsión
- C) Se puede confundir con un núcleo de osificación
- D) Es intraarticular y de trazo horizontal

Respuesta Correcta: C

542. En relación al traumatismo pélvico en el paciente politraumatizado, señale el enunciado FALSO:

- A) Las fracturas pélvicas son la cuarta causa de mortalidad en los accidentes de tráfico tras las lesiones del SNC, tórax y del abdomen.





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Habitualmente, las fracturas de pelvis suelen ir asociadas a lesiones de otros órganos con una prevalencia del 11-20%
- C) De estas lesiones pélvicas, más del 50% llegan a los Servicios de Urgencias con tensiones sistólicas menores de 90 y una tercera parte necesitan transfusión de sangre
- D) Las fracturas abiertas de pelvis presentan tasas de mortalidad entre el 30-50%

Respuesta Correcta: A

543. La reducción de una luxación de rotula precisa una maniobra de:

- A) Extensión de la rodilla
- B) Flexión de la rodilla
- C) Rotación externa de la rodilla
- D) Rotación interna de la rodilla

Respuesta Correcta: C

544. Según las reglas de Ottawa, esta indica la radiografía de rodilla ante un traumatismo en la misma en caso de:

- A) Paciente >55 años
- B) Dolor a la palpación en la cabeza del peroné
- C) Imposibilidad de flexionar 90° la rodilla
- D) En todos los casos anteriores

Respuesta Correcta: D

545. Ante un paciente traumatizado grave en situación de shock, el origen más probable del mismo es:

- A) Anafiláctico
- B) Séptico
- C) Cardiogénico
- D) Hipovolémico

Respuesta Correcta: D





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

546. Señale lo correcto respecto a la Triada de Beck:

- A) Incluye ingurgitación yugular, taquicardia y desviación traqueal, y se presenta en el paciente con taponamiento cardíaco.
- B) Es una triada característica del shock hipovolémico
- C) Se presenta en el shock medular
- D) Incluye ingurgitación yugular, taquicardia y ruidos cardíacos apagados o ausentes, y se presenta en el paciente con taponamiento cardíaco.....

Respuesta Correcta: D

547. En relación a la valoración del traumatismo abdominal cerrado en el paciente politraumatizado, señale la Respuesta Correcta:

- A) La exploración física es suficientemente fiable para decidir si hay una lesión abdominal.
- B) La TAC abdominal es la exploración de imagen a realizar siempre en el paciente hemodinamicamente inestable
- C) La ecografía abdominal es la exploración de imagen a realizar inicialmente en el, paciente inestable
- D) La ecografía abdominal tiene mayor predicción diagnóstica que la TAC

Respuesta Correcta: C

548. Señale cuál de las siguientes situaciones indicaría una punción-lavado peritoneal:

- A) Cuando exista calar indicación de laparotomía
- B) Siempre que el paciente inicialmente presente hipotensión.
- C) Exploración abdominal no fiable por intoxicación etílica de un paciente que presenta hipotensión arterial inexplicable
- D) Herida por arma de fuego que penetre peritoneo.

Respuesta Correcta: C

549. Según la clasificación de Tile de la fractura de pelvis, ¿a qué tipo corresponde una fractura inestable rotacional y verticalmente?

- A) Tipo A





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- B) Tipo B1
- C) Tipo B2
- D) Tipo C

Respuesta Correcta: D

550. Señale lo correcto respecto al Volet costal:

- A) Se manifiesta por movimiento paradójico de la pared costal (retracción de los espacios intercostales a la inspiración)
- B) Es la fractura de una costilla por al menos dos sitios
- C) Nunca ocasiona hipoxemia
- D) El tratamiento es el vendaje de la caja torácica para evitar movilidad del torax

Respuesta Correcta: A

551. Señale lo correcto en relación al neumotorax abierto:

- A) Se produce por una apertura en tórax de al menos 1 tercio del diámetro de la traquea
- B) El orificio/herida torácica debe cubrirse con un apósito oclusivo
- C) No existen dispositivos comerciales para el sellado de la herida torácica
- D) El drenaje pleural definitivo debe colocarse lo más alejado posible de la herida en el hemitorax afecto

Respuesta Correcta: D

552. Señale cuál de lo siguiente NO es propio de un neumotorax a tensión en un paciente víctima de un traumatismo:

- A) Disnea
- B) Hipertensión arterial
- C) Timpanismo a la percusión
- D) Taquicardia

Respuesta Correcta: B

553. Señale en cuál de las siguientes circunstancias la exploración física del





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

abdomen del paciente con traumatismo abdominal no es fiable:

- A) Shock
- B) Intoxicación aguda
- C) Lesión medular
- D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

554. Señale cuál de los siguientes es síntoma/signo de lesión traumática aguda de la aorta torácica:

- A) Soplo sistólico precordial
- B) Disfonia
- C) Hipertensión arterial solo en miembro superior derecho
- D) Todas las opciones son correctas

Respuesta Correcta: D

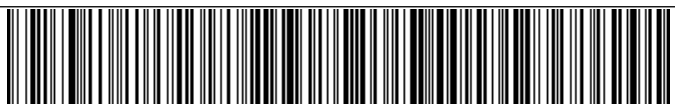
555. ¿Cuáles son los factores hemodinámicos a considerar en una mujer embarazada que ha sufrido un traumatismo?

- A) Gasto cardíaco
- B) Frecuencia cardíaca
- C) Presión arterial
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

556.Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al traumatismo abdominal en la mujer embarazada:

- A) La pared abdominal, el miometrio y el líquido amniótico actúan como amortiguadores de las lesiones directas.
- B) Es necesario realizar una reposición vigorosa de líquidos para corregir y prevenir el shock hipovolémico
- C) Una mínima hemorragia materno fetal es capaz de sensibilizar a la madre con factor Rh negativo





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

557. Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación a la mujer embarazada víctima de un accidente:

- A) El útero debe de ser desplazado manualmente hacia la izquierda para aliviar la presión en la vena cava
- B) La pérdida sanguínea en las mujeres embarazadas puede ser elevada antes de dar señales físicas de hipovolemia.
- C) La monitorización fetal continua es obligatoria en cualquier trimestre del embarazo
- D) El feto puede estar en peligro a pesar de que exista una lesión aparentemente mínima en la madre

Respuesta Correcta: C

558. De los siguientes cambios fisiológicos en la mujer embarazada ¿Cuál de ellos no aparece nunca?

- A) Incremento del gasto cardíaco
- B) Disminución frecuencia cardíaca
- C) Cambios en el eje cardíaco en el EKG
- D) La hipocapnia es común dado el aumento del volumen corriente

Respuesta Correcta: B

559. De las siguientes afirmaciones indique la CORRECTA:

- A) La eclampsia puede aparentar un traumatismo craneoencefálico
- B) Una PaCO₂ normal en el contexto de un politraumatismo puede ser signo de una insuficiencia respiratoria
- C) Es necesario hacer una revisión fetal aunque no haya lesiones graves en la madre
- D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

560. En la embarazada que ha sufrido un traumatismo, hay que investigar las patologías particulares de su estado, ¿cuál de las siguientes no es una de ellas?

- A) Desprendimiento de placenta
- B) Embolismo de líquido amniótico
- C) Rotura prematura de membranas
- D) Todas deben de investigarse

Respuesta Correcta: D

561. En relación al ABCDE en la mujer embarazada señale la afirmación incorrecta:

- A) Si fuera necesario aislar la vía aérea no es necesario tener en consideración ningún parámetro gasométrico a la hora de una correcta ventilación y oxigenación
- B) La monitorización materna debe de incluir, determinación de gases en sangre
- C) Es normal encontrarnos con niveles ligeramente bajos de bicarbonato como compensación de la alcalosis respiratoria
- D) Se debe de realizar una monitorización continua fetal a partir de las 20 semanas de gestación

Respuesta Correcta: A

562. Respecto al trauma en el embarazo, señale la afirmación INCORRECTA:

- A) El mejor tratamiento inicial para el feto es una reanimación óptima de la madre
- B) Las prioridades del tratamiento inicial de la paciente embarazada son las mismas que para la paciente no embarazada
- C) No es necesario contar con un obstetra cualificado para el tratamiento de la paciente embarazada que ha sufrido un traumatismo grave
- D) Si durante el manejo crítico de estas pacientes está indicado el uso de rayos X no se debe evitar debido al embarazo

Respuesta Correcta: C

563. Con respecto a la revisión secundaria de una embarazada que ha sufrido un traumatismo, señale la afirmación INCORRECTA:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Debe de seguir el mismo patrón que la mujer no embarazada
- B) Las indicaciones para realizar una ECO FAST, TAC abdominal y un lavado peritoneal difieren de las aplicables a la mujer no embarazada
- C) Es de vital importancia realizar un tacto vaginal si existe hemorragia vaginal para valorar probables desprendimientos de placenta
- D) La presencia de liquido amniótico, valorado por pH 7 a 7,5 sugiere rotura de membranas

Respuesta Correcta: B

564. De las siguientes afirmaciones respecto al trauma pediátrico señale la INCORRECTA:

- A) La apnea, la hipoventilación y la hipoxia se presenta con una mayor frecuencia cinco veces mayor que la hipovolemia con hipotensión.
- B) Hay que poner mayor énfasis en el manejo agresivo de la vía aérea y de la ventilación
- C) Las fracturas costales son raras en los niños, pero la contusión pulmonar es frecuente.
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

565. El uso de las radiaciones ionizantes en el trauma pediátrico deberían de utilizarse en las siguientes circunstancias:

- A) No existe problema en su uso en la población pediátrica
- B) No se ha demostrado que su uso se relacione con mayor riesgo de algunas enfermedades malignas
- C) Se justifica su uso si la información obtenida va a cambiar el manejo clínico del paciente
- D) En caso de usarse han de ser con la radiación habitual

Respuesta Correcta: C

566. En el trauma pediátrico:





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) La falta de oxigenación y ventilación, son las causas las frecuentes de paro cardíaco en el niño.
- B) Para preservar la alineación neutral de la columna vertebral, se coloca un soporte de 2,5cm debajo de la totalidad del torso (hasta los 3 años)
- C) El primer objetivo es establecer una vía aérea permeable
- D) Todas son ciertas

Respuesta Correcta: D

567. Con respecto al manejo de la vía aérea en el paciente pediátrico, señale la correcta:

- A) No difiere en absoluto del manejo de la vía aérea en el adulto.
- B) Se debe de realizar una preoxigenación antes de cualquier intento para establecer una vía aérea
- C) La colocación de una cánula orofaríngea se realiza como en el paciente adulto.
- D) Los tubos endotraqueales no difieren de los usados en población adulta.

Respuesta Correcta: B

568. A la hora de aislar la vía aérea en el paciente pediátrico cuál de las siguientes es la correcta:

- A) En los niños es mandatorio la premedicación con atropina
- B) Las dosis de fármacos hipnóticos y miorelajantes van ajustadas a la edad
- C) El niño que requiera de intubación oro o nasotraqueal, ha de ser preoxigenado
- D) Todas son falsas

Respuesta Correcta: C

569. En ahogamiento con aspiración por liquido dulce se produce:

- A) Hipervolemia y hemodilución
- B) Hipovolemia y hemoconcentración
- C) Hipovolemia e hemodilución
- D) Todas son falsas

Respuesta Correcta: A





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

570. En un accidente de tráfico en el que se ve involucrado un niño en situación de PCR, las maniobras de SVA deben de comenzar por:

- A) Compresiones torácicas
- B) Apertura vía aérea y cinco ventilaciones iniciales de rescate
- C) Monitorización del niño in situ
- D) Conectar desfibrilador como primera medida

Respuesta Correcta: B

571. Al plantear la intubación traqueal en niños, señale cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- A) La laringe es más corta, alta y en posición anterior respecto del adulto
- B) La epiglotis es más corta que en el adulto
- C) El máximo estrechamiento se produce a nivel del cricoides
- D) Hasta la pubertad se aconseja utilizar tubos sin balón.

Respuesta Correcta: C

572. En una bradicardia en un niño politraumatizado lo indicado en primer lugar sería:

- A) Administración de oxígeno al 100%
- B) Masaje cardíaco y adrenalina
- C) Atropina IV
- D) Marcapasos externo

Respuesta Correcta: A

573. En los niños mayores de 5 años de edad, el lugar de acceso intraóseo más recomendable sería:

- A) Porción distal de la tibia
- B) Porción proximal de la tibia
- C) Porción distal del fémur
- D) Porción proximal del fémur





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: B

574. ¿Cuál es el sistema de monitorización que ofrece la información más precoz de que un paciente se ha extubado accidentalmente?

- A) EKG
- B) Pletismografía
- C) Pulsiosimetría
- D) Capnografía

Respuesta Correcta: D

575. Entre los efectos de la administración de presión positiva en la vía aérea se encuentra:

- A) Disminución presión intracraneal
- B) Disminución de la producción de péptido natriurético (BNP)
- C) Aumento precarga ventricular
- D) Aumento perfusión coronaria

Respuesta Correcta: B

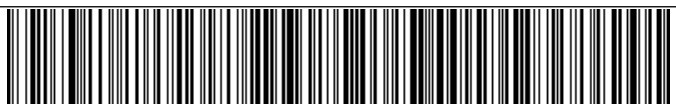
576. La dosis inicial recomendada de rocuronio para intubación orotraqueal es de :

- A) 0,15mg/Kg
- B) 0,20mg/Kg
- C) 0,30mg/Kg
- D) 0,6mg/Kg

Respuesta Correcta: D

577. ¿Cuál de estos fármacos no puede usarse en personas alérgicas al huevo?:

- A) Propofol
- B) Ketamina
- C) Cisatracurio
- D) Todos ellos





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: A

578. La ventilación asistida-controlada, señale la respuesta ERRONEA:

- A) Evita la asincronia respiratoria
- B) Puede empeorar el atrapamiento aéreo
- C) Se puede aplicar con control de volumen o presión
- D) Permite al paciente varias la frecuencia respiratoria pero no el tipo de ventilación

Respuesta Correcta: A

579. ¿Cuál de las siguientes se considera que la administración de la ventilación mecánica no invasiva es exitosa o cumple sus objetivos terapéuticos?

- A) Ausencia de disnea
- B) Frecuencia respiratoria del paciente >25rpm
- C) pH menor de 7,35
- D) Mantenimiento de una Saturación de oxígeno entre el 75-80%

Respuesta Correcta: A

580. El propofol:

- A) Está especialmente indicado para la sedación de pacientes hemodinamicamente inestables
- B) Puede usarse en asmáticos
- C) La dosis de inducción es de 5mg
- D) Es seguro en el embarazo

Respuesta Correcta: B

581. Señale cuál de los siguientes no es un dispositivo supraglótico:

- A) Mascarilla laríngea
- B) Combitube
- C) Mascarilla I-gel
- D) Bujía de Boussignac





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: D

582. Respecto a la ventilación mecánica no invasiva, señale la afirmación CORRECTA:

- A) Este tipo de ventilación es una modalidad de apoyo a la ventilación espontánea del paciente
- B) Permite que el paciente pueda toser de forma espontánea, eliminando sus secreciones
- C) Disminuye la aparición de complicaciones asociadas a la ventilación mecánica
- D) Todas son correctas

Respuesta Correcta: D

583. ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio para definir al paciente geriátrico?

- A) Edad mayor de 75 años
- B) Pluripatológico
- C) Ausencia de patología mental
- D) La enfermedad principal es incapacitante

Respuesta Correcta: C

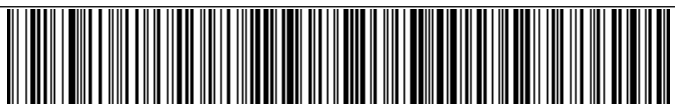
584. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de la valoración geriátrica integral?

- A) Descubrir problemas tratables no diagnosticados
- B) Mejorar la calidad de vida
- C) Establecer un diagnóstico sindrómico del paciente
- D) Establecer el tratamiento adecuado

Respuesta Correcta: C

585. ¿Cuál de las siguientes interacciones de fármacos en el anciano provoca como efecto secundario un incremento de las caídas?

- A) Antihipertensivo y AINES
- B) Diurético ahorrador de potasio e IECA





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- C) Diureticos de ASA y Digoxina
- D) Antihipertensivo vasodilatador y neurolépticos

Respuesta Correcta: D

586. ¿Cuál de los siguientes fármacos se relaciona con la aparición de síntomas depresivos en el anciano?

- A) Corticoides
- B) Benzodiacepinas
- C) Neurolépticos
- D) Antidepresivos

Respuesta Correcta: A

587. ¿Cuál de las siguientes NO es una medida para el tratamiento del síndrome confusional agudo?

- A) Cuidados del hábito intestinal
- B) Control analgésico optimo con opiáceos
- C) Evitar cambios de habitación
- D) Minimizar los cambios de personal responsable de la atención

Respuesta Correcta: B

588. ¿Cuál es la forma de manifestación más habitual en el anciano de una reacción adversa a medicamentos?

- A) Erupción cutánea
- B) Delirio
- C) Deterioro cognitivo
- D) Inestabilidad

Respuesta Correcta: A

589. Los ancianos son mas susceptibles para sufrir un golpe de calor, si están tomando determinados medicamentos. Señale el fármaco que NO suele estar implicado





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Diuréticos
- B) Anticolinérgicos
- C) Antagonistas de leucotrienos
- D) Antiparkinsonianos

Respuesta Correcta: C

590. ¿Cuál de los siguientes ítems NO se encuadra dentro de la valoración clínica y nutricional, dentro de la valoración geriátrica abreviada adaptada a los servicios de urgencias?

- A) Detectar probable demencia
- B) Comorbilidad
- C) Polifarmacia
- D) Malnutrición

Respuesta Correcta: A

591. ¿Cuál de los siguientes procesos NO predispone a una intoxicación digitalica en el anciano?

- A) Deshidratación
- B) Insuficiencia hepática
- C) Hipopotasemia
- D) Insuficiencia renal

Respuesta Correcta: B

592. Desde el Servicio de Urgencias se puede iniciar un enfoque paliativo de los pacientes. ¿En cuál de los casos descritos a continuación NO estaría indicado?

- A) Insuficiencia cardíaca NYHA IV con FEVI <30% y 3 ingresos en último año por síntomas secundarios a la misma
- B) EPOC con disnea de reposo FEV1 <30% y 3 ingresos en los últimos 6 meses por descompensación
- C) Insuficiencia renal crónica grave (FG<15), candidato a trasplante
- D) Cirrosis hepática avanzada (Child C) con ascitis refractaria





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

Respuesta Correcta: C

593. En las fases finales del paciente paliativo, en ocasiones se originan abundantes ruidos asociados a los movimientos respiratorios producidos por la oscilación de las secreciones acumuladas (estertores premortem). Con frecuencia causan gran angustia en los familiares. Todas las siguientes, menos una, son medidas para paliarlos.

- A) Poner en decúbito lateral, si es posible, con la cabeza elevada
- B) Disminuir la hidratación
- C) Butilescopolamina 20-40mg/8 horas vía subcutánea
- D) Baclofeno 5mg/8 horas vía subcutánea

Respuesta Correcta: D

594. ¿Cuál de los siguientes fármacos administraría para el tratamiento de los espasmos musculares?

- A) Fluoxetina
- B) Metilprednisolona
- C) Midazolam
- D) Baclofeno

Respuesta Correcta: D

595. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO está indicado para el tratamiento del dolor neuropático?

- A) Amitriptilina
- B) Carbamazepina
- C) Dexametasona
- D) Pregabalina

Respuesta Correcta: C

596. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO es un opiáceo mayor?





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

- A) Oxicodona
- B) Tramadol
- C) Tapentadol
- D) Fentanilo

Respuesta Correcta: B

597. ¿Cuál es la vía de elección para la administración de medicación en el dolor oncológico?

- A) Oral
- B) Subcutánea
- C) Intramuscular
- D) Intravenosa

Respuesta Correcta: A

598. ¿En qué escalón de la escalera analgésica se administra la medicación coadyuvante en el tratamiento del dolor oncológico?

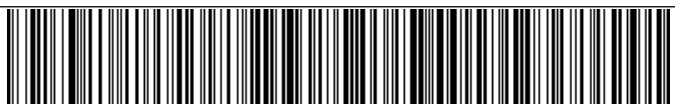
- A) Primer escalón
- B) Segundo escalón
- C) Tercer escalón
- D) En cualquier escalón

Respuesta Correcta: D

599. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO se utiliza en el primer escalón de la escalera analgésica en el dolor oncológico?

- A) Metamizol magnésico
- B) Salicilatos
- C) Naproxeno
- D) Codeína

Respuesta Correcta: D





Listado de preguntas definitivo

Convocatoria: PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN 2022 – GRUPO A/A1 SANITARIO

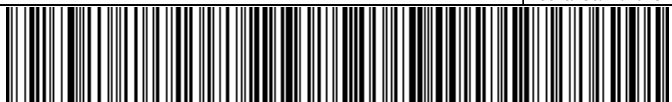
Categoría: MÉDICA/O DE URGENCIA HOSPITALARIA

Nº de preguntas de reserva: 0

600. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo del tratamiento del dolor oncológico?

- A) Mantener al paciente sin dolor el mayor tiempo posible
- B) Asegurar el descanso diurno
- C) Prevenir el dolor mejor que disminuirlo
- D) Utilizar fármacos adecuados con los menores efectos secundarios

Respuesta Correcta: B

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MARIA GLADIS PAJES ABREU - JEFE DE SECCION	Fecha: 30/11/2023 - 09:28:56
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0lo_n_Hf1nGk-YziI0TnDmpsQIK5dfheZ puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:	 
El presente documento ha sido descargado el 30/11/2023 - 12:47:44	